



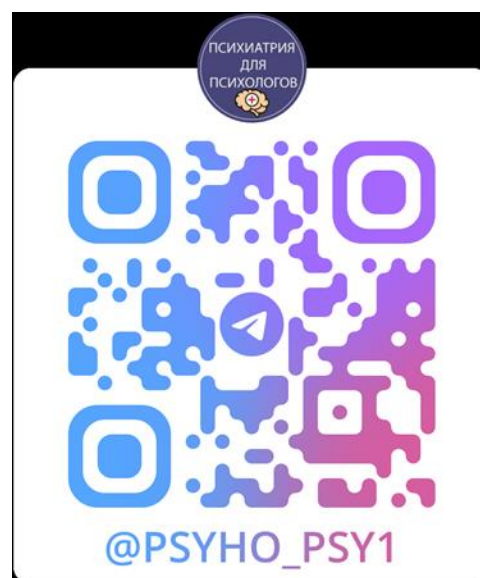
МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Когнитивно-поведенческая терапия РДВГ

Психиатрия для психологов



КПТ СДВГ



Карпова Мария, врач-психиатр ЕВМ, психотерапевт СВТ, DBT, специалист по нейроразличиям у взрослых и подростков.

Автор и спикер образовательных программ для психологов.

Образовательный проект **Психиатрия для психологов**



КПТ СДВГ

Протокол Янг-Брэмэм

Разработан Сьюзан Янг и Джессикой Брэмэм.

Сьюзан Янг, бакалавр наук, DClinPsy, PhD, CSi, AFBPS, является директором Psychology Services Limited и почетным профессором Университета Рекьявик.

Джессика Брэмэм — академический клинический нейропсихолог. Она имеет степень бакалавра естественных наук Кембриджского университета, степень доктора клинической психологии и доктора нейропсихологии Института психиатрии Королевского колледжа Лондона.



КПТ СДВГ

Наше понимание того, как клиенты с РДВГ становятся лучше, часто подвержено когнитивным искажениям. В частности, прогресс может восприниматься как **чёрно-белый процесс**: либо «всё плохо», либо «полная ремиссия». Но на деле улучшение при РДВГ гораздо **более тонкий и многоступенчатый процесс**.

Улучшение состояния – это не гонка. Для подавляющего большинства клиентов **улучшение проявляется в развитии мастерства**, а не в полном исчезновении симптомов. Становление лучше — это не гонка с финишной чертой, где важно, насколько быстро человек меняется.



КПТ СДВГ

В долгосрочной перспективе важнее:

- насколько устойчивыми будут изменения.
- насколько клиент научится **адаптироваться к трудностям**, а не избегать их.

Изменения происходят **постепенно**, через время, настойчивость, творческий подход, жизнестойкость и саморефлексию. Эти качества — основа действительно глубоких и устойчивых изменений.



КПТ СДВГ

Современные исследования РДВГ помогли нам **отойти от моральной интерпретации** («он просто ленивый») и перейти к **научному пониманию**: нарушение исполнительных функций, трудности с торможением импульсов, нестабильная рабочая память.

Теперь мы понимаем, что:

- человек не может «просто взять себя в руки»;
- многие трудности носят **нейропсихологический характер**, и это требует новых подходов к поддержке и терапевтическому взаимодействию.



КПТ СДВГ

В терапии РДВГ важно понимать, что **внутренние симптомы (эмоции, мышление) и внешние симптомы (действия, поведение)** тесно связаны.

Когда человек с СДВГ сталкивается с необходимостью выполнить важную, но сложную задачу (например, написать работу, сдать налоговую декларацию, сдать экзамен, прибраться дома), он часто:

- **испытывает тревогу и чувство никчемности.**
- **вспоминает прошлые неудачи и обесценивает себя.**

Из-за этого может формироваться **порочный круг избегания и самокритики**, в котором ухудшается мотивация и снижается функциональность.



КПТ СДВГ

Традиционно при РДВГ основной акцент делается на **симптомах** (невнимательность, гиперактивность, импульсивность). Но **оценка симптомов — это только вход в понимание**, а не само решение.

Настоящая цель терапии — **улучшение функционирования**:

- в повседневной жизни.
- в отношениях.
- в самоорганизации и управлении собой.

Важно ориентироваться не на то, сколько симптомов осталось, а на то, **в каких сферах клиент испытывает реальные трудности**, и что мешает ему жить лучше.



Наиболее эффективной считается **модульная структура терапии**, где внимание уделяется конкретным навыкам и трудностям.

Например:

- управление временем и прокрастинацией.
- эмоциональная регуляция и гнев.
- межличностные проблемы и конфликты.

Эти модули:

- решают конкретные задачи.
- обучают практическим навыкам.
- дают основу для переноса изменений в другие области жизни.

Навыки, развиваемые в одном модуле, **носят кумулятивный характер**: если клиент научился планировать дела, он сможет позже применять этот же навык и в отношениях, и в учёбе, и в уходе за собой.



КПТ СДВГ

РДВГ - гетерогенное расстройство, у каждого человека оно будет проявляться по-своему, охватывая целый ряд психологических преимуществ и проблем.

Хотя диагностика СДВГ основывается на категориальной перспективе, многие из основных проблем, связанных с вниманием и импульсивностью, постоянно распространяются среди нормальной популяции.

Таким образом, **есть много людей с проблемами внимания, импульсивности и гиперактивности**, которые не попадают в порог для постановки официального диагноза, но которые, тем не менее, могут также извлечь пользу из лечения своих функциональных нарушений.



Как РДВГ влияет на опыт взрослого человека

1. Нейропсихологические особенности и их последствия

Взрослые с СДВГ сталкиваются с длительными нейропсихологическими трудностями, такими как:

- снижение концентрации внимания.
- забывчивость.
- трудности в решении проблем.
- стремление к немедленному удовлетворению.

Эти особенности могут **существенно** влиять на качество жизни, снижая эффективность в повседневных задачах и социальных взаимодействиях.



2. Последствия в разных сферах функционирования

Из-за этих трудностей люди с РДВГ часто сталкиваются с негативным жизненным опытом, включая:

- проблемы в учебе и профессиональной деятельности.
- трудности в установлении и поддержании дружеских и интимных отношений.
- стремление к поиску новизны и участие в рискованном поведении.



КПТ СДВГ

3. Уязвимость в значимых ситуациях

При столкновении с эмоционально или социально нагруженными задачами — например, на собеседованиях, в конфликтных ситуациях или на важных встречах — симптомы РДВГ могут **снижать работоспособность** и мешать эффективному взаимодействию.



4. Формирование негативной самооценки

Накопленный опыт неудач приводит к тому, что человек начинает:

- **негативно оценивать себя и свои способности.**
- **ожидать неудачи в будущем (эффект самоисполняющегося пророчества).**
- **сомневаться в своей компетентности.**

Это способствует формированию **низкой самооценки** и **уязвимости к стрессу**.



5. Реакции на стресс: поведение и мышление

После негативной оценки ситуации возможны две основные поведенческие реакции:

- **Негативное поведение** (вербальная агрессия, физическая агрессия).
- **Избегающее поведение** (социальная изоляция, злоупотребление ПАВ, пассивность).

Параллельно формируются **устойчивые негативные убеждения** и мысли: «я слабый», «у меня не получится», «я все всегда порчу».



6. Эмоциональные последствия и замкнутый цикл

Такое сочетание поведения и мышления вызывает или усиливает **негативные эмоциональные состояния**, такие как:

- тревога
- фрустрация
- гнев
- уныние

Чем хуже настроение, тем более негативной кажется следующая ситуация, что **поддерживает замкнутый цикл**:



КПТ СДВГ





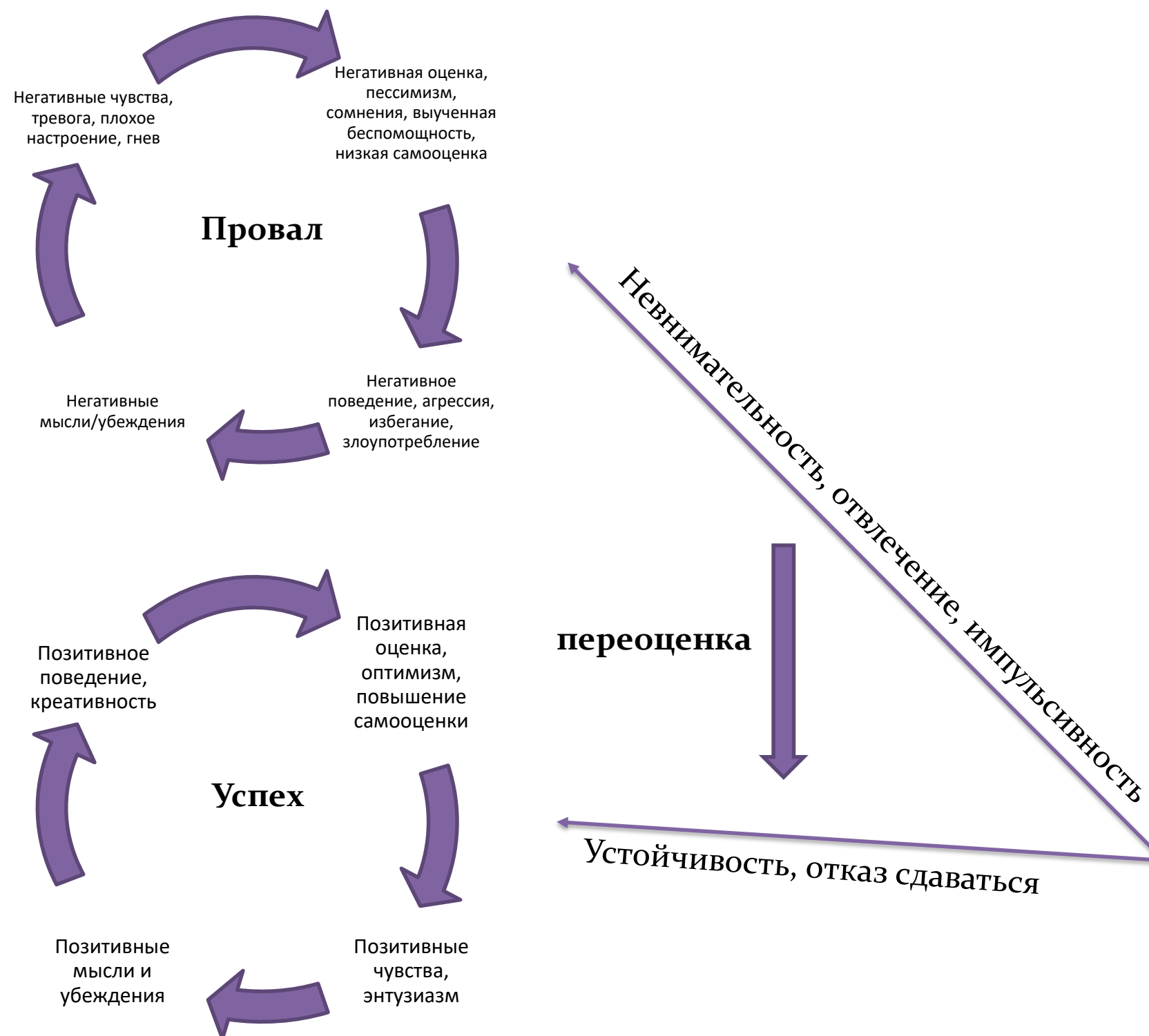
7. Возможность выхода:

Несмотря на этот цикл, у взрослых с РДВГ **сохраняется способность к переоценке и когнитивному переосмыслению стрессовых ситуаций.**

Это означает, что в рамках терапии и поддержки возможно:

- обучение навыкам эмоциональной регуляции
- развитие адаптивных способов совладания
- формирование более реалистичных и поддерживающих установок

Когнитивно-поведенческая модель взрослых с РДВГ



Нейропсихологический дефицит

- Плохая концентрация внимания
 - Дезорганизация
 - Забывчивость
- Трудности с решением проблем
 - Плохое торможение реакции
 - Проблемы с саморегуляцией
- Потребность в немедленном удовлетворении
 - Непринятие задержки

Жизненные события/опыт

- Проблемы с образованием
 - Проблемы с работой
- Проблемы в отношениях
- Социальное отвержение
- Рискованное поведение

Ситуация/задача/стимул

- Конфронтация
 - Экзамен
 - Интервью
 - ...



КПТ СДВГ

В то время как взрослые с РДВГ могут участвовать в спонтанном процессе переоценки, они также подвергаются негативному влиянию своих когнитивных искажений, что приведет к дисфункциональности или неуспешности процесса.

Тем не менее, человек с РДВГ может вновь вступать в цикл позитивного переосмысления негативного результата, заставляя повторить попытку в надежде достичь успеха. Это объясняет жизнестойкость, обычно встречающуюся у людей с РДВГ, и предполагает, что в основе этого лежит вера в самоэффективность.

Следовательно, то, как они взаимодействуют, связано с их способностью постоянно компенсировать и адаптироваться. Этот адаптивный аспект расстройства также может быть выражен в виде творческих и предприимчивых личностных характеристик.



КПТ СДВГ

В психотерапии РДВГ есть 2 цели:

1. **Изменения снаружи внутри** (from the outside in) - терапевт помогает побудить человека с СДВГ изменить свое окружение и оптимизировать функционирование.
2. **Изменение наружу изнутри** (from the inside out) - найти способы поощрения человека к разработке психологических стратегий адаптивного функционирования.

Волшебного лекарства от РДВГ, к сожалению, нет, но можно изменить то, как человек справляется с расстройством и максимально использовать его сильные стороны.



КПТ СДВГ

Содержание программы

1. Психообразование
2. Глубинные симптомы
 - Проблемы с вниманием и памятью
 - Тайм-менеджмент
 - Решение проблем
 - Гиперактивность/импульсивность
3. Коморбидные состояния/ассоциированные проблемы
 - Межличностные проблемы
 - Тревожность
 - Разочарование/гнев
 - Депрессия
 - Нарушение сна
 - Злоупотребление ПАВ
4. Подготовка к будущему



Исследование доктора Янг выделило 3 темы для работы с клиентом с СДВГ:

- 1. Пересмотр прошлого:** ощущение отличия от других. Клиенты могут чувствовать себя непохожими на своих сверстников и семью. Их нелестно сравнивали и продолжают сравнивать с братьями и сестрами и часто говорили, что они глупые, ленивые или невоспитанные. Для некоторых людей это привело к тому, что они усвоили негативную обратную связь, которая в свою очередь пагубно сказалась на их самооценке.

Однако другие люди описывали свою относительную устойчивость к критике со стороны других. Отчасти это могло быть связано с защитной ролью их невнимательности и импульсивности, которые мешали им размышлять о своих трудностях. Они описывали отсутствие способности зацикливаться на проблеме достаточно долго, чтобы она стала тревожной или проблематичной.



2. **Эмоциональное воздействие диагноза:** получив диагноз РДВГ, клиенты часто испытывают чувство **облегчения** и приподнятого настроения от того, что их трудностям нашлось объяснение. За этим быстро следует **замешательство**, поскольку они пытаются осмыслить прошлый опыт в свете поставленного диагноза. Они начинают задумываться о том, как их жизнь могла бы быть более успешной, если бы у них было диагностировано это расстройство и они получили лечение раньше. Например, они, возможно, смогли добиться академических успехов. Будет также **гнев** по поводу того, что им не оказывали надлежащей поддержки в детстве и отрочестве. Тогда клиенты чувствуют себя особенно **опечаленными** и сожалеющими о том, что они привыкли ожидать от себя неудач и недостаточных достижений. Затем наблюдается период **адаптации**, в течение которого они осознают, что у них пожизненное хроническое расстройство, и это вызывает некоторую тревогу. Однако на заключительных этапах адаптации люди приходят к согласию с диагнозом и необходимостью принимать лекарства и проходить психотерапию.

3. **Размышления о будущем:** клиенты могут признать, что медикаментозное лечение улучшило их мотивацию и способность функционировать в повседневной жизни, особенно в том, что касается межличностных отношений. Однако они осознают, что все их трудности не исчезают при медикаментозном лечении и что определенные проблемы требуют от них внесения изменений в свое поведение. Некоторые люди могут быть обеспокоены тем, что другие подумают, что они используют РДВГ в качестве оправдания всех своих трудностей, и, следовательно, им было полезно понять что было связано с расстройством, а что нет. Также могут быть опасения по поводу стигматизации, связанной с РДВГ, и это может влиять на раскрытие ими диагноза другим.



Эти результаты определяют роль психологического лечения в трех областях:

- Во-первых, необходимо помочь клиентам пройти через процесс адаптации и осмыслить прошлое.
- Во-вторых, чтобы уменьшить беспокойство по поводу будущего, терапевтам нужно подчеркивать сильные стороны и положительные характеристики клиента, которые помогут ему внести изменения в будущем.
- В-третьих, существует потребность в развитии навыков, особенно в областях, которые не улучшаются непосредственно лекарствами, чтобы клиент мог функционировать более успешно.



КПТ СДВГ

Цели и задачи терапии

1. Психообразование – предоставление информации о РДВГ.
2. Разработка психологических стратегий для преодоления симптомов и связанных с ними проблем.
3. Если реализация протокола осуществляется в групповом формате, то третьей целью является столкновение взрослых с СДВГ с другими людьми с аналогичными трудностями и переживаниями.



КПТ СДВГ

Этот протокол основан на КПТ, психообразовании и мотивационном интервьюировании. Он предназначен для того, чтобы дать человеку возможность развить самоэффективность и уверенность в том, что перемен можно достичь, разработав стратегии для позитивного изменения образа жизни и преодоления трудностей.

Протокол включает информирование о расстройстве; внедрение психолого-педагогических методик; преодоление амбивалентности, опирающееся на мотивационное интервью; баланс в принятии решений; когнитивную реструктуризацию; переосмысление прошлого опыта через борьбу с автоматическими мыслями; самоконтроль эффективности; распознавание ошибок в мышлении и оценку когнитивных искажений.

По возможности также важно выявить глубинные убеждения, которых придерживается клиент в отношении себя, других людей и окружающего мира.



Терапевтический альянс и комплаенс

Центральным принципом терапевтической программы является **сотрудничество**. Жизненно важно вовлекать и мотивировать человека, совместно определяя повестку дня и цели терапии. Важно, чтобы клиент доверял терапевту и чувствовал, что терапевт понимает его проблемы и прогноз расстройства.

К зрелому возрасту люди с РДВГ часто сталкиваются с различными службами образования и охраны психического здоровья. Однако диагноз РДВГ часто не ставился или человеку могла быть предоставлена противоречивая информация. Люди, которым впервые поставили диагноз в зрелом возрасте, могут не доверять специалистам и чувствовать, что с ними несправедливо обошлись в системе, которая не смогла выявить их проблемы.



КПТ СДВГ

Основная функция терапевта заключается в том, чтобы посредством управляемого открытия помочь человеку построить мост между своим внутренним и внешним миром. Человек должен определить и разработать соответствующие стратегии совладания для преодоления трудных ситуаций и препятствий на пути прогресса.

Развитие успешных терапевтических отношений имеет **решающее значение** независимо от способа лечения. Это важно на ранних этапах терапии, особенно если оно происходит в то время, когда клиент приспосабливается к своему диагнозу.



Влияние диагноза

Лечение взрослых начинается с момента постановки им диагноза. После постановки диагноза, как правило, клиент проходит через 6 стадий:

1. Первоначальное облегчение и душевный подъем
2. Замешательство и эмоциональное потрясение
3. Гнев
4. Печаль
5. Тревога
6. Принятие



1. Облегчение и узнавание

Многие люди испытывают облегчение после постановки диагноза РДВГ. Они могут говорить: «Я всегда чувствовал, что что-то не так — и теперь понимаю, что это не моя вина».

Диагноз помогает им переосмыслить себя через объективную, нейропсихологическую перспективу.

2. Шок и эмоциональная реакция

Даже если человек давно подозревал РДВГ, услышать диагноз официально может стать шоком. После этого часто возникает потребность в эмоциональной адаптации.



3. Эмоции: сожаление, грусть, вина

Многие люди сообщают о волне чувств:

- сожаление о прошлом
- чувство вины
- грусть по поводу упущенных возможностей

Эти реакции — естественная часть процесса принятия диагноза.

4. Переосмысление прошлого

После постановки диагноза начинается внутренний диалог:

- Что в моей жизни было связано с РДВГ?
- Что можно было бы изменить, если бы я знал(а) раньше?
- Как могла бы сложиться моя судьба иначе?

Этот этап важен для интеграции нового знания о себе.

5. Изменение идентичности

После начала медикаментозной терапии некоторые клиенты говорят: «Я стал(а) более серьёзным(ой), менее хаотичным(ой) — как будто я уже не я».

Это может вызывать **внутренний конфликт**, связанный с чувством изменения «я-концепции». Важно, что терапевт может помочь клиенту понять, что он все тот же человек, просто с новыми возможностями и инструментами.

6. Роль окружения и социальной поддержки

Полезно поощрять клиентов:

- общаться с близкими, которые знают их «до» и «после»,
- напоминать себе, что изменения — это рост, а не утрата личности.



7. Образование и расширение понимания

Чем больше клиент узнаёт о своём состоянии, тем лучше он:

- понимает свои трудности и сильные стороны
- оптимизирует стратегии адаптации
- перестаёт винить себя за симптомы

Образование — ключ к принятию и саморегуляции.

8. Изучение уже существующих стратегий совладания

Важно

- Исследовать, как способы самопомощи клиент уже применяет
- Определить, что работает, а что мешает
- На этой основе строить терапевтический план



КПТ СДВГ

Таким образом, способ доведения диагноза до сведения клиента имеет решающее значение для его понимания расстройства и будущей адаптации к диагнозу.

Многие люди не усваивают много информации в первый раз. Только на повторном приеме клиенты могут осмыслить опыт постановки диагноза РДВГ, получить соответствующую информацию и задать вопросы, поэтому фактическая информация, касающаяся диагностики и лечения, должна быть предоставлена максимально понятно.



КПТ СДВГ

Психообразование: структура, цели, назначение

1. Цель психообразования

Психообразование должно начинаться с **первых этапов диагностики и терапии.**

Его основные задачи:

- распространение достоверных знаний о РДВГ
- формирование понимания диагноза и его значения
- переосмысление личного опыта клиента через призму расстройства



2. Предоставление базовой информации

Первая задача психообразования — объяснить **основы РДВГ**. Это необходимо, так как:

- у клиентов часто есть **ошибочные или стигматизирующие представления о РДВГ**
- в обществе по-прежнему преобладает **«популярная» информация**, не основанная на науке.

Терапевт должен:

- объяснить, **почему поставлен диагноз** и как клиент соответствует критериям
- описать **нейробиологическую природу расстройства**
- подчеркнуть, что это не вопрос лени или интеллекта

Полезно использовать письменные раздаточные материалы.



3. Обсуждение вариантов лечения

На этом этапе важно:

- рассказать о **медикаментозной терапии** (развеять мифы о «наркотиках» и «зомбировании»),
- объяснить значимость **психологических подходов**: КПТ, тренировки навыков, изменения среды.

До психообразования пациенты нередко воспринимают медикаменты как **единственный** способ «борьбы» с РДВГ. После — начинают осознавать **биопсихосоциальную модель**, включая:

- фармакотерапию
- психологические стратегии
- адаптацию окружения (работа, быт, график)



4. Расширение понимания симптомов

Психообразование помогает клиентам понять, что РДВГ — это не только:

- невнимательность
- гиперактивность
- импульсивность

но и:

- эмоциональная дисрегуляция
- низкая самооценка
- устойчивые неадаптивные стратегии совладания

Осознание этой широты симптомов способствует лучшему самопониманию и снижению самокритики.

5. Что должен уметь объяснить терапевт

Терапевт обязан информировать клиента о:

- этиологии (причинах) РДВГ
- прогнозе
- возможных сопутствующих расстройствах (депрессия, тревожность, СРК и др.)
- нарушениях исполнительных функций
- характере проявлений в реальной жизни (память, планирование, саморегуляция)
- риске неадаптивного поведения (например, избегание, прокрастинация, агрессия)

Важно делать это **конструктивно и с акцентом на цели терапии.**



6. Роль психообразования в восстановлении самооценки

Понимание, что трудности вызваны **нейроразвитием**, помогает клиентам:

- перестать считать себя «глупыми» или «ленивыми»
- **начать уважать свои границы** и особенности
- сформировать **реалистичные ожидания** от себя и своего прогресса

Это снижает внутреннее напряжение и улучшает мотивацию.



КПТ СДВГ



Практическое задание:

В парах объяснить друг другу, что такое СРДВГ (как будто объясняете клиенту).



КПТ СДВГ

Мотивационное интервью как часть терапии

Клиенты с РДВГ часто сталкиваются с амбивалентностью: они одновременно **хотят** изменений (лучше организовываться, меньше опаздывать, завершать дела) и **сопротивляются** изменениям (боятся неудачи, скуки, чувства перегрузки).

КПТ предоставляет стратегии. МИ помогает **захотеть** ими воспользоваться.



КПТ СДВГ

1. МИ повышает мотивацию к изменениям

СДВГ часто сопровождается низкой самооценкой, множественным неудачным опытом, избеганием и прокрастинацией.

МИ позволяет создать пространство, где клиент чувствует уважение, автономию и безопасность, чтобы начать говорить о том, что он **реально** хочет изменить — и почему.

Пример вопроса: *«Что бы в твоей жизни стало возможным, если бы ты мог немного лучше справляться со временем?»*



2. Работа с амбивалентностью

Клиенты с РДВГ нередко говорят:

- «Я знаю, что мне это нужно, но я всё равно не делаю этого»
- «Я устал от списков. У меня уже ничего не работает»

МИ помогает **исследовать обе стороны** внутреннего конфликта без давления.

Пример техники: «Двойственное размышление» - с одной стороны ты хочешь больше контроля, с другой – опасаясь, что это будет слишком сложно. Правильно ли я тебя понимаю?



3. Укрепление терапевтического альянса

Многие взрослые с РДВГ приходят в терапию с ожиданием:

- что их будут учить, «как надо»
- что их будут стыдить за слабую дисциплину

МИ с его установкой **«сотрудничества, принятия и уважения»** разрушает этот барьер. Это критически важно на фоне возможного опыта стигматизации или недоверия к специалистам.



4. Согласование терапевтических целей

КПТ-методикам может сопротивляться тот, кто:

- не понимает цели упражнения
- не видит в нём личной ценности
- считает, что «опять не получится»

МИ позволяет выстроить **индивидуальные цели**, опираясь на ценности клиента, а не на общие «стандарты успешности».

Например, «ты говоришь, что для тебя важно быть надежным человеком для своей семьи. Как ты думаешь, может ли планирование помочь тебе в этом?»



Как КПТ и МИ могут работать вместе

Этап терапии	МИ	КПТ
Начало	Установление контакта, выявление амбивалентности, формирование внутренней мотивации	Психообразование, постановка целей
Мотивационный кризис	Уточнение сопротивления, возвращение к ценностям	Модификация целей, адаптация стратегий
Стабильная работа	Поддержка автономии, закрепление изменений	Формирование и автоматизация новых навыков
Рецидив/откат	Предотвращение самообвинения, восстановление мотивации	Анализ провалов, работа с убеждениями





КПТ СДВГ

Когнитивно-поведенческая терапия РДВГ

Взрослые с РДВГ сталкиваются с многочисленными проблемами и сложными историями. Их сильные стороны могут быть погребены под горой негативных мыслей и переживаний. Таким образом, важно определить цели лечения, это могут быть:

- Общие цели: например, мотивация к участию в лечении
- Модульные цели: например, снижение социальной тревожности
- Конкретные цели: например, выполнение домашних заданий



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ нуждаются в структуре с точки зрения личной организации, социальных границ и практической помощи, чтобы справляться с повседневными проблемами.

Они добиваются наилучших результатов в среде, в которой существуют четкие правила и ожидания поведения. Таким образом, КПТ эффективна для взрослых с РДВГ, независимо от того, применяется ли она индивидуально или в группе, поскольку она структурирована и имеет сильную доказательную базу.

КПТ делает акцент на действии как средстве реагирования на изменения, поэтому люди, которые принимают роль «пассивного получателя», вряд ли добьются успеха и могут потребовать более интенсивного МИ.



КПТ СДВГ

Существует ряд проблем при адаптации КПТ для этой группы клиентов. Они варьируются от прагматических трудностей, например, нежелания выполнять задания по «домашней работе», до общих проблем, таких как основные симптомы РДВГ.

В более общем плане когнитивно-поведенческая терапия направлена на обеспечение когнитивной реабилитации, когнитивного переосмысления прошлого, когнитивную реструктуризацию и стратегии когнитивного рассуждения, рационализацию, разработку внутренних/внешних компенсаторных стратегий, а также использование поведенческих техник.



1. Стратегии когнитивной коррекции

Стратегии когнитивной коррекции являются важным методом лечения основных симптомов РДВГ у взрослых, поскольку они могут быть использованы **для улучшения памяти, внимания и организации** в повседневной жизни. Предполагается, что они являются важным активным дополнением к другим методам психологического лечения. Умение применять стратегии, которые непосредственно устраняют и/или компенсируют основные симптомы, может помочь людям почувствовать, что они обладают большим самоконтролем, и может уменьшить чувство приобретенной беспомощности.



КПТ СДВГ

Нейропсихологическая оценка клиентов полезна для составления профиля когнитивных сильных и слабых сторон. Например, людям, страдающим дефицитом избирательного внимания, будет полезно изучить стратегии развития внимания и памяти. Научиться игнорировать внешние отвлекающие факторы и разработать методы, позволяющие оставаться сконцентрированным на задании, будет важно для людей, испытывающих трудности с поддержанием внимания. У других могут возникнуть трудности с управлением импульсами, и им потребуется помощь в этой области.



2. Когнитивный рефрейминг прошлого опыта

Взрослые с РДВГ наверняка сталкивались с неудачами во многих аспектах своей жизни. Часто им дают понять, что они глупы, ленивы и немотивированные. Совокупным эффектом этого часто является низкая самооценка и вера в то, что ситуацию никогда нельзя будет изменить.

Помогая человеку понять, что РДВГ имеет неврологическую основу и «не является дефектом характера или моральной слабостью», следует начать давать ему некоторую надежду на будущее. Как только людям впервые ставят диагноз РДВГ во взрослом возрасте, они могут проходить период адаптации, смиряясь с диагнозом и влиянием расстройства на свою жизнь. Они могут размышлять о прошлом опыте с другой точки зрения.



КПТ СДВГ

Некоторые люди могут почувствовать облегчение от того, что есть объяснение тому, как развивались события, но другие могут испытывать негодование и/или сожаление о том, что их ситуация могла быть иной.

Существует риск того, что люди могут столкнуться с депрессией, если будут размышлять о прошлых неудачах и упущенных возможностях. Терапевт должен признать наличие чувства дистресса и замешательства и привести в норму эти мысли и чувства. Затем терапевт должен попытаться выявить примеры положительных аспектов наличия расстройства и направить человека на то, чтобы извлечь уроки из прошлого и сосредоточиться на будущем конструктивным образом.

3. Когнитивная реструктуризация и стратегии рассуждения

Некоторые люди с СРДВГ креативны и без труда применяют полезные стратегии КПТ, такие как мониторинг мышления, оспаривание негативных мыслей и предположений и генерирование альтернативных когнитивных моделей.

Другие испытывают особые трудности в абстрактном мышлении. В этом случае клиентам потребуется большая поддержка и практика в освоении техник. В частности, импульсивность может препятствовать разработке стратегий рассуждения, поскольку клиенты не продумывают план действий или не развивают его последовательно.

4. Рационализация

Взрослые с РДВГ могут стать чрезмерно сосредоточенными на текущих мыслях, и, следовательно, их озабоченность может означать, что им трудно дистанцироваться от искаженных представлений, чтобы бросить вызов им и заменить их. Это может иметь место, особенно вскоре после лечения стимулирующими препаратами, когда люди (которые менее вероятно, будет отвлечены) могут быть поглощены негативными убеждениями, переосмысливая прошлое.

Важно, чтобы клиенты обучались с использованием системы «направляемого открытия», чтобы побудить их критически рассуждать, использовать логическое мышление и рационализировать убеждения.

5. Разработка внутренних и внешних компенсаторных стратегий

Учитывая, что взрослые с РДВГ будут испытывать симптомы на протяжении всей своей жизни, вполне вероятно, что у них уже будет разработан обширный репертуар компенсаторных стратегий, **как адаптивных, так и неадаптивных**. Компенсаторные стратегии могут быть разделены на те, которые:

- Требуют изменений изнутри (т.е. внутренние стратегии, такие как метод «остановись и подумай»)
- Предполагают адаптацию окружающей среды в соответствии с индивидуальными потребностями (т.е. внешние стратегии, такие как устранение потенциальных отвлекающих факторов)



Структура протокола терапии

✓ *Роль терапевта на ранних этапах терапии РДВГ*

1. Установление границ и структуры

На начальном этапе задача терапевта — **ясно обозначить правила и рамки терапии:**

- подчеркнуть, что терапия — это совместный процесс, а не система «наказаний и наград»
- предотвратить борьбу за контроль в терапевтических отношениях
- объяснить клиенту, что ответственность за участие — обоюдная

Важно помнить: у некоторых клиентов с РДВГ могут наблюдаться черты:

- перфекционизма
- вызывающего или конфронтационного поведения
- избегания и прокрастинации



2. Поведенческие и когнитивные трудности в терапии

Клиенты с РДВГ могут:

- теряться в ходе сессии, отвлекаться или не удерживать логическую нить
- перегружаться от длительного когнитивного напряжения
- испытывать трудности с соблюдением расписания и тайминга

Чтобы адаптировать терапию:

- сокращайте длительность сессии, если нужно
- включайте перерывы или меняйте формат активности
- используйте наглядные пособия, ролевые игры, письменные упражнения и чередуйте методы



КПТ СДВГ

✓ *Организация курса терапии*

3. Гибкость длительной терапии

Хотя КПТ РДВГ обычно включает 8–12 сессий, некоторым клиентам может потребоваться:

- длительная терапия
- повторное прохождение модулей
- дополнительное время на закрепление материала

Рекомендуется:

- уделять 3–4 сессии на один модуль
- не задерживаться дольше 6 сессий на одном модуле, чтобы избежать скуки
- возвращаться к сложным темам позже, после освоения более простых стратегий



4. Регулярность и устойчивый график

Для людей с РДВГ предсказуемость расписания имеет ключевое значение.

Рекомендуется:

- проводить сессии в одно и то же время, в один и тот же день
- избегать частой смены дней или времени, так как это увеличивает риск неявки



КПТ СДВГ

✓ *Управление временем и посещаемостью*

5. Опоздания и забывчивость

Терапевт должен быть готов к опозданиям, но не поощрять их продлением сессии.

Вместо этого:

- обсудить с клиентом причины опозданий
- использовать домашние задания, чтобы работать с управлением временем
- применять напоминания:
 - сообщение/звонки за день до сессии
 - будильники/напоминания в телефоне
 - сторонняя помощь (член семьи, коллега и др.)

Важно: напоминания со стороны терапевта должны постепенно прекращаться в ходе терапии, по мере развития самостоятельности.



КПТ СДВГ

✓ Структура модулей и адаптация

6. Модульность терапии

Протокол КПТ РДВГ строится как модульная система. Возможны два подхода:

- пройти все модули по порядку
- выбрать индивидуально релевантные модули, совместно с клиентом (важно для мотивации и вовлечённости)

Темы могут включать:

- тайм-менеджмент
- прокрастинацию
- эмоциональную регуляцию
- межличностные навыки и др.



7. Закрепление и повторение

Из-за дефицитов внимания и рабочей памяти:

- необходимо больше времени на повторение и практику
- важно возвращаться к сложным модулям позже, когда клиент освоит другие стратегии

Навыки в терапии накапливаются. Поэтому пересмотр сложного материала на позднем этапе может быть более успешным, чем в начале курса.



КПТ СДВГ

Групповая терапия

Данный протокол может применяться в групповом формате. Групповая работа обеспечивает нормализацию, взаимопонимание и поддержку сверстников. Это важно для снижения социальной изоляции. Групповая структура позволяет встретиться с людьми со схожими проблемами и перенять стратегии преодоления трудностей.

Кроме того, групповая терапия предоставляет возможность для приобретения и отработки ключевых навыков в благоприятной валидирующей среде.



КПТ СДВГ

Традиционно групповая терапия состоит из еженедельных встреч по 1-2 часа. Рекомендуется обеспечить частые перерывы на встречах (например, по 10 минут каждые 30 минут), а участникам раздавать подробные раздаточные материалы, содержащие упражнения для выполнения.

В группе должны использоваться методы для переключения внимания и поддержания интереса и мотивации, например, ролевые игры, работа в парах или малых группах, групповые дискуссии.



КПТ СДВГ

Повестка сессии

Повестка сессии – это метод обеспечения структуры в рамках каждой сессии, и их следует составлять совместно. Терапевт должен строго придерживаться повестки дня и не отвлекаться на «кризисы», которые могут возникать у клиента неделя за неделей.

Это послужит для клиентов образцом того, как справляться со сложными ситуациями рациональным и некатастрофизируемым образом. Например, проблема, возникшая через неделю, может быть включена в повестку следующей сессии, и к этому моменту она, возможно, уже не будет такой сложной.



Постановка целей

Терапевт должен представить концепцию модульного подхода, разъяснив клиенту, что лечение не может охватывать все проблемы сразу. Как бы клиент не хотел решить множество проблем за один неорганизованный сеанс, это бесполезно и вызовет чувство неудовлетворенности и разочарование.

В начале терапии необходимо совместно установить **четкие конкретные** цели, которые далее разбиваются на этапы. Клиенту, скорее всего, потребуется помощь в выполнении этой задачи, поскольку ему будет сложно видеть дальше одной всеобъемлющей цели, такой как «Я хочу нравиться людям», или «Я хочу добиться успеха». Цели следует регулярно пересматривать, чтобы сохранять сосредоточенность и предотвращать искушение отвлечься на что-то другое.



КПТ СДВГ

Вознаграждение

Вознаграждения важны для людей с РДВГ, поскольку им трудно откладывать вознаграждение/удовлетворение и они склонны выбирать краткосрочное вознаграждение меньшего размера, а не ждать более крупного подкрепления через время.

Эта особенность РДВГ должна быть учтена в терапии, чтобы вовлекать в лечение таким образом, чтобы клиент регулярно получал вознаграждение за достижения, в противном случае, он потеряет интерес к терапии и станет рассеянным.



КПТ СДВГ

Домашнее задание

Домашние задания даются в конце каждой сессии. Важно, чтобы клиент научился брать на себя ответственность за повторение и внедрение техник, изученных на сессиях, в прикладной обстановке. Необходимо устранять сопротивление к выполнению ДЗ, выявлять препятствия, предвидеть их и преодолевать путем планирования альтернативных стратегий.



КПТ СДВГ

Прекращение терапии

Учитывая, что РДВГ является хроническим расстройством, может быть трудно определить момент, когда следует прекратить терапию. Поэтому важно четко определить ощутимые цели на начальном этапе и регулярно отслеживать прогресс.

Для одного клиента может потребоваться больше сессий, чем для другого, поскольку процесс приобретения навыков индивидуален. Это может привести к «зависимости» клиента от терапевта, поэтому важно в ходе терапии передавать все больше ответственности клиенту. Переход от терапии к автономии необходимо тщательно планировать в сотрудничестве, например, сокращая периодичность сессий и/или проведение кратких плановых бустерных сессий.



Профилактика рецидивов

Взрослые с РДВГ потенциально могут потерпеть неудачу, когда столкнутся с проблемами в будущем. Поэтому методы МИ полезны для переосмысления проблемы как промахов и упущений. Заранее запланированные повторные сессии – это разумный способ поддержать клиента после прекращения терапии и предотвратить рецидив. Терапия должна включать план на случай непредвиденных ситуаций или моментов, когда клиент может чувствовать себя уязвимым. Выявляя такие моменты, клиент может рассмотреть соответствующие варианты совладания и избежать импульсивных реакций. Планируя заранее и продумывая последствия поведения, клиент может научиться избегать сложных ситуаций или преодолевать их. Планы рецидивов должны быть многогранными, например, включать обращение за социальной помощью, советом, применение когнитивных техник и избегание ситуаций, если необходимо.



КПТ СДВГ

ГЛУБИННЫЕ СИМПТОМЫ

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ



КПТ СДВГ

Нарушение внимания может привести ко многим проблемам в повседневном функционировании, включая трудности с рабочим интервью, проблемы в работе, академические трудности и так далее.

Людам с РДВГ трудно выполнять задания одновременно и на приемлемом и удовлетворительном уровне. Способность уделять внимание и концентрироваться включает в себя ряд этапов развития умственных способностей, необходимых для личностной, социальной и профессиональной адаптации.

Человеческий мозг имеет несколько систем внимания, выполняющих различные функции в повседневном поведении, и нарушение центрального исполнительного компонента рабочей памяти может привести к неэффективности распределения ресурсов внимания.



1. Внимание и контроль внимания

Внимание - это процесс, который позволяет нам сосредоточиться на конкретных особенностях нашего окружения таким образом, чтобы мы осознавали их в определенный момент времени. Процессы контроля внимания определяют в любой данный момент, где следует расставить приоритеты и на какие стимулы обратить внимание. Эти процессы управления представляют собой сложные когнитивные функции «высшего порядка», которые позволяют вниманию быть избирательным к одному стимулу, разделяться между несколькими стимулами и переключаться между стимулами.



КПТ СДВГ

В некотором смысле, трудности с контролем внимания можно рассматривать как когнитивный дефицит, лежащий в основе всех аспектов нарушения внимания при РДВГ.

Если человек не в состоянии управлять тем, что он будет слушать, смотреть и на чем сосредоточиваться, значит, он потерял контроль над вниманием.

Теоретические модели предполагают, что система контроля внимания/центральный исполнительный элемент – это когнитивная функция высшего порядка, которая определяет, какие стимулы в окружающей среде являются приоритетными с точки зрения концентрации внимания, особенно в новых ситуациях.



КПТ СДВГ

Некоторые виды деятельности предъявляют к системе контроля более высокие требования, чем другие, например, перспективное планирование, реагирование на обратную связь и самоконтроль. И наоборот, проблемы в системе контроля внимания/центрального исполнительном элементе могут привести к различным дефицитам внимания и, в конечном счете, повлиять на функционирование памяти.

У людей с РДВГ эти типы дефицита внимания можно разделить на четыре области:

- избирательное внимание
- Распределенное внимание
- переключаемость внимания
- устойчивое внимание

Область внимания	Ассоциированные проблемы
Избирательность внимания	Невозможность увидеть детали, неаккуратность, постоянные ошибки в чтении и заполнении форм, пропуск строк в анкетах и формах
Распределение внимания	Невозможность сконцентрироваться на разговоре или задаче, когда есть фоновый шум, невозможность делать 2 вещи одновременно по приемлемому стандарту
Переключаемость внимания	Застревание на задаче, невозможность изменить направление внимания, постоянно начало выполнения задачи без доведения до конца, потому что сложно восстановить первоначальную задачу
Устойчивость внимания	Потеря темы разговора, фильма, книги и пр. Отвлечение на свои собственные мысли или на что-то в окружении



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ испытывают большие трудности с многозадачностью. Для того чтобы хорошо выполнить задание и не допустить ошибок, они должны приложить все свои ресурсы, чтобы сосредоточиться на этой задаче. Это сложно по трем причинам:

1. Им трудно поддерживать необходимую степень контроля внимания
2. Они легко отвлекаются от выполнения задания
3. Они отказываются от выполнения задания, потому что не достигают своей цели (из-за отсутствия положительного подкрепления)



КПТ СДВГ

Для взрослых с РДВГ трудности с поддержанием внимания, вероятно, являются наиболее выраженной и выводящей из строя проблемой внимания, поскольку людям часто трудно заниматься длительными видами деятельности, независимо от того, являются ли они повторяющимися или утомительными. Если задача длительная и к тому же утомительная, клиент с РДВГ, скорее всего, полностью откажется от нее. Домашние дела, которые ему приходится выполнять в повседневной жизни, по определению рутинные, скучные и повторяющиеся. Невозможно вести ежедневный распорядок дня, который был бы постоянно наполнен волнением и высокой стимуляцией.



КПТ СДВГ

Когда люди с РДВГ сталкиваются с рутинными задачами, они реагируют раздражением, что является источником разочарования как для человека с РДВГ, так и для тех, кто живет или работает с ними. Эти чувства в сочетании с множеством незавершенных задач, скорее всего, оставят у человека чувство неудачи и низкую самооценку.

Напротив, когда деятельность особенно интересна или мотивирует и/или предполагает немедленное удовлетворение (например, быстрая обратная связь и подкрепление, представленные во многих компьютерных играх), люди с РДВГ, как правило, способны хорошо концентрироваться.



КПТ СДВГ

Окружающим людям может быть трудно понять такую непоследовательность. У одного клиента может быть наполовину выкрашенная гостиная, наполовину подключенная стиральная машина, каркас встроенного шкафа в спальне, а плитка для ванной была куплена полгода назад, но так и осталась лежать стопкой на полу ванной комнаты.

Наблюдение за человеком с РДВГ может помочь нам увидеть, что он компетентен в одной области (например, серфинг в Интернете), но не способен достичь результатов в другой, которая воспринимается как более важная (например, написание резюме). Основное различие между задачами заключается в колеблющихся уровнях мотивации, которые не всегда находятся под контролем человека с РДВГ.



2. Мотивация и внимание

Существует 2 формы мотивации: внешняя и внутренняя. И та, и другая может быть подвержена влиянию РДВГ и может значительно колебаться в течение любого заданного периода времени.

1. Внешняя мотивация относится к вознаграждениям или стимулам за то, что люди хорошо работают или избегают негативных последствий.
2. Внутренняя мотивация определяется интересом к какой-либо деятельности.



КПТ СДВГ

Что касается внешней мотивации, у человека должно быть некоторое ожидание того, что он сможет достичь желаемых целей, в противном случае он будет чувствовать себя демотивированным независимо от вознаграждения или стимула.

Однако люди с РДВГ часто чувствуют себя демотивированными, поскольку они пережили годы отсутствия успеха. Когда мотивация падает, внимание и усилия также снижаются. Может развиваться состояние выученной беспомощности. Человек может изменить свой взгляд на задачу и свою способность к ее достижению, поставив четкие цели и вознаградив свое внимание к задаче поощрениями.



Внешние системы вознаграждения должны быть реалистичными, уместными и достижимыми. **Постановка целей** - это мотивационная стратегия, которая повышает эффективность внимания в трудных, но достижимых целях. Если цели не достигнуты, то неудача усилит приобретенную беспомощность, и клиент с РДВГ «отключится».

Обратная связь является важнейшим компонентом внутренней мотивации, поскольку она помогает человеку определить несоответствие между желаемыми и фактическими показателями. Если человек обладает чувством самоэффективности и верит, что он может что-то сделать, он будет чувствовать, что у него есть контроль.



КПТ СДВГ

Чувство контроля повысит его мотивацию и оптимизирует его внимание к задаче. Однако, если задача воспринимается как неподвластная человеку, он может потерять интерес и перестать посещать ее выполнять. Это означает, что задача останется незавершенной, что усилит ощущение неудачи.

Цикл отрицательной обратной связи может развиваться из-за повторяющихся неудач и приобретенной беспомощности. И наоборот, чувство самоэффективности будет ассоциироваться с успешной и настойчивой работой.



3. Выявление дефицита внимания и его функций

Нарушения внимания, связанные с РДВГ, по-разному влияют на разных людей. Ниже описаны некоторые примеры трудностей с концентрацией внимания:

- Теряют ход мыслей, это особенно раздражает, если человек забывает, что хочет сказать в середине разговора.
- Когда вокруг много людей или на заднем плане много шума, им трудно поддерживать беседу.
- Им трудно поддерживать углубленный разговор на одну тему.
- В их сознание приходят другие мысли и идеи, которые могут подавить нужную мыслительную деятельность.
- На вечеринках люди могут раздражаться, так как думают, что человек с РДВГ непостоянный из-за того, что он постоянно меняет собеседников и темы разговора.
- Их разум блуждает, они могут начать грезить наяву, когда смотрят телевизор, читают книгу или занимаются учебой.
- Они начинают много дел, но не заканчивают их. Отвлекаются, занимаясь чем-то другим.
- Им трудно выполнять более одной задачи одновременно, например, управлять авто во время разговора с пассажиром.



КПТ СДВГ

Конечно, во всем, что мы делаем, есть индивидуальные различия. Например, некоторые люди испытывают большие трудности с поддержанием внимания, в то время как другие испытывают большие трудности с распределением внимания. Разные задачи сопряжены с разными трудностями. Некоторые люди обнаруживают, что они более продуктивны, занимаясь несколькими видами деятельности на ходу; то есть обеспечивая себе «конструктивное» отвлечение внимания, чтобы снизить вероятность того, что им наскучит выполнение основной задачи. Другие считают, что это мешает их работе.



КПТ СДВГ

Настроение и мотивационные процессы также могут влиять на производительность. **Цель терапевта** состоит в том, чтобы выявить конкретные слабые области и помочь человеку разработать компенсаторные стратегии, способствующие достижению целей.

Клиента следует научить распознавать задачи, которые, вероятно, будут проблематичными, и реагировать адаптивно. На достижение этой цели будет оказано влияние, если имеется доминирующий симптом СДВГ (например, преимущественно невнимательный тип или преимущественно гиперактивный/импульсивный тип), чего человек хочет достичь и какой поддержкой он пользуется.



КПТ СДВГ

В во многих отношениях «предупрежден - значит вооружен», поэтому распознавание задач, которые могут оказаться проблематичными, и подготовка к ним являются первым важным шагом на пути к устранению трудностей с концентрацией внимания.

Как только будут определены конкретные задачи, при решении которых человек сталкивается с трудностями с контролем внимания, то их следует целенаправленно улучшать, применяя как внешние, так и внутренние стратегии. ***Внешние стратегии предполагают адаптацию к окружающей среде, а внутренние стратегии предполагают процесс самоконтроля.***

4. Применение внешних стратегий для решения проблем с вниманием

Внешнее отвлечение относится ко всей внешней сенсорной информации (т.е. как слуховой, так и визуальной), которая обрабатывается в ущерб требуемой задаче. Сокращение неуместных отвлекающих факторов может помочь человеку сосредоточиться на интересующем его предмете. Применение внешних стратегий требует от человека адаптации к своему окружению, чтобы максимизировать вероятность того, что он сможет оптимальным образом достичь успеха. Необходимо поощрять клиента к проведению мини-экспериментов между сессиями, чтобы проверить, какие техники ему наиболее подходят и работают лучше всего. Существует множество возможностей, и у самого клиента могут быть идеи для работы или уже разработанные стратегии, которые могут оказаться полезными. При отслеживании эффективности стратегии важно определить, правильно ли клиент применил стратегию.



1. Источник отвлечения – **слуховой**:

- Прослушивание музыки низкого регистра без текста может быть полезно для маскировки других, более прерывистых шумов. Как правило, следует избегать музыки со словами, поскольку это может помешать мыслям и привести к дальнейшему отвлечению.
- Хотя может быть неудобно просить окружающих уменьшить уровень шума, эту стратегию можно отрепетировать на сессии. Затем клиент может разработать способ подачи этого запроса так, чтобы с наименьшей вероятностью получить негативный фидбэк от окружающих. Часто люди чувствуют облегчение, когда окружающая среда становится более спокойной.
- Простая стратегия использования берушей может быть эффективной в блокировании всех звуков, кроме самых громких, если не нужно проводить фильтрацию звуков.



- Телефонные звонки могут нарушить концентрацию внимания и продуктивность. Хотя некоторые звонки могут быть важными, но это редко относится ко всем звонкам. Телефоны можно переключать в беззвучный режим и проверять наличие сообщений в удобное время, через регулярные промежутки времени или после выполнения задачи.
- Если задача может быть перенесена, клиенту может быть полезно удалиться из шумного окружения, например, дома, где громко работает телевизор. Если клиент не может найти более тихую комнату в своем доме, то он мог бы договориться с близкими о времени тишины или попросить друга использовать комнату для работы или работать в тихом месте вне дома.



2. Источник отвлечения – зрительный:

- Отвлекающие визуальные стимулы, такие как картинки, доски объявлений, всплывающие окна и так далее, следует располагать вне поля зрения человека.
- Взгляд в окно может отвлекать, даже когда снаружи ничего не происходит, поскольку у людей с РДВГ возникает соблазн взглянуть наружу и помечтать. Однако нахождение лицом к стене может вызвать беспокойство. Часто расположение лицом к комнате может стать наилучшим вариантом для ограничения отвлекаемости и уменьшения беспокойства.
- Использование ярких цветов для привлечения внимания к задаче может быть полезным. Например, с помощью заметок и ручек-маркеров.
- Может быть полезно разместить карточку-подсказку (фотографию, заметку) в «опасных» местах, чтобы напомнить человеку о необходимости быть внимательным. «Сосредоточься!» или что-то такое можно разместить на компьютерном мониторе.

5. Применение внутренних стратегий для решения проблем с вниманием

Применение внутренних стратегий для оптимизации производительности требует от человека умения прилагать настойчивые усилия и подавлять внутренние побуждения. Важно побудить клиента максимально использовать свою способность удерживать внимание, повышая интерес и мотивацию. Этого можно достичь, поставив небольшие достижимые цели и введя систему **немедленного вознаграждения и/или регулярные перерывы.**

Действительно, основное различие между лечением людей с РДВГ и нормотипичных клиентов - это внедрение систем вознаграждения в процессе лечения, поскольку люди с РДВГ не могут откладывать удовлетворение. Это означает, что они предпочитают небольшие регулярные вознаграждения, в отличие от получения больших вознаграждений, которые распределяются на более длительный период.



КПТ СДВГ

Однако клиента необходимо поощрять сосредотачиваться на выполнении задачи в течение длительного периода, поэтому рекомендуется вводить множество небольших немедленных регулярных вознаграждений, а также более крупное вознаграждение за достижение общей цели или задачи. Исходя из установленного вознаграждения за выполнение задачи, выполнение задачи само по себе является наградой, поскольку дает клиенту ощущение достижения. **Достижение - это очень сильное подкрепление.**



КПТ СДВГ

1. **Награда** – разработка программы стимулирования и вознаграждения является приоритетной задачей. Это следует учитывать как при постановке небольших целей, так и при достижении более крупных, поскольку это позволяет использовать потребность в немедленном удовлетворении. Вознаграждением может быть простые действия, такие как перерыв на чай или прогулка.



Основные принципы системы быстрых вознаграждений

- Малые и частые подкрепления > крупные и редкие.
- Вознаграждение должно быть сразу после поведения, а не через час/дни.
- Важно сочетать внешние награды и самоподкрепление (похвала, осознание успеха).
- В начале → максимально конкретные и видимые вознаграждения; постепенно → переход к более внутренним и долгосрочным.



КПТ СДВГ

Виды быстрых вознаграждений

- Сенсорные и микро-радости (1-2 минуты)
 - Кофе/чай, любимая жвачка
 - Послушать один трек
 - Съесть небольшой приятный перекус (но не еду в целом как единственный инструмент!)
 - 3-5 минут на соцсети и мемы
 - Мини-медитация с наушниками
 - Контакт с домашним животным



КПТ СДВГ

- Символические (накапливаемые)
 - Стикеры или жетоны за выполнение задания
 - Баллы в приложении (Habitica, Forest, Todoist с геймификацией)
 - Монетки/жетоны, которые можно затем обменять на большую награду (сериал, прогулка, новая вещь)

- Эмоциональные
 - Записать успех в «дневник достижений»
 - Отправить себе/терапевту смайлик или фото «сделал!»
 - Наклейка
 - Высказать вслух похвалу самому себе



Примеры структуры быстрых наград в терапии

➤ Дома (самостоятельная работа)

- Разбить задачу на шаги → после каждого шага маленькая награда (например, 5 минут YouTube).
- Использовать таймер Pomodoro (25 мин работа → 5 мин награда).
- Приложения с мгновенным «фейерверком» после галочки (Todoist, Trello с анимацией).

➤ В терапии

- В начале сессии → маленькое вознаграждение за то, что пришёл вовремя/выполнил домашнее задание (словесная похвала + жетон/символ).
- В конце → выбор приятного способа завершить сессию (короткое упражнение на релаксацию, приятный разговор).

➤ В повседневности

- После бытовых задач (мытьё посуды, звонок) → «мгновенный бонус» (сериал/трек).
- За выполнение 3 мелких дел → бонус побольше (например, прогулка/игра).



Как встроить в терапевтический процесс

1. **Совместно с клиентом** составить список быстрых наград (персонализированных).
2. Сделать “**меню быстрых вознаграждений**” — 10–15 штук разных категорий.
3. Использовать **жетонную систему** (token economy):
 1. Каждое маленькое достижение = жетон.
 2. 5 жетонов = средняя награда (сериал/покупка).
 3. 20 жетонов = большая награда (новая вещь/долгая прогулка).
4. Обязательно отслеживать **чувство удовольствия** и обсуждать на сессиях: что сработало, а что нет.



Важные моменты

- Вознаграждения должны быть **разнообразными** (иначе быстро теряют ценность).
- **Избегать наказаний** → акцент только на подкреплении.
- Важно встроить **немедленное терапевтическое признание** («ты сделал шаг — и я вижу, это успех»).
- С детьми/подростками → добавляется участие семьи (родители дают символические награды).
- У взрослых → делать систему максимально **автономной и гибкой**, чтобы не ощущалась «детской».



КПТ СДВГ

Уровень	Примеры наград	Когда использовать
Быстрые (немедленные, 1–5 мин)	☕ чашка кофе/чая 🎧 любимый трек 📱 5 минут соцсетей/мемов 🍪 маленький перекус (конфета, орехи) 💡 стикер/жетон 🕒 мини-медитация 2 минуты 📝 записать галочку/“+1” в приложении	После каждого маленького шага или блока работы (например, сделал звонок, помыл посуду, закончил Pomodoro-цикл)
Средние (доступные почти ежедневно)	🎮 20–30 минут игры 📺 эпизод сериала или YouTube 🚶 прогулка в парке 🛒 маленькая покупка (свеча, канцелярия) 📖 20 минут чтения «для удовольствия» ☎ звонок другу/чату 🌸 время на хобби (музыка, рисование)	За несколько быстрых наград подряд или выполнение 2–3 задач/домашнего задания
Большие (накопительные, раз в неделю/месяц)	🎁 крупная покупка (одежда, аксессуары) 🎬 поход в кино/кафе/ресторан 🕒 СПА/массаж/баня 🚗 поездка в новое место 📦 заказ чего-то давно желанного онлайн 🏖 день отдыха «без задач» 🎨 мастер-класс или новое хобби	Когда накоплено 20 жетонов или выполнен крупный терапевтический/жизненный шаг (например, неделя выполнения расписания, завершение проекта)



КПТ СДВГ

2. **Соревнование** - людей с РДВГ можно побудить повысить их интерес и мотивацию к какому-либо занятию, введя элемент соревнования (например, давайте посмотрим, сможем ли мы закончить это за один час) или включив уже существующий интерес (например, если клиенту нравится использовать компьютер, то поощряйте его оплачивать счета через Интернет).



Форматы соревнования

- Соревнование с самим собой: побей свой рекорд (время концентрации, количество выполненных дел), приложения с геймификацией (Forest, Habitica)
- Мини-соревнование в группе: в групповой терапии – кто первым выполнит задачу, челлендж недели – кто больше дней подряд вел дневник задач)
- Партнерская система: два клиента в паре – каждый сообщает о выполнении поддерживают друг друга; «кто сегодня первым справился с ДЗ»
- Командные челленджи: группа делится на команды, общая цель – закрыть задачи. Акцент на коллективное достижение.



КПТ СДВГ

Примеры упражнений

- Спринты внимания: кто дольше удержит фокус на задаче (с таймером)
- Лестница успеха: каждый шаг задачи = балл, сравнение прогресса
- Геймифицированное ДЗ: выполнение = очки очки копятся и можно обменять на награду
- Чемпион недели: выбирается за самое креативное или последовательное выполнение



КПТ СДВГ

- В индивидуальной терапии терапевт может выступать как «соперник», соревнование также можно проводить с прошлой версией себя.
- В групповой терапии можно создать «челлендж-доску» и выполнять командные упражнения.

Условия:

- Фокус на прогрессе, а не на идеале
- Награда всегда за участие (даже если не выиграл → всё равно похвала или маленький бонус)
- Прозрачные и простые правила
- Баланс между сотрудничеством и конкуренцией



КПТ СДВГ

3. Новизна - люди с РДВГ могут быть более мотивированы в новых ситуациях, поэтому их следует поощрять извлекать выгоду из фактора новизны, принимая новые задания в обмен на старые, менее интересные (например, с энтузиазмом берясь за новые роли).

Терапевт может осознанно использовать новизну как инструмент повышения вовлечённости и закрепления терапевтических навыков.

Формы новизны:

- Формат сессии: менять расположение в кабинете, использовать новые материалы (карточки, визуалы), вводить неожиданные мини-упражнения в начале сессии
- Содержание: новые метафоры, картинки, видео, мемы для объяснения техник, привязка навыков к новым темам интереса клиента (например, обсуждать прокрастинацию через аналогии с любимыми книгами/фильмами)
- Методы работы: чередование письменных, визуальных, телесных упражнений, использование приложений и геймифицированных инструментов
- Малая новизна: новая ручка, стикеры, цвета маркеров, вариации в ДЗ



КПТ СДВГ

Терапевтические приемы

- Элемент неожиданности: начать сессию с «случайно карты навыка» или «колеса выбора техники»
- Технологическая новизна: вовлекать приложения, менять их раз в несколько недель
- Техника-сюрприз: клиент не знает заранее, какая техника будет на сессии
- Визуализация через новизну: использование необычных картинок, комиксов, арт-метафор



Примеры внедрения

- Домашнее задание – каждую неделю разный формат (схема, голосовая заметка, фото, мини-комикс)
 - Работа с планированием – сначала «обычная таблица», потом «цветная карта», потом «приложение-игра»
 - Освоение навыка внимательности - сначала дыхание, потом “mindful eating”, потом короткая прогулка.
 - В групповой терапии – ротация ведущего, новые мини-конкурсы
-
- ✓ Новизна должна быть малой и управляемой
 - ✓ Новизну можно использовать как усилитель, но навыки должны стабильно закрепляться
 - ✓ Обязательно сочетать новое и знакомое

4. Щелк! - перенаправление внимания с помощью **простых физических инструментов** — это эффективный приём в терапии РДВГ. Использование **сенсомоторных “якорей”** (например, резинки, сжималок, тактильных предметов) помогает **снизить импульс** и вернуть внимание в настоящий момент.

Тактильная стимуляция активизирует сенсорные каналы и снижает уровень внутреннего напряжения. Дает **малую дозу новизны и стимула** и компенсирует потребность мозга в дополнительной стимуляции. Помогает остановить автоматическое действие (например, импульсивный поступок) через **“стоп-сигнал”**. Является **фокусировочным якорем** — клиент связывает резинку/предмет с конкретным терапевтическим действием (например, пауза и осознанность).



Инструменты для перенаправления внимания

- Резинка на запястье – легкий щелчок = сигнал «стоп, вернись в задачу».
- Антистресс-предметы: сжималки, фитжеты, кольца, кубики и пр.
- Тактильные предметы: гладкий камень, браслет, четки.
- Ручка/карандаш с насадкой – для кручения или жевания.
- Карточки-якоря – с короткой фразой, например, «Стоп», «сосредоточься».



КПТ СДВГ

Условия

- Предмет должен быть удобным и доступным (лучше всегда иметь при себе)
- Использовать не как наказание, а как мягкий сигнал
- Можно связать с короткой техникой дыхания или саморегуляции
- Персонализировать: индивидуально подходим к выбору предмета



КПТ СДВГ

5. Когнитивные вызовы - разрабатывайте стратегии, позволяющие справляться с ситуациями, когда клиент теряет ход своих мыслей, например, он не должен стесняться сказать кому-то: «Мне жаль, но я забыл, что я говорил». Это можно отрепетировать в ролевой игре, дисфункциональные мысли о том, что значит терять внимание и как это может быть воспринято другими, могут быть когнитивно оспорены на сессиях.

Вербальные фразы для «сброса» - клиент учится заранее готовым «нейтральным» или «уверенным» ответам:

- «Извините, я потерял мысль — сейчас вспомню».
- «Давайте я сформулирую по-другому».
- «Пока вы отвечали, я отвлёкся — где мы остановились?»

Необходимо отрепетировать в ролевой игре.

Микро-техники для удержания мысли:

- Делать **ключевые пометки** (одно слово, рисунок).
- Использовать **визуальные опоры** (схема, жест рукой).
- Применять «маркеры речи»: «Первое, что важно... второе... третье...».



КПТ СДВГ

6. Повторение - в случаях, когда клиент испытывает трудности с отслеживанием и сохранением информации(например, когда ему дают инструкции), следует поощрять его просить повторить их. Опять же, это можно отрепетировать в ролевой игре, чтобы клиент мог преодолеть чувство смущения и/или унижения.



КПТ СДВГ

7. Постановка целей - помогите клиенту установить достижимые цели и избегайте всеобъемлющих нематериальных целей, которые могут оказаться трудными для практической реализации. Следует поощрять клиентов к размышлению о том, каково это - завершить задание и обрести чувство достижения. Могут быть включены принципы удовольствия и мастерства (об этом чуть дальше).



8. Перерывы - важно разделять занятия. Клиент должен приучить себя выделять вынужденные перерывы в выполнении задач, особенно если они рутинные или утомительные. Клиент должен дополнительно выделять перерывы непосредственно перед "периодом риска", когда он может потерять концентрацию или интерес, например, если он может концентрироваться в течение 30 минут, им следует сделать перерыв через 25 минут.



6. Отвлекаемость и беспокойство

Особая проблема людей с РДВГ состоит в том, что они отвлекаются от выполнения поставленной задачи. Им сложно оставаться вовлеченными по двум причинам:

1. Внешнее отвлечение: внимание к несущественным деталям (например, кто-то проходит мимо)
2. Внутреннее отвлечение: желание сделать что-то более стимулирующее (например, поболтать в чате, когда нужно спокойно работать).



Двигательная гиперактивность часто является инвалидизирующим симптомом в детском возрасте, но в меньшей степени - во взрослом. Вряд ли вы встретите много взрослых с РДВГ, бегающих по терапевтическому кабинету, выпрыгивающих из окон, лазающих по деревьям или катающихся на скейтборде по больничному коридору.

В то время как взрослые с РДВГ, возможно, научились лучше контролировать свое гиперактивное поведение, они часто сообщают о чувстве "внутреннего" беспокойства. Некоторым людям почти невозможно усидеть на месте, или у них возникает ощущение, что их "приводит в движение мотор". Однако во взрослом возрасте беспокойство чаще всего выражается в расхаживании взад-вперед, постукивании пальцами, покачивании ногами, смене позы, возне с вещами, покачивании с ноги на ногу, напевании и/или чрезмерной разговорчивости. Такие трудности обычно ошибочно диагностируют как генерализованную тревогу или гипоманию.



КПТ СДВГ

Следует поощрять клиентов извлекать выгоду из этой энергии, выполняя задачи, требующие напряжения. При необходимости это может быть введено как **часть системы поощрения**, при этом день организуется таким образом, чтобы включать регулярные периоды, когда клиенты могут передвигаться и развеивать накопившееся беспокойство и энергию. В то же время полезно определить ситуации, которые клиент находит более расслабляющими, и вписать их в свой день как часть расписания занятий (поговорим об этом подробнее в разделе управления временем). Такое время может быть удобно распределено по расписанию после завершения когнитивно сложных и эмоционально требовательных задач.



7. Тревога

Снижение контроля внимания, когда человек вымотан, испытывает стресс или беспокоится. Если человек обращается к себе и думает «Я не смогу сделать это», то его способность к вниманию, скорее всего, будет еще более ослаблена из-за конкурирующих требований беспокойства о том, насколько хорошо он выполнит задачу. Затем это нарушение усугубляется и становится следствием стресса и тревоги. Когда клиенты испытывают тревогу, они становятся очень отвлекаемыми. В лучшие времена им достаточно трудно найти мотивацию продолжать выполнять задание, но если они будут испытывать острую тревогу по поводу своей работы и/или потеряют уверенность в том, что справятся хорошо, они станут еще менее мотивированными, у них будет много незавершенных задач (как важных, так и менее важных) и они будут чувствовать себя еще более напряженно и огорченно.





КПТ СДВГ

8. Проблемы с памятью

Проблемы с памятью присутствуют при многих психических расстройствах, как с органической основой, так и без нее. У людей с РДВГ проблемы с памятью часто связаны с проблемами с вниманием. Проблемы с памятью также являются наиболее очевидной проблемой для самого человека и для окружающих, поскольку плохая память часто более очевидна, чем плохое внимание.



Общие проблемы с памятью

1. Перекладывание вещей не на свое место, например, забывание, куда они положили свои очки, ключи и так далее.
2. Забывание о назначенных встречах, крайних сроках и действиях, которые необходимо выполнить в будущем, например, человек забывает оплатить арендную плату.
3. «Потеря времени», т.е. невнимание к течению времени или искаженное ощущение времени, приводящее к тому, что такие люди опаздывают и не знают, куда ушло время.
4. Забывание инструкций, если кто-то пытается объяснить, как выполнить задание, им приходится замедляться и повторять это несколько раз.
5. Нарушение мыслительная обработки, например, ментальной арифметики.



КПТ СДВГ

Эти проблемы возникают из-за сбоев в процессах запоминания в трех основных системах памяти:

- непосредственная сенсорная память (т.е. очень кратковременное запоминание всех ощущений);
- кратковременная/рабочая память (т.е. временное хранилище, где можно манипулировать информацией);
- долговременная память (т.е. хранение в течение более длительного периода).

Дефицит и кратковременной и долговременной памяти может наблюдаться у клиентов с РДВГ.



Сенсорная память

Этот тип памяти часто рассматривается как "чувствительная" память, поскольку она обеспечивает кратковременную память для всех органов чувств, включая зрение, звуки, запахи, эмоции, осязание и вкус. Это как блокнот для записей или моментальный снимок информации, который быстро перезаписывается новыми ощущениями, поступающими в мозг. У некоторых людей с РДВГ могут возникнуть особые трудности, если их сенсорная память перегружается слишком большим количеством стимулов из слишком большого количества различных источников, и это приводит к тому, что они становятся чрезвычайно отвлекаемыми. Процессы, связанные с вниманием, также, вероятно, определяют качество информации, которая попадает в сенсорную память. Когда необходимо использовать информацию, находящуюся в сенсорной памяти, она затем переносится в кратковременную/рабочую память, где ее можно отрепетировать или манипулировать ею.



Рабочая/кратковременная память

После того, как информация была получена в системе сенсорной памяти, она затем хранится в течение очень короткого периода в системе рабочей памяти. Это временное хранилище информации, подобное перезаписываемой кассете или видеозаписи, прежде чем информация попадет в долговременную память или будет "отбракована" и, таким образом, станет невозстановимой. Было показано, что рабочая память нарушена у людей с РДВГ, возможно, из-за плохого внимания или помех при отвлечении внимания.

При РДВГ возможно, что информация не поступает в рабочую память должным образом и что материал не может быть сохранен в том же объеме, что и у людей без РДВГ, кроме того, проблемы с "центральным исполнительным элементом" могут привести к трудностям с обращением к соответствующему материалу для того, чтобы он был обработан рабочей памятью.



Долговременная память

Информация переносится из рабочей памяти в долговременную, которая довольно четко относится ко всей информации, начиная всего с нескольких минут назад и заканчивая годами, прошедшими с момента события. Эта система запоминания состоит из трех этапов: кодирование, хранение и извлечение информации. Кодирование включает в себя регистрацию и обработку информации и сильно зависит от процессов внимания и, следовательно, может быть нарушено у людей с РДВГ. На хранение усвоенной информации влияет широкий спектр факторов, которые влияют на функционирование мозга и проявляются в забывании.



КПТ СДВГ

Извлечение сохраненной информации предполагает явное воспоминание или неявное знание, выявленное при последующем выполнении. Поиск может зависеть от стратегий доступа к информации, таких как попытка проследить свои шаги, чтобы найти потерянную вещь. При РДВГ этот процесс может быть более бессистемным. На поиск также может повлиять способ кодирования информации. Например, было показано, что пациенты с РДВГ испытывают трудности с организацией информации на этапе кодирования, например, с распределением материала по категориям, и, следовательно, испытывают трудности с оптимальным поиском.



Применение внешних стратегий для улучшения памяти

Существует несколько стратегий, которые клиент может адаптировать, чтобы попытаться помочь ему улучшить свою память. Обычно они включают внедрение **внешних вспомогательных средств**, то есть использование систем поддержки для минимизации проблем, возникающих из-за плохой памяти, таких как использование дневников, планировщиков. Более того, существуют также **внутренние стратегии**, которые могут быть применены, и для достижения оптимальных результатов следует поощрять клиента к разработке как внутренних, так и внешних методов улучшения памяти. Как обсуждалось ранее для развития контроля внимания, терапевт должен исследовать, что клиент успешно применял в прошлом, выявить новые возможности, поставить домашние задания, чтобы оценить их эффективность, и обсудить с клиентом лучшие и наиболее подходящие техники.



1. **Дневник** - полезен для краткосрочного планирования. “Страница в день”- стратегия наиболее полезна, поскольку в него можно записывать встречи, а также дополнительные заметки, например, о задачах, которые необходимо выполнить, необходимых покупках и так далее. Представление этой информации в формате дня служит подсказкой и напоминанием о задачах, которые нужно выполнить для достижения долгосрочных целей.

При СДВГ страдает **рабочая память** → мозг «забывает» удерживать последовательность задач и воспоминаний. Дневник = “**внешний жёсткий диск**”, который разгружает мозг и помогает фиксировать важное. Цель не в том, чтобы всё помнить самому, а в том, чтобы **правильно выносить на бумагу/экран**.

Форматы дневника: бумажный блокнот, приложение (Notion, Todoist, Evernote, Google Keep), смешанный вариант.

Структура дневника (варианты в терапии):

- Дневник задач: например, каждое утро составляется список дел (3-5 задач), вечером выполняется отметка о том, что сделано, в терапии обсуждается, что помогало, а что мешало.
- Дневник событий: краткие записи о том, что произошло сегодня (3-4 факта), цель здесь – тренировка эпизодической памяти+осознание, что клиент вспоминает больше, чем ему кажется.
- Дневник мыслей/идей: клиент улавливает «потерянные мысли» и фиксирует их, в терапии можно использовать как материал для когнитивной реструктуризации.
- Дневник эмоций и успехов: запись ситуаций, где удалось удержать внимание, фиксация того, что помогло. Формируется позитивный опыт памяти и концентрации.



КПТ СДВГ

Терапевтические стратегии внедрения:

1. **Минимум входа** — не более 2–3 минут на запись (иначе бросит).
2. **Якорь привычки** — привязать дневник к действию (например, утренний кофе = открыть дневник).
3. **Визуальные сигналы** — держать дневник на столе, прикрепить стикеры-напоминания.
4. **Регулярный разбор на сессиях** — терапевт просматривает записи вместе с клиентом, хвалит за фиксацию, помогает находить закономерности.
5. **Геймификация** — отмечать галочками/стикерами каждый день использования.



2. Ежедневный календарь - позволяет членам семьи записывать напоминания и инструкции, которые могут быть полезны для конкретного человека. Например, для семейной вечеринки по случаю дня рождения другой член семьи может разработать план действий, распределив обязанности, отметив “заказать такси”, “купить торт” и так далее. Кроме того, человеку с РДВГ полезно узнать, как его деятельность интегрируется с деятельностью его семьи. Кроме того, ежедневный календарь используется для фиксирования личных задач.



КПТ СДВГ

Для людей с РДВГ **еженедельный календарь** — это один из самых эффективных **внешних инструментов саморегуляции**, потому что:

- снижает нагрузку на рабочую память (не нужно держать в голове сразу много задач и сроков)
- помогает «визуализировать время» (у людей с РДВГ часто искажено ощущение времени: «только сейчас» и «*никогда*»)
- даёт структуру и предсказуемость, что снижает тревожность
- создаёт **ритуал планирования**, который сам по себе становится терапевтическим



Форматы календарей: бумажный (еженедельник на развороте так, чтобы было видно всю неделю), цифровой календарь (Google Calendar, Outlook, Todoist) с напоминаниями, настенный календарь/доска (подходит визуалам, детям и подросткам).

Основные терапевтические задачи календаря:

- Вынесение информации из головы на внешний носитель
- Разбивка времени на блоки
- Видимость недели целиком, что помогает выстроить баланс работа/отдых/семья
- Фиксация обязательств (работа, учеба, терапия) и наград (приятные активности)
- Формирование рутин (закрепление в поведении)



Как внедрять в терапии

1. На сессии:

- Терапевт вместе с клиентом заполняет календарь на неделю: обязательные задачи, базовые потребности, приятные награды. Обсуждается: где перегруз, где слишком пусто.

2. В процессе:

- В начале каждой сессии выделяется 5-10 минут на обзор календаря (что получилось, а что нет). Сравнение план/факт – и далее когнитивная реструктуризация (это не провал, а материал для анализа).

3. Домашнее задание: каждый вечер открывать календарь и уточнять информацию+вносить новую (в моменте), добавить напоминания.



КПТ СДВГ

Техники

- Цветовое кодирование: красный – работа, зеленый – отдых, синий – встречи и т.д.
- Правило «больших камней»: сначала вписываются ключевые дела, а потом мелкие.
- Ограничение времени: указываем не только то ЧТО ДЕЛАТЬ, но и СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ.
- Календарь как зеркало успехов: клиент видит, что он сделал, таким образом укрепляется самооценка.



КПТ СДВГ

Условия

- Календарь должен быть **видимым** (лежать на столе, висеть на стене, быть доступен в телефоне).
- **Минимализм**: перегруженный календарь демотивирует.
- Сначала терапевт помогает, позже клиент берёт всё больше ответственности.
- Важно **подчёркивать награды и отдых**, а не только обязательства.



КПТ СДВГ

3. *Ежегодный календарь* - может быть использован для составления долгосрочных планов и прогнозирования будущего, например, для обозначения школьных каникул, семейного отпуска, годовщины и так далее.



КПТ СДВГ

4. Портативный рекордер/диктофон на телефоне - можно использовать для составления устных списков и напоминаний об информации, которая может вылететь из головы. Некоторым людям полезно носить с собой диктофон, чтобы они могли быстро записывать задачи и идеи. Затем список задач или напоминаний можно будет систематически прорабатывать позже.



КПТ СДВГ

Почему это удобно?

- Не требует писать или структурировать мысль, что снижает риск потерять идею.
- Разгрузка рабочей памяти: мысль фиксируется сразу, даже если она «сырая».
- Быстрый доступ: включить запись проще, чем искать бумагу.
- Аудио-якорь: при переслушивании лучше всплывают контексты и эмоции.



КПТ СДВГ

Основные форматы: дневник мыслей и событий, заметки для дел, напоминания себе, рефлексия после сессии, домашнее задание.

В терапии:

- 1) Психообразование: объясняем, что диктофон = внешняя рабочая память.
- 2) На сессии вместе с клиентом пробуем записать голосовую заметку.
- 3) Договариваемся о структуре записи: дата, короткий заголовок, ключевые мысли.
- 4) Разбор на следующей сессии: переслушиваем заметки, обсуждаем, что помогает/мешает.



КПТ СДВГ

Условия:

- Записи должны быть короткими (30-90 секунд), иначе клиент не будет переслушивать.
- Лучше использовать ОДНО приложение.
- Учим клиента давать название записи голосом.
- При желании можно автоматически конвертировать в текст.

Риски:

- Накопление записей (аудио-свалка)
- Отказ от переслушивания, в этом случае нужно обсудить стратегию.



КПТ СДВГ

5. Сообщения на автоответчике - некоторые телефонные системы, включая мобильные телефоны, дают возможность отдельным лицам самим оставлять сообщения. Это может помочь уменьшить необходимость запоминания информации в будущем.



6. Списки - будет полезно привить человеку с РДВГ привычку составлять списки. Они будут включать ежедневные списки дел, которые нужно сделать, списки покупок, работу по дому. Систематизация идей по спискам и категориям также может помочь человеку с СДВГ развить чувство контроля, а отметка выполненных пунктов служит обратной связью и может быть мотиватором за счет положительного подкрепления.



КПТ СДВГ

Виды списков:

- Список задач: на день, неделю, проект.
- Список покупок: снижает риск импульсивных действий.
- Список целей: долгосрочные, разбитые на маленькие шаги.
- Список удовольствий/наград: для подкрепления.
- Список напоминаний: «что сделать утром/перед выходом из дома/перед сном».

Форматы: бумажные (доски, блокнот, карточки, стикеры), цифровые (Todoist, Google Keep, TickTick, Trello), гибридные.



КПТ СДВГ

Правила:

- 3-5 задач в день – длинные списки демотивируют.
- Разбивка задач – «сделать презентацию» → «открыть PowerPoint», «сделать первый слайд».
- Маркировка приоритетов – значки или цвет.
- Видимость – список всегда под рукой.
- Соединение со стимулом – привычка открывать список при утреннем кофе.



КПТ СДВГ

7. Карточки помощи - обобщенные формы информации могут быть полезны для действий, которые выполняются нерегулярно, таких как заполнение отчетов и форм налоговой декларации.



КПТ СДВГ

8. Наручные часы и отслеживание времени - часы можно разместить в очевидных местах, даже в каждой комнате дома, чтобы напоминать человеку с РДВГ о течении времени. Часы, которые издают звуковой сигнал, могут быть полезны для того, чтобы сориентировать человека на время, когда он отвлекся.



КПТ СДВГ

9. Сигналы напоминания - могут служить напоминаниями в течение различных периодов времени, начиная от трехчасового будильника для приема лекарств и заканчивая установкой ежегодного напоминания, чтобы не забыть о дне рождения друга.



КПТ СДВГ

10. Личные органайзеры и мобильные телефоны - могут выполнять многие из выше перечисленных задач, однако, если их организационные функции являются новыми для клиента, то их следует внедрять постепенно и превращать в рутину, согласовывая постановку целей с терапевтом, чтобы убедиться, что это не очередная стратегия, которая будет заброшена. Цель состоит в том, чтобы эти предметы были функциональными, а не отвлекающими.



КПТ СДВГ

Функции телефона:

- Календарь с напоминаниями (Google Calendar, iCal)
- Списки дел (Todoist, TickTick, Microsoft To Do)
- Заметки и чек-листы (Google Keep, Evernote, Notion)
- Голосовые записи
- Таймеры (Pomodoro) для управления временем
- Фото как напоминание (например, фото холодильника – напоминание, что нужно купить продукты)
- Будильники (не только утренние, но и сигналы-паузы в течение дня)



Внедрение в терапии

1) На сессии

- Психообразование – телефон = инструмент компенсации, а не слабость.
- Вместе с клиентом выбираем 2-3 ключевые функции (не перегружаем!)
- Настраиваем прямо на сессии: добавляем регулярное напоминание, создаем список трех задач на завтра, записываем голосовую заметку.

2) Домашнее задание: использовать телефон ЕЖЕДНЕВНО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Вести дневник использования: что помогло, где отвлекался.



Применение внутренних стратегий для улучшения памяти

1. Повторение и репетиция - повторение и отработка запоминания информации, например, с помощью разговор с самим собой может повысить вероятность успешной обработки информации рабочей памятью и последующего кодирования для более длительного запоминания.

- Повторение = многократное предъявление материала → ↑ вероятность закрепления.
- Репетиция = **активное проговаривание / проигрывание ситуации** → улучшает доступ к воспоминанию в реальной жизни.
- Стимулируется **дофаминергическая система**: знакомый материал становится менее скучным → легче удерживать внимание.



Виды повторения

- Вербальное – проговаривание вслух («три пункта, которые я должен запомнить»)
- Письменное – переписывание или выделение ключевых слов.
- Аудио – прослушивание записанных заметок
- Визуальное: повторение с опорой на карточки, схемы, цветовые маркеры

Виды репетиций

- Ролевая репетиция: клиент проигрывает ситуацию (например, как сказать коллеги «я потерял мысль»)
- Социальная репетиция: рассказать то, что нужно запомнить, другому человеку
- Ментальная репетиция: визуализировать шаги («сначала иду в магазин → беру корзину → покупаю 3 продукта»)
- Репетиция времени: мысленно пройти завтрашний день по шагам



2. Создание визуального сигнала - сочетание вербального задания с визуальным образом может улучшить запоминание слов, поскольку позволяет кодировать информацию как в визуальной, так и в вербальной форме. Это улучшает отслеживание в памяти и увеличивает вероятность последующего извлечения. Чем более причудливым и преувеличенным будет изображение, тем легче его будет запомнить. Например, если вы не забыли оплатить счет за воду, подумайте о сплаве по горной реке!



Для людей с РДВГ визуальные сигналы работают особенно хорошо, потому что они **мгновенно привлекают внимание** и становятся «якорями», помогающими удерживать нужную информацию в рабочей памяти. Это уже **внутренняя стратегия**, так как сигнал создаётся и используется самим человеком.

Формы визуальных сигналов:

- Цветовые метки (красный стикер на двери → «возьми ключи»)
- Символы и значки (нарисованный кружок, стрелка, галочка на листе)
- Ментальные картинки (представить себе, как телефон лежит на столе, когда уходишь из дома)
- Жест как сигнал (например, клиент делает жест рукой → напоминает себе «соберись»)
- Ассоциация



КПТ СДВГ

3. Мнемоника - заучивание реплик или мнемотехники может быть полезным методом усиления информации для последующего запоминания и может показаться менее подавляющим для человека с РДВГ. Например, С.Т.О.П. = сосиски, томаты, оливки, петрушка (список в магазин).



КПТ СДВГ

Мнемоника — это классическая когнитивная стратегия, которая отлично подходит клиентам с РДВГ, поскольку:

- **помогает закреплять информацию в долговременной памяти,**
- **делает скучные данные более «яркими» и дофаминергически привлекательными,**
- **переводит абстрактное в образы, истории, рифмы, что удерживает внимание.**



Основные формы мнемоники:

- **Акронимы** (первые буквы слов образуют запоминающееся слово: например, SMART для постановки целей).
- **Рифмы и ритмы** (короткая фраза в стихотворной форме: «Тридцать дней — у сентября...»).
- **Визуальные образы** (ассоциация слова с яркой картинкой).
- **Метод локусов** («дворец памяти»: каждый элемент информации кладётся в знакомое место в воображаемом пространстве).
- **Истории и нарративы** (соединение разрозненных элементов в сюжет).
- **Числовые и телесные привязки** (например, список покупок «раскладывается» по пальцам).



4. Интервальное извлечение информации - исследования памяти показали, что постепенное увеличение промежутка времени между извлечениями увеличивает вероятность того, что информация будет извлечена в будущем, и, таким образом, улучшает запоминание за счет усиления следа в памяти. Информацию следует повторять с увеличивающимися интервалами, например, 5 минут, 30 минут, час, на следующий день и т.д. Можно тренировать это упражнение на протяжении всей сессии и после это может позволить человеку с РДВГ повысить свою самооффективность.



КПТ СДВГ

5. Решение проблем - хороший метод поиска потерянных или затерявшихся вещей – это систематически мысленно повторять пройденные шаги. Это можно сделать, задав клиенту последовательность вопросов, таких как "когда у меня в последний раз были ключи?", "куда я пошел, когда вошел?" или "куда бы я положил этот ключ сейчас?".



КПТ СДВГ

6. Сохраняем спокойствие - высокое эмоциональное возбуждение и чувство стресса могут влиять как на внимание, так и на работу памяти, поэтому важно побудить клиента уменьшить беспокойство и гнев прежде чем пытаться что-либо вспомнить.



КПТ СДВГ

ГЛУБИННЫЕ СИМПТОМЫ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ



КПТ СДВГ

Тайм-менеджмент это ахиллесова пята взрослых с РДВГ. Людям с РДВГ труднее, чем другим, управлять своим временем из-за проблем с концентрацией внимания, из-за которых они не могут сосредоточиться на поставленной задаче. Они легко отвлекаются на другие, казалось бы, более важные или интересные занятия.

Расстановка приоритетов особенно сложна, поскольку люди с РДВГ склонны переходить от задачи к задаче, независимо от ее важности. У них часто на ходу много проектов, и все они находятся на разных стадиях завершения.

Люди с РДВГ очень спонтанны и инициируют множество проектов с добрыми намерениями, но их неорганизованный хаотичный личный стиль приводит к тому, что они не доводят это до конца.



КПТ СДВГ

Часто возникают трудности с соблюдением сроков и поддержанием интереса к завершению проекта. Это может быть особой проблемой для более рутинных задач, которые необходимы, но скучны.

Из-за их неспособности эффективно организовывать время и склонности попадать в "ловушки траты времени впустую" их часто считают "предпринимателями-неудачниками".

Аналогия заключается в том, что люди с РДВГ пытаются удержать в воздухе слишком много мячей одновременно, но в конечном итоге роняют большинство из них.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ добиваются большего, когда для них организуется структура времени. Трудность заключается в том, чтобы установить это для себя и управлять этим. Таким образом, цель сессий тайм-менеджмента состоит в том, чтобы научить человека правильно структурировать свое время, расставлять приоритеты в задачах и вознаграждать себя за успех.

Успех становится позитивным подкреплением достижений. Лучший способ сделать это - использовать методичный подход и убедиться, что клиент придерживается его. Это усиливает целеустремленность.



КПТ СДВГ

Людам с РДВГ может казаться, что время всегда работает против них. Оно либо течет слишком медленно, когда они чувствуют скуку и разочарование, либо слишком быстро, когда они увлекаются чем-то интересным или приносящим немедленное удовлетворение.

Время летит быстро, когда их внимание ускользает - это означает, что они легко отвлекаются и могут начать грезить наяву. Конечным результатом является то, что они часто опаздывают, не достигают или не завершают задачи и упускают возможности. Поэтому терапевту и клиенту необходимо установить общее понимание того, как клиент воспринимает время.



КПТ СДВГ

Время следует рассматривать как ресурс, который используется для достижения поставленных целей. Время - это инструмент.

Если клиенты удовлетворены тем, как они проводят свое время, и чего они достигают за это время, то это усилит потребность в структуре. Таким образом, важно поощрять клиентов находить то, что им нравится во всем, что они делают. Это может включать в себя "высвобождение времени" для объединения приятных занятий и рутинных задач.



КПТ СДВГ

Для оценки проблем со временем можно использовать опросник.

Как часто вы...	Никогда	Редко	Иногда	Часто	Постоянно
Планируете свое время?	4	3	2	1	0
Прописываете свой план?	4	3	2	1	0
Завершаете все, что запланировали на день?	4	3	2	1	0
Прерываетесь на задачи, которые кажутся важными?	0	1	2	3	4
Оставляете задачи не выполненными?	0	1	2	3	4
Забываете, что должны были выполнить?	0	1	2	3	4
Приходите вовремя и готовитесь к встречам?	4	3	2	1	0
Знаете точно, который сейчас час?	4	3	2	1	0
Чувствуете, что тратите время впустую?	0	1	2	3	4



В дополнение к оценке тайм-менеджмента, описанной в опроснике, будет полезно определить, как человек на самом деле проводит свое время, прежде чем приступить к изучению стратегий тайм-менеджмента.

Это достигается путем ведения журнала действий с использованием еженедельной записи в дневнике. Следует попросить клиента составить карту на сессии, что он делал в недавнем прошлом, например, за последние два дня. Затем клиента просят завершить оставшуюся часть доследующей сессии и обсудите. Это поможет определить, сколько времени тратится с пользой и конструктивно на выполнение задач, и выделить проблемные моменты, когда клиент подвержен ловушкам траты времени, например, чтение нежелательной почты, длительные разговоры по телефону, поиск потерянных вещей, опоздание на поезд, серфинг в Интернете.



КПТ СДВГ

Время, в течение которого клиент обычно принимает лекарство, также должно быть зафиксировано, поскольку важно установить взаимосвязь между приемом лекарства и его влиянием на концентрацию внимания (здесь мы говорим про стимуляторы).

Журнал активности поможет терапевту понять, как клиент на самом деле проводит свое время, и это следует использовать в качестве основы для обсуждения. Клиент может быть удивлен, увидев, сколько времени он проводит вне работы. Легко забыть, сколько времени тратится на чтение нежелательной почты, поиск потерянных вещей, опоздание на поезд, и т.д. Изучив свой дневник активности, клиент может увидеть, что он был довольно хаотичен в организации своего времени.



КПТ СДВГ

Дневник активности

Время	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
7-8 утра	спал						
8-9 утра	спал						
9-10 утра	Чувствовал себя очень уставшим чтобы сделать завтрак						
10-11 утра	Принял лекарства, смотрел телевизор						
11-12 утра	Смотрел телевизор						
12-13 утра	Говорил по телефону						
...							



КПТ СДВГ

Для того, чтобы быть эффективным, клиент должен составлять план временной активности. Для этого нужно выполнить 6 шагов:

1. Поставить задачи
2. Сделать список
3. Определить приоритет деятельности
4. Оценить необходимое время для выполнения задачи
5. Планирование задачи
6. Внедрить систему вознаграждения



Необходимо поощрять клиента к определению поставленных целей в течение определенного периода времени. На сессии клиент должен перечислить действия, которые должен выполнить в течение недели, а также действия, которые он хотел бы выполнить.

Следующий шаг - расставить приоритеты в задачах. Определение приоритетов деятельности, скорее всего, потребует помощи терапевта на начальном этапе, до тех пор, пока клиент не разовьет или не улучшит эти навыки. Этого можно достичь, попросив клиента присвоить рейтинг важности, например, насколько важно, чтобы счет был оплачен на этой неделе от (0) - "совсем нет" до (4) - "существенно".



КПТ СДВГ

Затем клиент должен оценить количество времени, которое займет выполнение каждой задачи. Это может потребовать некоторой практики, поскольку клиенту и терапевту нужно будет совместно определить, имеет ли клиент тенденцию постоянно переоценивать или недооценивать время. На этом этапе клиент должен быть готов составить график выполнения задач в течение определенного периода времени.

При составлении временного плана важно изучить "планы на случай непредвиденных обстоятельств", поскольку некоторые важные задачи могут быть перегружены.



КПТ СДВГ

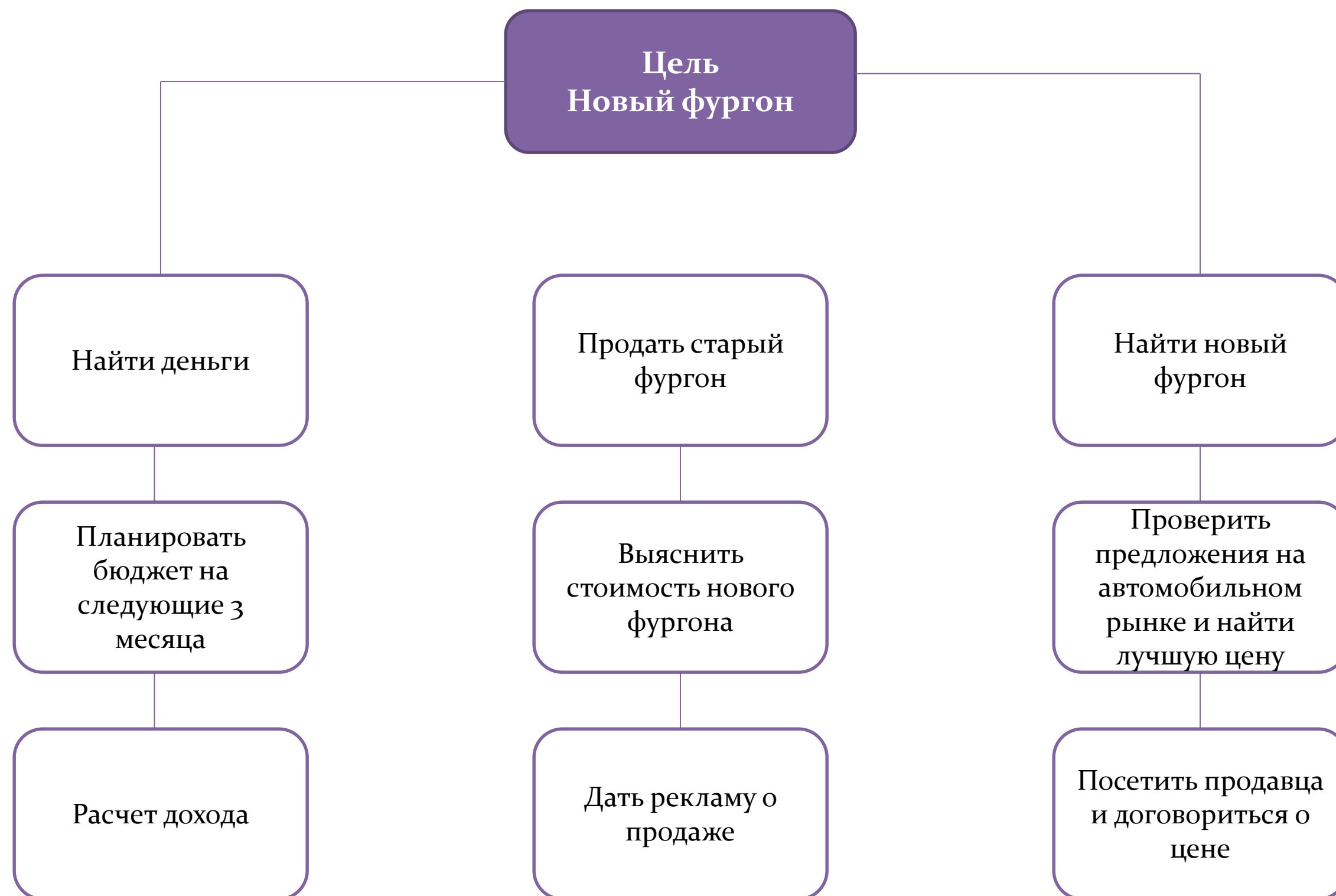
Заключительным шагом является внедрение системы вознаграждения за успешное завершение задачи в заданный период времени. Это может быть перерыв в выполнении сложной задачи или переключение на более приятную задачу с меньшим приоритетом на определенный период.



Шаг 1: постановка целей

Терапевт должен поощрять клиента регулярно ставить и пересматривать цели, поскольку это поможет клиенту достичь того, чего он хочет достичь в жизни. Клиенты должны учитывать свои масштабные и долгосрочные цели. К ним относятся карьера, образование, семья, финансы - социальные, физические цели и цели, связанные с получением удовольствия.

Однако клиент **должен научиться** разбивать эти общие цели на более мелкие достижимые "мини-цели", которые представляют собой ступеньки к достижению общей цели. Это обеспечит краткосрочную сосредоточенность и мотивацию в дополнение к побуждению клиента обращать внимание на долгосрочную перспективу. Важно сосредоточиться на конкретных задачах, поскольку это поможет клиенту организовать свои ресурсы.





Шаг 2: создание списка

Затем клиент и терапевт должны составить исчерпывающий список того, чего необходимо достичь, например, на предстоящей неделе.

Список должен включать:

- Что нужно сделать клиенту для достижения этапа(ов), на котором он сосредоточен
- То, что клиент действительно хочет сделать
- Вещи, которые он должен сделать
- Вещи, которые он мог бы сделать, если бы у него было время
- Вещи, которые он ненавидит сделать, но которые необходимы



КПТ СДВГ

Списки должны быть составлены, когда это возможно, чтобы избежать траты ценной умственной энергии на репетиции и напоминания себе о задачах. Это само по себе может отвлекать. Гораздо эффективнее создать письменный документ. Это гораздо более мотивирует, поскольку может использоваться как внутри сессий, так и самостоятельно за их пределами. Действительно важно включить в список виды деятельности, которые нравятся клиенту.



КПТ СДВГ

Списки не обязательно должны быть рутинной работой!

Перечисление рутинных или неинтересных задач, которые необходимо выполнить, будет скучным и непривлекательным. Клиент будет не мотивирован и не достигнет своей общей цели. Составление "списка дел" служит дополнительной цели - сформировать чувство контроля и удовлетворения, поскольку действия координируются в одном месте. Это позволяет избежать ощущения подавленности или того, что дело клиента требует бесконечных затрат.

Устанавливая структуру и порядок, клиент может логически связать задачи, увидеть, как они способствуют достижению общей цели, и интегрировать их с желаемыми видами деятельности. Это уменьшит чувство паники и беспокойства.



КПТ СДВГ

Например, если целью является подача заявления о приеме на работу, список может включать:

1. Понедельник - сходить в центр занятости
2. Вторник - получить соответствующие формы заявлений по телефону или письменно
3. Среда - заполнить личные данные в анкетах для подачи заявки
4. Четверг - заполнить предыдущие данные о работе в анкете для подачи заявления
5. Пятница - указать в анкете причины, по которым вы хотите получить соответствующую работу
6. Суббота - попросить друзей или члена семьи просмотреть формы заявок и оставить отзыв.
7. Воскресенье - внесите изменения в формы заявок, перепечатайте и отправьте.



Шаг 3: определение приоритета деятельности

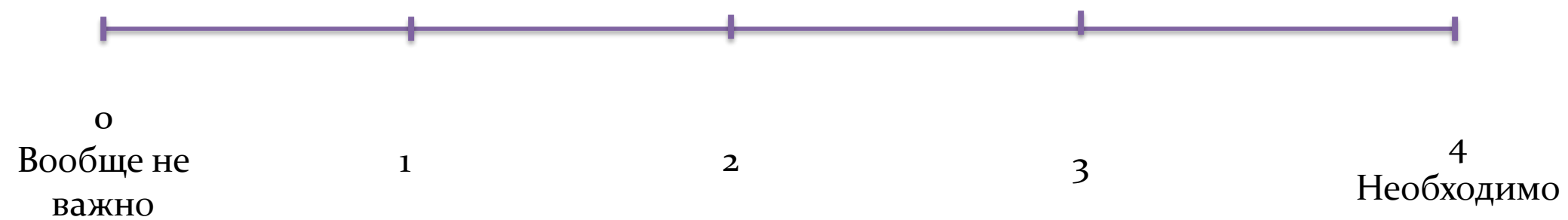
Маловероятно, что все, что указано в полном списке шагов, будет выполнено за отведенное время. Поэтому важно расставить приоритеты, поскольку очень легко потратить много времени на выполнение небольшой работы, которая на самом деле не продвигает клиента вперед к своим целям или повысит качество жизни клиента. Расставление приоритета заставляет клиента задавать себе следующие вопросы:

- Что ДОЛЖНО быть сделано на этой неделе?
- Что может подождать и как долго?
- Что я ХОЧУ сделать на этой неделе?
- Что случится, если я этого не сделаю?



КПТ СДВГ

Насколько важно выполнить эту задачу на следующей неделе?



Насколько важно сходить на игру в футбол в воскресенье?



КПТ СДВГ

Для каждой задачи клиент должен оценить, насколько важно выполнить эту задачу в течение установленного периода (т.е. дня, недели, месяца). Например, если цель клиента - как можно быстрее устроиться на работу, поскольку он безработный, ему следует задать определенные вопросы, показанные на рисунке ранее.

Для клиентов, которые считают, что шкала Лайкерта недостаточно чувствительна, чтобы помочь выявить тонкие приоритеты, им может быть более полезно присвоить процентную оценку (в диапазоне от 0% - "совсем не важно" до 100% - "существенно").



КПТ СДВГ

Следует иметь в виду характеристики, выявленные и изученные из дневника активности, полученного в начале этих сессий и до вмешательства. Это даст полезные подсказки о том, как клиенты естественным образом проявляют себя; то есть какое лучшее время суток для выполнения работы, требующей концентрации, физической активности и периодов отдыха. Это также даст подсказки о вероятных отвлекающих факторах и препятствиях для достижения поставленных задач.



КПТ СДВГ

Предупрежден - значит вооружен, поэтому задания следует выполнять, готовясь к отвлекающим факторам и препятствиям и разрабатывая план, как избежать искушений.

После того как элементы были расставлены по приоритетам, их следует ранжировать в порядке важности. Затем эти действия могут быть запланированы на то время, когда человек сможет выполнять их на оптимальном уровне.

Умение расставлять приоритеты - это навык, который необходимо развить клиенту. Он должен быть смоделирован и отрепетирован на сессиях, например, с использованием повестки дня и определения приоритетов текущей работы.



КПТ СДВГ

Клиенты могут неохотно расставлять приоритеты в задачах и считать это занятие пустой тратой времени, поскольку они предпочитают решать проблемы по мере их возникновения.

Отсутствие контроля над импульсами должны быть признаны и обсуждены на занятиях. Только после того, как клиент включится в процесс, он поймет, что вовлечение в процесс расстановки приоритетов требует времени, но это хорошее использование времени. Оно выполняет ценную функцию и приводит к положительным результатам. Как и все новые навыки, этот процесс нужно практиковать до тех пор, пока он не станет привычным.



Шаг 4: Оценка необходимого времени для выполнения задачи

Затем клиент должен оценить сколько времени, по его мнению, потребуется для выполнения каждой задачи. Например, чтобы посетить терапевта:

1. Позвонить в приемную терапевта и оформить запрос – 5 минут
2. Подъехать к кабинету терапевта и припарковаться – 10 минут
3. Подождать на стойке регистрации – 10 минут
4. Поехать домой – 15 минут

Составляя свой план, человеку также нужно учитывать время для непредсказуемых обстоятельств, такие как пробка на дороге, трудности с поиском парковочного места, опоздания и пр. Лучше переоценить и преуспеть, чем недооценить и потерпеть неудачу.



КПТ СДВГ

Восприятие времени искажено у взрослых с РДВГ. Обычно для человека с РДВГ время проходит быстро, например, 10 минут могут ощущаться как две, поэтому трудно составить временной план, который точно отражал бы все, что нужно сделать за ограниченный промежуток времени.

Почти наверняка это гарантирует неудачу, оставляя огорченного клиента с чувством незаинтересованности, разочарования, подавленности, беспокойства о незавершенных задачах и без мотивации возобновлять их в другой день.

Чтобы избежать этого негативного подкрепления, очень важно точно оценить, **сколько времени потребуется** для выполнения задания.



Во-первых, общее восприятие времени клиентом можно определить, попросив его выполнить комплекс упражнений (см. следующий слайд). Конечно, эти упражнения могут быть изменены по мере необходимости, поскольку важно, чтобы они соответствовали образу жизни каждого клиента. Сначала клиент подсчитывает, сколько времени ему потребуется, чтобы выполнить задание, а затем засекает время, чтобы посмотреть, насколько точно он рассчитал время (в качестве домашнего задания). Этот поведенческий эксперимент может быть расширен за счет того, что клиент определяет время выполнения определенных задач другими людьми.



КПТ СДВГ

Активность: как много времени это займет?	Расчётное время клиента	Фактическое время клиента
Принять душ и высохнуть	2 мин	8 мин
Одеться утром	3 мин	5 мин
Сделать чашку чая	1 мин	3 мин
Пойти в парикмахерскую	20 мин	30 мин
Поменять постельное белье	5 мин	15 мин
Помыть пол на кухне	5 мин	15 мин
Почитать новости	20 мин	40 мин



Это упражнение поможет клиенту осознать, до какой степени он постоянно искажает периоды времени, и выяснить, сколько времени на самом деле занимают обычные действия, такие как поход по магазинам, глажка одежды и т.д.

Важно определить общую черту клиента в оценке времени (т.е. склонны ли они переоценивать или недооценивать - скорее всего, последнее), чтобы можно было внести соответствующие коррективы в временной план. Однако при составлении временного плана некоторые задачи, очевидно, будут новыми, и в этом случае клиентов всегда следует поощрять выделять дополнительное время для их выполнения их. Незапланированные промежутки времени, то есть свободное время, рассматриваются как дополнительное вознаграждение за успешное выполнение заданий.



Шаг 5: Планирование задачи

Следующим этапом является упорядочение задач или мероприятий путем составления и систематизации временного плана.

В зависимости от индивидуальных предпочтений, приоритетные задачи могут быть организованы в соответствии с конкретными склонностями клиента. Некоторые люди предпочитают сначала выполнить самую сложную задачу, чтобы избавиться от нее, другие предпочли бы мягко облегчить себе задачу.

Время суток также может быть важным фактором. У большинства людей после обеда наблюдается снижение уровня энергии, поэтому рекомендуется избегать занятий, требующих особой умственной нагрузки, в этот период.



Кроме того, при составлении временного плана важно равномерно распределить день по приятным и неприятным занятиям.

Некоторые виды деятельности будет трудно точно запланировать (особенно новые виды деятельности, сроки завершения которых трудно оценить). Необходимо запланировать время на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы учесть задачи, которые перегружены, и/или непредвиденные задачи, возникающие в течение дня. Однако, когда это происходит, **важно различать разницу между подлинным неожиданным событием, которое является приоритетным, и идеей, которая приходит на ум и отвлекает от рутинной задачи.** Нерелевантные отвлекающие факторы должны обсуждаться на сессиях, чтобы клиент мог распознать их, когда они возникают, и отвергнуть как ловушки для траты времени, представляющие собой препятствия на пути клиента к достижению его еженедельных целей.



КПТ СДВГ

Однако идеи и инициативы следует не отбрасывать, а временно отложить в сторону, отметив их для включения в будущий комплекс мероприятий и/или временной план.

Креативность - это не тот ресурс, который нужно подавлять.

Далее в таблице показан временной план, разработанный на сессии с клиентом. Конкретными целями клиента на неделю были - привести в порядок свои финансы, устроиться на работу, получить повторный рецепт и записаться на курсы штукатуров. На этой неделе клиент также захотел поиграть в футбол в субботу, навестить родителей и выяснить стоимость продажи фургона.



КПТ СДВГ

1) Поставленные цели

- Организация финансов
- Получение работы
- Получение рецепта на лекарства
- Запись на курсы штукатуров

2) Список дел

- Разработать бюджет на 3 месяца
- Оплатить задолженности
- Посетить банк
- Уточнить стоимость фургона
- Просмотреть предложения по продаже фургона
- Пойти в центр занятости
- Просмотреть объявления о работе
- Обзвонить знакомых по поводу работы
- Заполнить формы о приеме на работу
- Попросить сестру проверить формы



КПТ СДВГ

- Записаться к врачу
- Пойти за рецептом
- Пойти в аптеку и купить лекарства
- Поискать курсы штукатуров
- Записаться на курс
- Навестить родителей
- Поиграть в футбол
- Пойти куда-нибудь с друзьями



КПТ СДВГ

3) Расстановка приоритетов

- Распределить бюджет на 3 месяца – 4
- Заплатить просроченные счета – 4
- Пойти в центр занятости – 4
- Записаться к врачу – 4

- Позвонить друзьям по поводу работы – 3
- Просмотреть предложения по работе – 3
- Заполнить формы – 3
- Попросить сестру проверить формы – 3
- Пойти к врачу за рецептом – 3
- Пойти в аптеку – 3
- Посетить банк – 3
- Поискать курсы штукатуров – 3
- Записаться на курс – 3

- Повидать родителей – 2
- Поиграть в футбол – 2

- Поискать цены на фургоны – 1
- Пойти куда-нибудь с друзьями – 1
- Сходить по объявлению о продаже фургона – 1



КПТ СДВГ

4) Оценка времени для выполнения задачи

- Распределить бюджет на 3 месяца – 3 часа
- Заплатить просроченные счета – 3 часа
- Пойти в центр занятости – 4 часа
- Записаться к врачу – 5 минут

- Позвонить друзьям по поводу работы – 30 минут
- Просмотреть предложения по работе – 6 часов
- Заполнить формы – 5 часов
- Попросить сестру проверить формы – 2 часа
- Пойти к врачу за рецептом – 45 минут
- Пойти в аптеку – 5 минут
- Посетить банк – 1 час
- Поискать курсы штукатуров – 1 час
- Записаться на курс – 1 час

- Повидать родителей – 3 часа
- Поиграть в футбол – 3 часа

- Поискать цены на фургоны – 2 часа
- Пойти куда-нибудь с друзьями – 5 часов
- Сходить по объявлению о продаже фургона – 4 часа

Шаг 6: Внедрение системы подкрепления

Запланированные перерывы и вознаграждения являются жизненно важной частью тайм-менеджмента для людей с РДВГ, и они, скорее всего, будут исключены из запланированного расписания. Крайне важно планировать перерывы и вознаграждения так же тщательно, как и время на выполнение заданий, поскольку они дают время расслабиться и освежиться, чтобы переориентировать внимание. Дополнительная функция заключается в том, что они обеспечивают клиенту положительное подкрепление путем вовлечения в приятную деятельность.

Распространенной проблемой для людей с РДВГ является то, что они не делают достаточного количества запланированных перерывов, особенно когда задания интересные, что приводит к усталости. Внимание ослабевает, когда люди устают, и новые, легкомысленные задачи могут казаться более привлекательными и приносящими вознаграждение. В таких обстоятельствах люди с РДВГ часто застревают на задаче, отвлекающей внимание, в результате чего становится невозможным вернуться к первоначальному (теперь уже скучному) заданию.



КПТ СДВГ

Необходимо оценить продолжительность времени, в течение которого клиент может сосредоточиться, и она будет варьироваться в зависимости от индивидуальных различий.

Как правило, перерывы следует назначать по крайней мере каждый час, но это необходимо протестировать, оценить и скорректировать соответственно. Клиентам лучше прерваться в "критический момент" в середине выполнения задачи, так как это повышает интерес и мотивацию и облегчает возвращение к задаче позже. Вознаграждение может заключаться просто в перерыве в разговоре с коллегой или в том, чтобы побродить по офису (местным магазинам или отправиться на прогулку) в течение пяти минут. Дело в том, что человек должен быть отстранен от выполнения задания.



КПТ СДВГ

Более ощутимым вознаграждением может быть приготовление чашки чая/кофе, шоколадного печенья, просмотр телевизора, звонок другу, поход по магазинам и т.д. Вознаграждение должно быть желанным и доставлять удовольствие, иначе оно становится отталкивающим стимулом, которого следует избегать, и, таким образом, оказывает негативный эффект.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ нуждаются в немедленном краткосрочном вознаграждении, а не заставляют себя ждать большого вознаграждения по завершении длительного проекта. Например, некоторые предпочли бы вознаградить себя остатками пиццы, чем отпраздновать завершение проекта походом в отличный ресторан. Как только небольшие вознаграждения будут включены во временной план, можно будет внедрить систему, в соответствии с которой небольшие вознаграждения учитываются при получении большего вознаграждения в долгосрочной перспективе.

Таким образом, клиенту необходимо научиться организовывать систему, при которой несколько небольших вознаграждений в долгосрочной перспективе перерастают в более крупное, например, выполнение всех задач в течение дня (включая задания с приятным вознаграждением) приводит к "большому вознаграждению вечером", например, к "потаканию своим желаниям" в течение часа этим вечером.



Варианты вознаграждений

1. Материальные вознаграждения – стикеры, наклейки, жетоны (особенно у детей и подростков), маленькие сувениры (брелок, канцелярия, маленькая игрушка), «бонусное время» (игра, телефон, видео), небольшие вкусняшки (фрукты, сладости – если уместно).
2. Социальные/эмоциональные – похвала, запись успеха в дневник достижений, совместно фото с отметкой прогресса, разделение успеха с важным человеком.
3. Поведенческие – время на любимое занятие, «бонус-активность» на сессии (5 минут на обсуждение интересной темы), возможность выбрать тему или формат следующей сессии.
4. Система токенов/накопительные вознаграждения – за каждое выполненное задание дается жетон/балл, накопленные жетоны/баллы можно обменять на большую награду, «свободный выбор активности», совместную награду с близким.



КПТ СДВГ

Принципы эффективных вознаграждений:

- Немедленность (лучше сразу после поведения, а не позже)
- Конкретность (четко за что именно клиент получил вознаграждение)
- Малые шаги (большие награды за маленькие успехи удерживают мотивацию)
- Вовлечение клиента (он сам выбирает список вознаграждений, которые для него реально приятны)



КПТ СДВГ

Оценка эффективности

Крайне важно, чтобы сессии включали регулярные обзоры прогресса и оценку успешности. Этого можно достичь путем повторного ведения журнала активности в дневнике, выполнения упражнения по оценке времени и анализа прогресса, достигнутого в достижении целей. Важно давать клиентам положительные отзывы, чтобы ободрить их и повысить самооффективность и уверенность в себе. Клиентов следует поощрять к вознаграждению, вычеркивая задачи из их списков, поскольку это дополнительно обеспечивает систему визуального подкрепления.



Ловушки, отнимающие время

1. Переключение внимания. Ловушки времени - это не просто отговорки, позволяющие избежать выполнения определенных задач. Они могут быть вызваны кратковременной потерей концентрации или рассеянностью, в результате чего человек теряет сосредоточенность и становится озабоченным либо внешними (например, другими задачами) или внутренними (например, фантазирование) стимулами. Это часто приводит к тому, что люди с РДВГ прыгают от задачи к задаче прежде, чем могут закончить хотя бы одну из них и это приведет к более длительному выполнению задачи. Человек может так никогда и не вернуться к задаче и часто оставляет ее незавершенной. Невыполненная задача может застрять в разуме клиента и привести к чувству гнева или раздражения, тревоги или фрустрации. Чтобы предотвратить эту дисфункциональную реакцию, когда у человека возникают внезапные мысли или идеи, необходимо поощрять клиента записывать их, чтобы он мог вернуться к ним позже, вместо того чтобы действовать немедленно.

2. Отсрочка вознаграждения. Как упоминалось ранее, проблема отсрочки вознаграждения связана с переключением внимания и способностью отвлекаться. Было показано, что люди с РДВГ испытывают трудности с отсрочкой вознаграждения для того, чтобы достигнуть долгосрочной цели. Это означает, что они с большей вероятностью выберут краткосрочное, иногда меньшее вознаграждение, чем будут мотивированы ждать долгосрочного вознаграждения. Это систематическое смещение во взаимосвязи между силой вознаграждения и временем может привести к трудностям с управлением временем, поскольку человек легко поддается искушению отклониться от своего первоначального плана из-за соблазна немедленного вознаграждения, хотя и в ущерб достижению долгосрочной цели. По этой причине люди с РДВГ могут с большей вероятностью отказаться от выполнения какой-либо задачи, например, выполнить более длительную работу, которая занимает 10 часов и за которую им заплатят 10000 рублей, и они отвлекутся на более непосредственное вознаграждение, например, получат 1000 рублей за трехчасовую работу.



КПТ СДВГ

Чтобы избежать отсрочки вознаграждения, терапевту необходимо определить, является ли вознаграждение высокомотивирующим, а также пропорционально ли количеству времени, затраченного на выполнение задания. Например, нужно проверить, является ли перерыв на кофе подходящим вознаграждением за час работы и является ли он достаточной мотивацией для клиента продолжать работать до конца дня. Для некоторых людей перерыв на кофе может быть предлогом для того, чтобы отвлечься от выполнения задания.

3. *Поведение, направленное на поиск удовольствия.* Некоторые клиенты жалуются, что из-за расписания мероприятий их дню не хватает спонтанности и волнения. В таких случаях возникает еще большая необходимость предусмотреть в плане времени конструктивные перерывы (либо для запланированных вознаграждений, либо для свободного времени для спонтанных занятий). Таким образом, вознаграждение должно соответствовать физическим и психологическим потребностям клиента. Это означает включение исключительных индивидуальных креативных и стимулирующих заранее определенных просоциальных вознаграждений. Это не должно вызывать беспокойства, поскольку размер вознаграждения обычно определяется клиентом. Долгосрочное вознаграждение может включать конкурентные виды спорта или различные варианты активности (банджи-джампинг, картинг и другие).

4. Прокрастинация. Люди с РДВГ чрезвычайно искусны в прокрастинации. Они искусны в рационализации дисфункциональных убеждений, интеллектуализации и игре в "адвоката дьявола". Обычно прокрастинация выполняет функциональную роль, поскольку позволяет избежать неприятной задачи. Однако она также может быть связана с недостатком уверенности в себе, поскольку люди с РДВГ установили для себя слишком высокие стандарты или были нереалистичны в отношении того, чего они могут достичь. Это особая проблема для людей, склонных к перфекционизму, которые никогда не могут оправдать своих собственных ожиданий. Отдельным людям нужно признать, что, устанавливая строгие стандарты достижений, они обрекают себя на неудачу. Избегание рутинных (но часто необходимых) задач также может стать проблемой, поскольку они воспринимаются как скучные. Клиенту следует подумать о том, нужно ли выполнять все кажущиеся непреодолимыми скучные задачи за один раз или можно разбить такие задачи на более мелкие, чтобы сделать их менее рутинными.



Работа с прокрастинацией

На практике взрослые с РДВГ сообщают, что прокрастинация является одним из наиболее частых их недостатков. Такое поведение, как правило, является неадаптивным (нерациональная задержка, несмотря на негативные последствия), а не стратегическим выбором. Прокрастинация, связанная с РДВГ, часто служит для того, чтобы избежать стресса или неприятных задач. Например, взрослые с РДВГ обычно откладывают выполнение домашних или служебных задач, чтобы избежать беспокойства или скуки, даже если они знают, что позже все станет только хуже.



КПТ СДВГ

Прокрастинация при РДВГ обычно включает в себя избегание сложных задач, а не «активное» откладывание. Это, как правило, сопровождается чувством вины, тревоги или поражения, а не продуктивностью. Часто сопровождается стремлением отвлечься в поисках острых ощущений: многие люди, страдающие РДВГ, импульсивно переключаются на более стимулирующие занятия (например, видеоигры) вместо запланированного задания. Со временем хроническая прокрастинация при РДВГ приводит к негативным последствиям (плохие оценки, проблемы с работой, низкая самооценка).

Ключевые стратегии работы с прокрастинацией:

- Психообразование: рассказываем клиенту о том, как РДВГ влияет на внимание и мотивацию. Объясняем цикл прокрастинации: невнимательность → переживания неудач → негативные убеждения → избегание. Объясняем, что прокрастинация - это симптом РДВГ, а не лень. Это подготовит почву для перемен.
- Когнитивная реструктуризация: выявляем негативные автоматические мысли (например, «я всегда никогда не справляюсь с заданиями») и бросаем им вызов. Используем технику СТОП (Stop–Think–Modify), чтобы прервать пораженческие мысли, прежде чем действовать. Например, терапевт может научить клиента делать паузу, когда он думает: «Я никогда не закончу это», переоценить доказательства и заменить их адаптивной мыслью («Я могу попробовать сделать один шаг сейчас и обратиться за помощью, если потребуются»). Это уменьшает избегание, вызванное страхом или низкой самооценкой.



КПТ СДВГ

- Обучение навыкам (организация и планирование): создание конкретных внешних инструментов. Основополагающий навык КПТ заключается в объединении всех задач в единую централизованную систему. Например, терапевты помогают клиентам составить единый календарь и общий список дел. Они поощряют ежедневный просмотр: клиента учат проверять этот ежедневник/список задач каждый день (например, каждое утро), чтобы быть в курсе крайних сроков. Это помогает избежать забывчивости и перегрузки. Затем задачи разбиваются на небольшие конкретные этапы (например, “Для отчета: день 1 – общий план; день 2 – первый абзац...”) и расписываются по времени.



- Обучение тайм-менеджменту: используем структурированное планирование. Внедряем процедуры (например, «стратегию распределения задач по блокам» или таймеры Pomodoro), чтобы планировать рабочие периоды и перерывы. Включаем напоминания / будильники в телефоны или приложения. Например, терапевт предложить пройти практику во время сессии: клиент в буквальном смысле вводит задания в цифровой календарь во время сеанса. Этот живой коучинг запускает систему.



- Решение проблем во избежание прокрастинации: когда задача постоянно откладывается, учим клиента формальному решению проблем. Терапевт помогает клиенту сформулировать заблокированную проблему, провести мозговой штурм и выбрать одно из решений. Например, если «написания письма начальнику» всячески избегают, специалист помогает разбить это на решаемые подзадачи (например, что конкретно в этом является трудным) и совместно разрабатывает шаги, которые позволят сделать это выполнимым.



КПТ СДВГ

- Поведенческая активация: включайте мотивацию, сочетая выполнение заданий с вознаграждением. В методах КПТ для лечения РДВГ часто используются методы поведенческой активации для повышения вовлеченности. Это может означать планирование коротких, интересных заданий вперемежку с обязательными и немедленное вознаграждение. Например, договоритесь о том, что после 15-минутной работы над домашним заданием клиент сделает небольшой приятный перерыв. Подчеркните ценности (“как выполнение этого задания будет способствовать достижению ваших целей?”), чтобы повысить внутреннюю мотивацию.



КПТ СДВГ

- Изменение окружающей среды: уменьшаем количество отвлекающих факторов на рабочем месте. КПТ учит перестраивать свое физическое окружение (например, чистый стол, заблокированные социальные сети во время работы) и формировать привычки (например, всегда упаковывать материалы на следующий день накануне вечером). Даже небольшие изменения (выставление учебных материалов на всеобщее обозрение, перенос телефонов в другую комнату) могут противодействовать склонности мозга с РДВГ к искушению.



КПТ СДВГ

- Самоконтроль и обратная связь: попросите клиента отслеживать попытки и успехи. Например, ведите краткий ежедневный журнал «Что я намеревался сделать в сравнении с другими» и «что я сделал», отмечая чувства и триггеры. Это повышает осведомленность о моделях прокрастинации и свидетельствует о постепенном прогрессе.



Терапевты должны использовать активный стиль решения проблем. Методы включают в себя:

- Совместный эмпирический подход: работайте вместе с клиентом над выявлением конкретных моделей прокрастинации и постановкой конкретных целей (например, «Мы увеличим время занятий с 0 до 15 минут в день»). Это расширяет возможности клиента и проясняет цели.
- Тренировка навыков во время сессии: по возможности выполняйте задания во время сессии. Например, как предлагается в одном руководстве по КПТ, терапевт может попросить клиента завести календарь или список дел во время сеанса. Это придает импульс и моделирует процесс; клиент покидает сессию, уже отработав ключевую стратегию.
- Домашняя работа с ответственностью: назначайте соответствующие домашние задания на каждую неделю (например, «ежедневно пользуйтесь ежедневником, а затем отмечайте все пропущенные задания»). Просмотрите домашнее задание на следующей сессии, чтобы усилить соблюдение требований. Это позволяет клиенту быть более ответственным.



КПТ СДВГ

- Можно привлечь «человека поддержки» (родителя, друга или тренера), который будет напоминать клиенту о домашних заданиях и занятиях.
- Позитивное подкрепление: активно хвалите маленькие победы (например, «Отлично справляетесь с этим заданием вовремя два дня подряд»). Подкрепляйте усилия и стратегию, а не только результаты. Это повышает мотивацию и самоэффективность.
- Устраните сопутствующие проблемы: выявите тревогу или депрессию, которые могут лежать в основе избегания. Если таковые имеются, примените краткие методы КПТ для улучшения настроения (например, планирование приятных занятий, навыки снижения тревожности), поскольку их устранение может уменьшить избегание.



5. Ложная занятость. Основная ловушка времени - это то, что можно назвать «ложной занятостью». Это когда человек порхает туда-сюда, обычно выглядя очень занятым (или заранее занятым), в то время как на самом деле эта "занятая пчелка" тратит впустую много времени, занимаясь неконструктивной деятельностью. Весь день можно заполнить общением у кофемашины, телефонными звонками, серфингом в Интернете, ответами на неважную почту и т.д. Ложную занятость можно определить, изучив журнал ежедневных действий, записанный до проведения мероприятий по управлению временем. Это должно быть обсуждено на сессиях, должен быть согласован "план профилактики рецидивов", чтобы избежать попадания в эту ловушку.



КПТ СДВГ

Некоторые из клиентов описывают, что, даже когда они тщательно составили свои планы и намерены сделать все в течение дня, им все равно очень трудно достичь этого, поскольку они забывают, что они должны делать, и в конечном итоге опаздывают на встречи и забывают о задачах.

Некоторые люди гиперкомпенсируют и прибывают на встречи неоправданно рано, чтобы быть уверенным, что они не опоздают. В таких случаях люди неизбежно тратят время на ожидание встречи, которое можно было бы использовать более продуктивно.

Эти проблемы с управлением временем связаны с предполагаемыми трудностями с памятью, то есть со способностью помнить, что нужно что-то сделать в будущем. Это можно рассматривать как дефицит в исполнительном функционировании, поскольку оно тесно связано со способностью к планированию, которая, как было показано, нарушена у взрослых с РДВГ.



КПТ СДВГ

Как только мысленный план составлен, определенные моменты времени "помечаются" исполнительным процессом функционирования таким образом, что человек примерно в нужный момент получает предупреждение о том, что он должен выполнять какое-либо действие.

Для людей с РДВГ можно заметить, что эта "система оповещения" работает не оптимально, так что им либо в неподходящее время напоминают о том, что они должны что-то делать, что затем становится отвлекающим фактором, либо они не получают внутреннего напоминания до тех пор, пока не становится слишком поздно и они не пропускают событие.



КПТ СДВГ

Лучший способ для людей с РДВГ следить за временем - полагаться на внешние вспомогательные средства, такие как будильники, цифровые часы, сигналы мобильных телефонов и т.д. Эти сигналы могут быть установлены в обычное время каждый день, например, накануне вечером, и включены в распорядок дня. Некоторые персональные системы-органайзеры или мобильные телефоны могут быть запрограммированы на подачу различных звуковых сигналов в зависимости от вида деятельности. Клиентов следует поощрять не просто устанавливать будильник на начало мероприятия, но и планировать время, необходимое для начала подготовки к занятию, например, начинать собирать вещи в 12:00, садиться на автобус в 12:30 и т.д. Такое "раннее предупреждение" также может улучшить внимание, поскольку может усилить возбуждение в головном мозге.



КПТ СДВГ

ГЛУБИННЫЕ СИМПТОМЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ испытывают трудности с решением проблем по многим причинам. Они могут реагировать импульсивно, вместо того чтобы продумать решение и его потенциальные результаты. Они могут излишне беспокоиться о второстепенных, более насущных проблемах и упускать из виду картину в целом. Это означает, что им может быть трудно генерировать варианты решения. Прошлый опыт означает, что они могут быть склонны сосредотачиваться на негативных результатах, поскольку это именно то, чего они привыкли ожидать.

Однако, научившись применять методический подход к решению проблем, можно добиться большего могут быть достигнуты оптимальные результаты. Проблема может быть определена как любая жизненная ситуация или задача, которая требует, чтобы что-то было изменено или решено.



Проблема может быть явной (например, потребность в приспособлении) или внутренней (например, ощущение непривлекательности). Такие препятствия, как новизна, двусмысленность, конфликт интересов или нехватка ресурсов, могут помешать немедленному реагированию или решению быть эффективными. Иногда люди могут начать осознавать, что проблема существует, только когда им несколько раз не удастся достичь желаемой цели, например, устроиться на работу.

Решение - это реакция или паттерн реакций, которые могут быть когнитивными или поведенческими. Решение возникает в процессе решения проблемы и достигает цели решения проблемы. Реализация решения является важной частью процесса решения проблем, поскольку это предполагает реализацию решения в конкретных ситуациях.



КПТ СДВГ

Наконец, решения необходимо оценивать с точки зрения их успешности в достижении поставленных целей. У людей с РДВГ на их способности решать проблемы часто влияют трудности с исполнительным функционированием, например, трудности с организацией и упорядочиванием информации и/или трудности с подавлением доминирующей реакции. Таким образом, их способности к решению проблем ограничиваются основными когнитивными нарушениями, такими как дефицит торможения реакций, рабочей памяти и/или внимания.



КПТ СДВГ

Важно оценить стили совладания клиентов, как адаптивные, так и неадаптивные, поскольку они будут определять соответствующие техники решения проблем, препятствия, с которыми они столкнутся при их внедрении, и их потенциальный успех. Мы поговорим о трудностях при решении проблем, о которых обычно сообщают люди с РДВГ, о их адаптивном функционировании и способах совладания, а также этапах успешного решения проблем. Эта модель представляет собой пятиэтапный процесс, который включает в себя идентификацию и определение проблемы, выработку решений, оценку решений, реализацию выбранного решения и оценку успеха.



1. Трудности при решении проблем

Существует несколько важных областей, вызывающих трудности, включая подавление реакции, рабочую память и внимание. Сбой в тормозном контроле при столкновении с проблемой может привести к тому, что человек с РДВГ отреагирует до того, как будет найдено оптимальное решение.

Трудности с отсрочкой вознаграждения также могут привести к тому, что взрослые с РДВГ выберут короткий путь, то есть решение, приносящее немедленное вознаграждение, вместо реализации долгосрочного решения, которое требует ожидания и больших усилий, но с большим вознаграждением.



КПТ СДВГ

Янг и др. исследовали эти концепции и обнаружили, что люди с РДВГ не увеличивали время планирования и были менее точны по мере увеличения сложности задания в эксперименте. Неспособность увеличить время планирования с увеличением сложности задачи была связана с повышенным уровнем импульсивности, это говорит о том, что нарушение способности к торможению реакции или тенденция действовать с меньшим количеством предварительных размышлений могут привести к неудаче в решении проблемы.



Трудности с рабочей памятью и ухудшение внимания могут повлиять на решение проблем на нескольких этапах у людей с РДВГ. Могут возникнуть трудности в генерировании решений, поскольку человек может быть склонен упускать из виду ранее предложенные идеи и/или отвлекаться. Им может быть трудно запомнить преимущества и недостатки решений, чтобы проанализировать, какое из них с наибольшей вероятностью окажется успешным.

Кроме того, нарушения рабочей памяти могут вызвать трудности у людей с РДВГ при реализации решений, поскольку они могут упустить важные компоненты или перепутать последовательность событий. Например, при решении проблемы продления водительских прав на транспортное средство они могут обратиться в необходимую организацию, не приведя в порядок бумаги, и обнаруживают, что забыли важный документ.



КПТ СДВГ

Сильные и слабые стороны клиента с РДВГ могут помочь терапевту определить области, которые могут потребовать большего внимания. Например, для более импульсивных личностей может оказаться необходимым сосредоточиться на стратегиях, которые предполагают выработку множества решений, чтобы избежать того, чтобы они хватались за первую пришедшую в голову идею разрешения ситуации. С другой стороны, людям, испытывающим трудности с невнимательностью, может потребоваться дополнительная помощь в разработке стратегий для реализации решений, не отклоняясь от запланированного и желаемого курса.



2. Стратегии совладания при РДВГ

Было показано, что взрослые с РДВГ используют неадаптивные стратегии совладания, такие как конфронтация, избегание и менее спланированное решение проблем. То, как взрослые с РДВГ справляются со стрессовыми ситуациями, определяется их когнитивными способностями. Нарушение исполнительных функций может привести к тому, что человеку не хватит гибкости в его способности получать доступ к набору соответствующих стратегий совладания. Например, трудности с контролем импульсов могут привести к тому, что клиенты будут справляться с проблемами, реагируя быстро и не задумываясь; это может означать, что они будут реагировать агрессивно.



С другой стороны, из-за предыдущего неблагоприятного опыта и трудностей с концентрацией внимания некоторые люди с РДВГ могут реагировать на стресс, не признавая проблему или активно избегая ее решения. На стратегии совладания, используемые взрослыми с РДВГ, также может влиять отсутствие интимных, доверительных отношений, поскольку социальная поддержка может выступать в качестве буфера для снятия стресса. Тесные, поддерживающие межличностные отношения дают возможность проконсультироваться по поводу проблемы, получать полезные советы, извлекать пользу из опыта других и извлекать уроки из моделирования успешных и неуспешных механизмов преодоления. Однако наблюдения за адаптивным функционированием могут быть менее доступны для людей, которые вступают в многочисленные краткосрочные межличностные отношения, с трудом поддерживают отношения со знакомыми и старыми друзьями, и у них могут быть напряженные отношения с членами семьи.

Стиль адаптивного функционирования индивида будет определять результат решения проблемы, другими словами, его успех и жизнеспособность. Функциональный стиль совладания обеспечивает контекст для выработки и реализации оптимальных решений. Дисфункциональный стиль совладания может негативно сказаться на качестве и пригодности генерируемых решений и может привести к неправильному принятию решений.

Согласно модели совладания Лазаруса и Фолкмана, стресс зависит от когнитивной оценки человеком ситуации и его восприятия своих ресурсов для борьбы с ней. Они предполагают, что чувство стресса может быть снято как с помощью эмоционально-ориентированного совладания, так и с помощью инструментального решения проблем. Копинг, ориентированный на эмоции, используется, когда целью является управление эмоциями, которые порождаются ситуацией, например, смертью в семье или разрывом отношений. Решение проблем используется в качестве общей стратегии совладания в ситуациях, которые воспринимаются как изменчивые или контролируемые.

Решение проблем может повлиять на чувство контроля человека и изменить его негативную оценку ситуаций. Функциональная реакция на стресс включает в себя способность использовать эмоционально ориентированное совладание и решение проблем в соответствующих ситуациях.

Существуют гендерные различия в вероятности использования стратегий совладания, ориентированных на эмоции или решение проблемы. Женщины с большей вероятностью будут использовать методы совладания, ориентированные на эмоции, в то время как мужчины с большей вероятностью будут использовать методы, ориентированные на решение проблем. Женщины с РДВГ часто испытывают трудности, связанные с эмоциями, такие как тревога и лабильность настроения, которые могут повлиять на их способность справляться со стрессовыми ситуациями. Кроме того, было показано, что женщины-подростки с меньшей вероятностью доверяются сверстникам и пользуются социальной поддержкой, которая является распространенным ресурсом, используемым молодыми людьми.



КПТ СДВГ

С другой стороны, мужчины с РДВГ более склонны к экстернализации, они испытывают стресс и импульсивно реагируют агрессивным или антиобщественным поведением, вместо того чтобы заниматься адаптивным решением проблем.

По этим причинам важно начать лечение с психообразования относительно того, когда каждый тип совладания может быть более подходящим, и довести это до конца, обучая эффективным навыкам и техникам. Если клиент находится в ситуации, которая полностью находится вне его контроля (и терапевту необходимо проверить, подвержено ли это восприятие когнитивным искажениям, таким как катастрофизация), то стратегии, ориентированные на эмоции, могут быть наиболее подходящими для оказания помощи клиенту управлять своими чувствами. Это может включать в себя простое консультирование или разговор, но могут распространяться и на стратегии, ориентированные на настроение. Однако ситуации, которые находятся под контролем отдельного человека, могут быть разрешены с помощью пятиэтапной модели решения проблем, представленной далее.



КПТ СДВГ

Пятиэтапная модель решения проблем

1. Выявление и описание конкретной проблемы
2. Выработка различных решений проблемы
3. Оценка каждого решения
4. Реализация выбранного решения
5. Оценка успеха

Этап 1: выявление и описание проблемы

Проблемы могут подкрадываться к людям с РДВГ незаметно или возникать внезапно. Они могут быть внешними препятствиями на пути к цели, которые возникают как часть естественного процесса (например, невозможность приобрести материалы для выполнения задачи из-за отсутствия в магазине); они могут быть результатом действий или вмешательства других лиц, как положительных, так и отрицательных (например, коллега по работе заболел на неделю, и клиент должен покрыть его рабочую нагрузку); они также могут быть самогенерируются и накапливается из-за беспокойства (например, мысли "мой босс ненавидит меня", «я безнадёжен на вечеринках"...). Однако клиенту могут потребоваться некоторые подсказки и помощь в выявлении проблемы. Этого можно достичь, задав четыре основных вопроса, чтобы определить, есть ли у человека разрешимая проблема или более общие опасения и волнения.



КПТ СДВГ

Какие это могут быть вопросы:

- Почему это проблема?
- Как это влияет на клиента?
- Можно ли изменить эту ситуацию?
- Что произойдет, если проблема не разрешится?



КПТ СДВГ

Таким образом, частью процесса решения проблемы является **расследование**. Если выяснить как можно больше фактов о проблеме, то это даст клиенту знания для поиска подходящего решения и придаст ему уверенности в себе. Это включает в себя не только сбор фактов, связанных с проблемой, но и изучение личной информации, например, собственных ожиданий или требований. Следовательно, если человек ставит перед собой нереалистичные, недостижимые цели, то проблема заключается не в неспособности достичь поставленных целей, а в неспособности реалистично оценить свои возможности и навыки.



КПТ СДВГ

Можно задать еще ряд вопросов:

- В чем заключается проблема (конкретно)?
- Чего клиент хочет?
- Каковы препятствия на пути к получению того, что хочет клиент?



КПТ СДВГ

	Я не уверен, что стоит говорить партнеру, что у меня РДВГ	Я часто опаздываю на работу	Я получил уведомление о выселении из квартиры	Я поссорился с другом
1. В чем заключается проблема?	Сообщать или не сообщать	Обычно опоздание на 20-30 минут	Нужно найти, где жить через месяц	Мой друг перестал со мной общаться
2. Чего я хочу?	Чтобы она знала и принимала мой диагноз	Быть вовремя или опоздать на 10 минут	Найти новое жилье в ближайшие 2 недели	Снова общаться с другом
3. Каковы препятствия на пути?	Найти правильный момент, правильно все объяснить, он может оттолкнуть меня	Сложно рано вставать утром. Опаздываю на автобус	Нужны деньги, переживаю, что придется общаться с новыми людьми	Гордость, страх отвержения



Общие проблемы у людей с РДВГ:

- Работа: неуспеваемость на работе, нет продвижения по службе, невыполнение плана...
- Транспорт: опоздание, проблемы с организацией поездок, аварии...
- Финансы: задолженности, неоплаченные счета, импульсивные траты...
- Домашние дела: незавершенная уборка, бардак...
- Отношения: трудности с началом отношений, поддержанием отношений, ссоры...
- Сон: усталость, сонливость, бессонница, трудности с пробуждением, гиперсомния...
- Дезорганизация: проблемы с тайм-менеджментом, трата времени впустую, проблемы со структурированием распорядка дня...

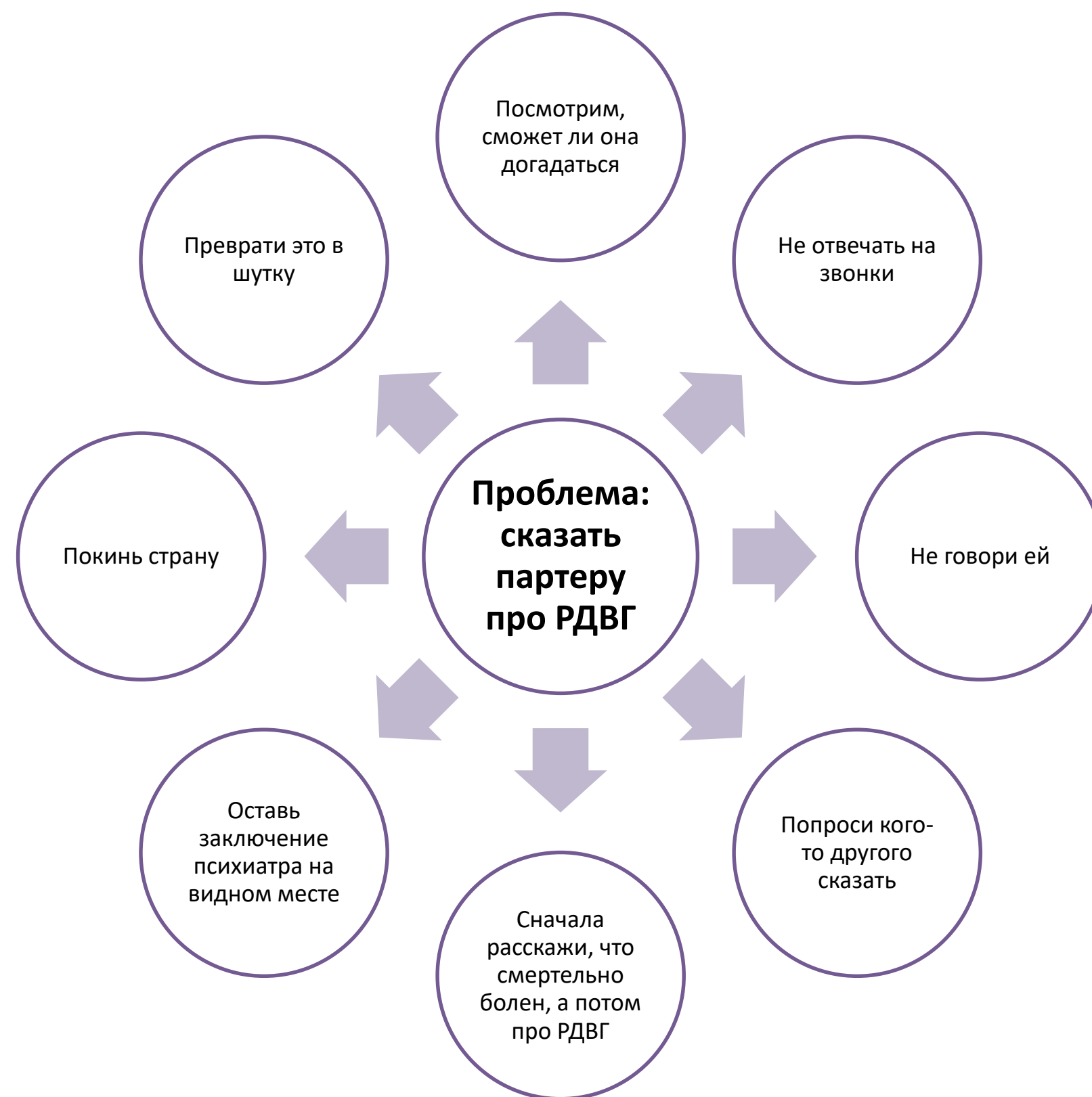


Этап 2: выявление и описание проблемы

Лучший способ разработки решения - это провести мозговой шторм всех возможных способов решения проблемы. Существует три основных правила выработки альтернативных решений с помощью мозгового шторма.

- Количество ведет к качеству, т.е. чем больше будет создано вариантов решения, тем больше среди них будет качественных идей
- Отсрочка выбора решения, т.е. человеку нужно подождать, чтобы выбрать решение для того, чтобы проанализировать более выгодные варианты решения
- Разнообразие, т.е. чем больше диапазон решений, тем больше вероятность того, что будет сгенерировано хорошее решение.

Таким образом, клиента следует поощрять к созданию идей, включающих экстремальные решения, варьирующие от рациональных до нелепых.





КПТ СДВГ

Распространенным препятствием для выработки креативных решений являются привычки. Привычки препятствуют решению проблем, заставляя клиентов реагировать автоматически и таким образом, к которому они привыкли. Люди с РДВГ вполне могут иметь в анамнезе привычные и импульсивные реакции, приводящие к развитию неадаптивных привычек, которые становятся неадаптивными стратегиями совладания.

Например, клиент может обычно воспринимать ситуацию, как угрожающую из-за неспособности решить проблему и может начать избегать ее. Такие привычки могут быть с успехом выявлены совместно на сессиях, чтобы клиент мог распознать их, когда они возникают, и сопротивляться импульсу автоматически реагировать в соответствии с заранее определенным образом мышления или поведения.



КПТ СДВГ

Одним из наиболее полезных методов решения проблем, который часто упускается из виду взрослыми с РДВГ, является простой обзор предыдущих решений, которые они применяли к аналогичным проблемам. Следует поощрять клиента задуматься о том, как он обычно решает проблемы и что сработало (или не сработало) в прошлом.



КПТ СДВГ

Мы должны оценить методы, с помощью которых им удавалось успешно избегать проблем в прошлом. Это потребует привлечения клиента к анализу затрат и выгод предыдущих процессов принятия решений. Клиенты должны быть поощрены думать не только о том, что и кто помогал в прошлом, но и о том, что усугубляло ситуацию. Им необходимо определить процесс того, как они пришли к решению и привело ли это к положительному или отрицательному результату. Они также могут обратиться за советом к кому-то, кто сталкивался с подобными ситуациями в прошлом, кто может быть более объективен в отношении того, что сработало, а что нет.



КПТ СДВГ

Этап 3: оценка решений

После того, как было сгенерировано несколько решений, их следует оценить в соответствии со степенью удовлетворенности клиента результатом каждого решения. Для содействия этому процессу рекомендуется несколько методов, включая оценку усилий, изучение альтернатив, повторение решения, ролевые игры и преодоление когнитивных искажений.

- **Оценка усилий.** Люди с РДВГ могут избегать адаптивного решения проблем, когда усилия, затрачиваемые на реализацию решения воспринимается как слишком сложная задача. Стремление к немедленному удовлетворению означает, что короткий путь может оказаться более полезным, чем альтернатива в виде затраты большего количества усилий для достижения более важной цели. Методы мотивационного интервьюирования помогут человеку сосредоточиться на цели или задаче, которые должны быть достигнуты, и мотивируют его оставаться на задании, избегать отвлекающих факторов и достигать цели. Основная задача терапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту научиться сначала думать, а потом говорить или действовать, или реагировать импульсивно.

- ***Изучение альтернативных вариантов.*** После устранения всех нелепых и наименее вероятных вариантов у клиента обычно остаются два или три возможных реалистичных решения. У них часто появляются очень разные планы действий. Сейчас самое время составить список "за" и "против" для каждого из них - часто преимущества одного решения являются недостатками другого. Оценки могут быть даны в зависимости от того, насколько важны для клиента все "за" или "против". Это может зависеть от вероятности достижения цели, эмоционального благополучия, времени и усилий.

- **Репетиция.** Это эффективный способ подготовки к сложному разговору или ситуации. Клиента можно попросить представить ожидаемую ситуацию и увидеть, как он сам действует в соответствии с выбранным решением. Клиента можно сориентировать в ситуации, попросив представить и описать окружающую обстановку в деталях, например, цвет штор, тип напольного покрытия, запахи готовящейся пищи. Поначалу у некоторых клиентов могут возникнуть трудности с включением в воображаемый режим, но с практикой это станет легче. В таких случаях терапевту может быть полезно: сначала обсудить с клиентом конкретные шаги, которые могут быть предприняты для решения проблемы, пока клиент находится в режиме воображения. Однако важно, чтобы клиент перешел к повторной отработке решения без посторонней помощи. Кроме того, клиент и терапевт должны попытаться выявить возможные подводные камни на пути к успеху, которые не были очевидны сразу, и совместно определить, как их можно преодолеть и/или конструктивно управлять ими. Клиент должен также учитывать, что он чувствует во время процесса и в результате.



КПТ СДВГ

- **Ролевая игра.** Метод ролевой игры особенно полезен для репетиции решений проблем с участием других людей, таких как уведомление на работе и прекращение отношений. Практикуя ситуации таким образом, люди будут меньше нервничать, когда ситуация действительно произойдет, и они будут чувствовать себя более подготовленными. Это улучшит их чувство самоэффективности и увеличит веру в то, что проблемы разрешимы и перемены возможны.

- **Работа с когнитивными искажениями.** Вполне вероятно, что на каком-то этапе лечения искаженное мышление будет препятствовать процессу решения проблем, особенно когда предпочтение отдается неадаптивным привычным реакциям ("У меня ничего не получается", "Я потерплю неудачу", "Я глупый", "Я им не нравлюсь"). Клиенту необходимо научиться проверять, являются ли его идеи о различных решениях продуктивными и жизнеспособными. Когнитивно искаженное мышление, скорее всего, будет способствовать тем идеям, которые мало что добавляют к решению проблемы и/или могут усугубить ее. В таких обстоятельствах потенциально полезные решения могут быть ошибочно отброшены из-за когнитивных искажений, приводящих к: чрезмерному обобщению («все, что я делаю, всегда идет не так, так зачем стараться»), черно-белому мышлению («если я не могу сделать на 100%, то в этом вообще нет смысла»), поспешным выводам («да, я смог начать, но я никогда не закончу») и пр.



Этап 4: выполнение выбранного решения

Как только подходящее решение определено и отрепетировано, клиенту рекомендуется реализовать его, заботясь о том, чтобы избежать проволочек и ловушек, связанных с пустой тратой времени. Например, проблема в долгах, и цель состоит в том, чтобы погасить счет по кредитной карте на сумму 10 000 рублей к концу года. Реализованное решение заключается в откладывании 500 рублей каждую неделю. Это иллюстрирует, как следует планировать шаги по достижению цели, разбивая цель на более мелкие достижимые шаги. Однако этот процесс часто является более сложным, особенно когда трудности в решении проблем связаны с межличностными отношениями. Это включает в себя обдумывание наилучшего времени и ситуации, в которых можно решить проблему, и, по возможности, подготовить обстановку. Задачи должны быть четко определены, а цели реалистичны.



КПТ СДВГ

Этап 5: оценка успеха

После реализации решения клиент должен оценить свой успех. Достиг ли он желаемого результата? Положительный отзыв терапевта - это мощная награда! Важно, чтобы клиент гордился своими достижениями и фокусировался на преимуществах успеха. Он должен задуматься о влиянии успеха на уверенность в себе, настроение, а также на его понимание первоначально возникшей проблемы (была ли она настолько опасной для жизни, как он сначала подумал?). Положительная обратная связь повысит вероятность того, что клиент включится в процесс решения проблемы без откладывания (или прокрастинации) на будущее и мотивировать их к достижению дальнейших целей.



КПТ СДВГ

В случае частичного успеха или его отсутствия терапевт должен систематически оценивать все возникшие препятствия и трудности и возобновлять процесс решения проблем, чтобы изучить, как с ними можно лучше справиться. Полезные области для изучения включают чувства клиента по поводу успешного разрешения проблемы, такие как боязнь последствий, беспокойство по поводу перемен или неопределенности. Возможно, проблему необходимо переоценить и решить по-другому. Вознаграждения имеют решающее значение для поощрения клиента и обеспечения мотивации. Система вознаграждений должна включать вознаграждения за попытку решения проблемы и еще одно большее вознаграждение за успешное решение проблемы.



КПТ СДВГ

ГЛУБИННЫЕ СИМПТОМЫ

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ



КПТ СДВГ

Поведенческая и когнитивная импульсивность и гиперактивность - это характеристики РДВГ, связанные с отсутствием способности контролировать поведение, речь или определенные мыслительные процессы. Это означает, что человек с РДВГ, скорее всего, скажет первое, что придет ему в голову, например, выразит чувства, мысли и мнения, не взвешивая последствий. Они также могут действовать, не задумываясь о последствиях своего поведения. В некотором смысле, у них нет внутреннего "тормоза", который позволял бы им отсеивать неподходящие реакции или поведение. Это иногда называют плохим подавлением реакции; то есть они неспособны подавлять доминантную реакцию.



КПТ СДВГ

Плохой контроль над импульсами может вызвать проблемы у людей с РДВГ в их социальных взаимодействиях. Они могут выпаливать неуместные комментарии и непреднамеренно оскорблять людей. Тем не менее, в некоторых обстоятельствах склонность действовать "под влиянием момента" может быть выгодной, поскольку это означает, что люди готовы идти на риск, который может окупиться, в то время как человек без РДВГ, скорее всего, будет более осторожен и, возможно, упустит возможности.



КПТ СДВГ

Импульсивность или отсутствие торможения также могут привести к усилению нестандартного мышления, что позволяет людям с РДВГ проявлять творческий подход. Они, как правило, не участвуют в систематическом процессе принятия решений и не рассматривают альтернативные точки зрения. Потребность в немедленном удовлетворении может заставить людей казаться требовательными, утомительными и бестактными, и они могут восприниматься как антисоциальные и раздражающие. Они также могут казаться невнимательными и непостоянными, поскольку могут импульсивно увлечься чем-то, но затем быстро потерять интерес в пользу чего-то нового. Их можно рассматривать как эгоцентричных личностей, которым не хватает внимания к чувствам и потребностям других. Такая презентация, вероятно, будет иметь негативные социальные последствия, в результате чего сами клиенты будут чувствовать себя непонятыми и социально изолированными.

Существует два конкурирующих объяснения того, почему импульсивность возникает при РДВГ. Одно из них заключается в том, что существует первичный дефицит исполнительного функционирования в механизмах ингибирующего контроля, таких как механизмы, которые останавливают человека от того, чтобы перебежать оживленную дорогу, или останавливают кого-то от того, чтобы выпалить бестактный комментарий. Вероятность успешного торможения, по-видимому, напрямую зависит от продолжительности интервала "остановки"; то есть, когда люди с РДВГ находятся под давлением, требующим подавления реакции в течение короткого промежутка времени, они с большей вероятностью совершат ошибку. Однако, если им дается больше времени для подавления реакции, они становятся более точными и, следовательно, менее импульсивными. Эта концепция имеет большое значение для вмешательства, поскольку клиенты с РДВГ должны научиться планировать время и поощряться к тому, чтобы "остановиться и подумать", чтобы уменьшить количество неудач из-за импульсивных ошибок.



Альтернативная теория заключается в том, что импульсивность, связанные с РДВГ, обусловлена отвращением к задержке. Согласно этой точке зрения, импульсивное поведение обусловлено стремлением избежать промедления, которое у людей с РДВГ вызывает отвращение. Теория предполагает, что импульсивность подкрепляется предпочтением немедленного или краткосрочного вознаграждения и неспособностью откладывать удовлетворение на более длительный срок. Это означает, что люди более мотивированы получать текущее вознаграждение, даже если оно менее ценно, чем более ценное долгосрочное вознаграждение. Это имеет значение для повседневного функционирования, где большая часть нашего поведения, особенно во взрослой жизни, регулируется принципом "хорошее приходит к тем, кто ждет".



Например, большинство людей считают, что перспектива получения зарплаты в конце недели или месяца достаточна, чтобы поддерживать у них мотивацию на работе каждый день. Однако люди с РДВГ, если они по какой-либо причине стали неудовлетворенными и / или раздраженными на работе (например, им наскучила работа; они раздражены коллегой), могут быть склонны уволиться с работы, чувствуя, что краткосрочное вознаграждение за выход из ситуации более ценно для них, чем долгосрочное вознаграждение в виде зарплаты. К сожалению, перспектива немедленного вознаграждения и соблазн могут склонить некоторых людей к делинквентному или преступному поведению. Последствия стратегии лечения заключаются в том, чтобы работать с потребностью в немедленном удовлетворении, разбивая задачи на более мелкие этапы и ставя краткосрочные цели, которые могут быть вознаграждены.



КПТ СДВГ

Существует несколько способов проявления импульсивности у взрослых с РДВГ. Люди могут казаться слишком "не в себе"; то есть такие люди склонны реагировать до того, как будут выполнены инструкции, или до того, как они получат всю информацию, необходимую для начала выполнения задачи. Также возникают трудности, когда взрослые с РДВГ действуют, не задумываясь, когда люди реагируют, предварительно не рассмотрев все возможные варианты реагирования и их последствия. В качестве альтернативы, человек может устно или физически наброситься на кого-то, кто их расстроил, не принимая во внимание социальные и/или юридические последствия. Они фокусируются на краткосрочных вознаграждениях, в отличие от долгосрочных, например, студентам может быть трудно отказаться от легкодоступного развлечения, что может помешать им достичь долгосрочной цели, такой как своевременная сдача курсовой работы.



КПТ СДВГ

Импульсивность может быть концептуализирована двумя способами:

- поведенческая импульсивность
- когнитивная импульсивность



КПТ СДВГ

- Поведенческая импульсивность относится к неспособности подавлять физические или словесные действия из-за преждевременной и/или чрезмерно быстрой реакции. Это проявляется, например, в неспособности сопротивляться тому, чтобы делать или говорить неподобающие вещи. Люди с РДВГ могут в порыве гнева наброситься на кого-то отпустить обидный комментарий. Поведенческая импульсивность связана с чрезмерной тягой к немедленному вознаграждению.
- Когнитивная импульсивность относится к дезорганизованному поведению, связанному с проблемами исполнительной функции. Она лежит в основе забывчивости, плохого планирования и нехватки времени. Например, клиенты могут неверно оценивать ситуацию или намерения других людей и принимать необдуманные важные решения, основанные на неадекватной информации.

Типичные проблемы с контролем импульсов при РДВГ:

- Слепота к последствиям: трудно обдумать последствия своего поведения прежде, чем действовать. Например, социальные последствия, если человек перебивает или сплетничает.
- Трудности с ожиданием: РДВГ может сильно влиять на способность человека стоять в очереди или ждать. Это особенно заметно в очередях в магазине.
- Мотивация к немедленному вознаграждению: люди с РДВГ склонны выбирать краткосрочное вознаграждение, требующее меньших усилий, чем работать в течение длительного времени и прикладывать больше усилий для получения большего вознаграждения.
- Выбор коротких путей: люди с РДВГ печально известны тем, что идут коротким путем, что может привести к снижению точности и качества результата.

- **Требовательное поведение:** люди с РДВГ могут показаться требовательными и эгоцентричными, если кто-то другой контролирует доступ к тому, чего они хотят.
- **Недостаток проницательности:** ситуации, в которых они будут импульсивны могут быть не очевидны для людей с РДВГ.
- **Резкие движения:** на движения может влиять импульсивность, например, внезапное соскакивание со стула или выхватывание предметов у другого человека.
- **Неосторожное вождение:** вождение может вызвать большие трудности при РДВГ, трудно ждать на светофоре, терпеливо ехать за медленными водителями. Плохой контроль импульсов приводит к штрафам, ДТП и пр.
- **Нарушение правил:** поведенческая импульсивность часто может сопровождаться непослушанием или непреднамеренным нарушением инструкций.

- Безрассудство: импульсивность может проявляться как безрассудство из-за склонности заниматься опасной деятельностью, не задумываясь о последствиях.
- Поспешные выводы: люди могут неверно истолковывать двусмысленные ситуации, делать предположения, основанные на очень скудной информации.
- Возникновение долгов: импульсивные траты могут побудить людей покупать товары, не задумываясь о том, могут ли они это себе позволить и необходимы ли они.
- Поиск новизны: поиск острых ощущений и новизны может быть вызван чрезмерным влечением к немедленному вознаграждению.
- Тревога: тревога может привести к импульсивному избеганию вызывающих беспокойство ситуаций или усугубить трудности с контролем импульсов.



КПТ СДВГ

Общей темой для всех этих форм поведения является то, что люди не думают наперед и не учитывают последствия своих действий. Дело не в том, что они не осознают разницу между подобающим и неподобающим поведением или что существует одно решение/реакция на одну проблему лучше, чем на другую. Трудность возникает из-за того, что они не продумывают и не рассматривают все варианты. Их процессы принятия решений могут быть импульсивными, что приводит к тенденции делать важный выбор быстро и без тщательного обдумывания или планирования. Поэтому терапия должна быть направлена на обучение навыкам самоконтроля и саморегуляции, обучение человека учитывать последствия действий и генерировать подходящие и конструктивные альтернативы.

До сих пор были описаны два основных аспекта импульсивности: **когнитивная и поведенческая импульсивность**. Клиенты с готовностью отнесутся к поведенческой импульсивности, поскольку это то, что они воспринимают как препятствующее их повседневной работе, например, не справляются с заданием и никогда ничего не доводят до конца; приходят к неправильным выводам; выходят из себя и прочее. Терапевт должен направить клиента на определение конкретных ситуаций, когда он, скорее всего,отреагирует импульсивно. Это не должно представлять большой проблемы, но если это кажется трудным, клиент должен начать с того, что оглянется назад на поведение, о котором он сожалеет. В частности, он должен выявлять проблемы, которые возникали на регулярной основе, поскольку они могут быть использованы для мониторинга прогресса в лечении. Посредством обсуждения, исследования и сократического диалога относительно этих ситуаций (а также наблюдения за поведением клиента на сессиях) могут быть определены целевые модели поведения, подходящие для лечения.



Однако, как и при любых поведенческих измерениях, целевое поведение должно быть конкретным и четко определенным клиентом и терапевтом. Частота целевого поведения затем может быть измерена либо в ходе сессии (например, количество прерываний), либо вне сессий с помощью клиента, друга, партнера или члена семьи (например, крики на автомобилистов во время вождения), либо с помощью объективного показателя (например, запись еженедельные покупки в магазинах). Конечная цель состоит в том, чтобы клиент взял на себя ответственность за мониторинг своего собственного импульсивного поведения. По мере того как люди все больше осознают свое поведение, обучение самоконтролю таким образом само по себе может выступать в качестве стратегии сокращения этого поведения. Этот процесс называется методом ИМПУЛЬС для самоконтроля и регулирования плохого контроля. Как только клиенты успешно освоят этот метод, им рекомендуется применять его к целому ряду проблемных форм поведения (включая те, которые были выявлены другими).



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

**I – identify – выяви и
определи свое поведение**

Целевое поведение должно быть выбрано клиентом. Не всякая импульсивность является проблемой для человека, важно, чтобы он определил и нацелился на те области, где у него есть мотивация к изменению. Например, перебивание других и неподобающее поведение в разговоре может привести к проблемам в отношениях и изоляции.



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

**М – make – сделай
поведение явным**

Разработка четкого определения проблемы имеет решающее значение для эффективных изменений. Расплывчатые цели, такие как “перестать быть импульсивным”, трудно измерить и трудно достичь. Более разумно использовать четкие формулировки - “превышение скорости”, “прерывание других”



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

**P – peer/partner –
партнерский мониторинг**

Терапевт может иметь возможность отслеживать некоторые формы поведения, такие как перерывы на сессиях. Однако оценить другие формы поведения может быть не так просто. Можно использовать видеокамеры для оценки поведения. Или можно обратиться за помощью к партнеру, другу или члену семьи



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

**U – understanding –
понимание и
самоконтроль**

Если метод ИМПУЛЬС контролировался не клиентом, а кем-то другим, ответственность за мониторинг в дальнейшем должна быть передана клиенту. Возможно, будет полезно сравнить отчеты о поведении, чтобы убедиться, что клиент способен надлежащим образом распознать целевое поведение. Самоконтроль тоже может быть вмешательством.



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

**L – list – сделай список
планов по решению
проблемы**

Как только поведение отслежено
и установлен базовых
показатель, клиент и терапевт
совместно формируют план
вмешательства.



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

**S – strategy – реализация
стратегии**

Клиент применяет
согласованную стратегию.



КПТ СДВГ

Метод ИМПУЛЬС (IMPULSE)

E – evaluation – оценка стратегии

Оценка успешности стратегии осуществляется 2 методами: клиенту следует предложить оставить отзыв о стратегии -что было полезным/бесполезным и т.д.; либо использовать повторный мониторинг, чтобы установить частоту целевого поведения (стало ли поведение реже).



КПТ СДВГ

В то время как планы управления поведением полезны для адаптации конкретных форм поведения, которые часто встречаются, основная цель лечения состоит в том, чтобы человек разработал и поддерживал свой план управления, чтобы со временем этот план мог стать более обобщенным. Цель состоит в том, чтобы человек начал в целом справляться с импульсивными реакциями. Работа включает в себя изучение методов мониторинга и контроля импульсивного поведения. Существует несколько техник, все из которых побуждают человека остановиться и подумать, они включают в себя обучение применению когнитивных стратегий, таких как самоконтроль, беседы, тренинги по самообразованию, перепроверки и методы отвлечения внимания. Не все стратегии будут полезны, но вполне вероятно, что клиент найдет некоторые из этих методов полезными. Это можно определить, только опробовав их и оценив прогресс.



КПТ СДВГ

Везде, где это возможно, следует моделировать соответствующее поведение. Кроме того, некоторым людям может быть полезно просмотреть записи, на которых они сами участвуют в ролевых играх, требующих от них как подобающего, так и неподобающего поведения. При воспроизведении записи клиенту следует предложить взглянуть на их поведение с другой точки зрения, представив, что за ними наблюдает друг или член семьи. Что могло бы происходить у них в голове? В качестве альтернативы клиента можно попросить представить, что он наблюдает за поведением друга или члена семьи. Что бы он сам об этом подумал? Будет ли он рассматривать это взаимодействие по-другому? Ролевые игры особенно полезны для восприятия перспективы, поскольку это дает клиенту возможность обдумать личные и социальные последствия поведения.



КПТ СДВГ

Будьте осторожны с когнитивным избеганием, которое может проявляться как отсутствие мотивации. Человек может испытывать беспокойство, если он начнет лучше понимать свое собственное поведение и его влияние на других. Это может привести к тому, что клиенты будут избегать встречи лицом к лицу с прошлыми ошибками, которые были финансово и/или эмоционально дорогостоящими, и/или болезненными. Если это произойдет, это может затруднить прогресс в лечении. В некоторых случаях люди могут намеренно пытаться саботировать лечение путем самоизоляции. Быть чутким к чувствам клиента и признавать их, вероятно, будет полезно для преодоления трудностей.



Стратегии для терапии когнитивной импульсивности

1. *Разговор с самим собой.* Это по сути проактивное мышление. В определенной степени каждый ведет разговор сам с собой, иногда даже вслух. Люди часто продумывают в своей голове планы на различные ситуационные исходы и репетируют возможные ответные действия. Клиента можно научить применять разговор с самим собой как когнитивную технику для прерывания автоматического дисфункционального мыслительного процесса, например, произнося такие слова, как "Остановись", "Контролируй", "Подумай, прежде чем говорить". Если клиент находится в состоянии повышенного эмоционального возбуждения, то это усугубит когнитивный дефицит, в результате чего он будет чувствовать себя перегруженным и сбитым с толку.



КПТ СДВГ

Разговоры с самим собой одновременно с визуализацией (заранее определенных) успокаивающих образов, помогут человеку лучше контролировать ситуацию. Потенциальные успокаивающие образы следует обсуждать и опробовать на сессиях, чтобы клиент мог разработать репертуар полезных и успокаивающих визуальных образов, которые можно использовать по мере необходимости. Беседа с самим собой должна быть адаптирована к индивидуальным потребностям путем определения того, что клиент считает полезным. Это должно быть достигнуто совместными усилиями на сессиях, а также протестировано и оценено в условиях реальной жизни.



2. Самообучение. Вторым шагом на пути к смягчению последствий импульса является самообучение. Разговор с самим собой прерывает дисфункциональный мыслительный процесс, и, как только это достигнуто, затем человек должен научиться направлять себя к более позитивному функциональному мышлению. Тренинг по самообучению помогает клиенту отстраниться от ситуации, оценить ее с разных точек зрения, оценить возможные реакции и результаты, провести переоценку и выбрать подходящий ответ. Это достигается путем обучения клиента самостоятельному выполнению целенаправленных инструкций. Пока клиент не привыкнет к этому процессу, его следует повторять вслух на сессиях. Наиболее распространенным препятствием на пути к успеху является желание и мотивация человека с РДВГ к немедленному удовлетворению. Немедленное или краткосрочное вознаграждение предпочтительнее долгосрочного вознаграждения. Таким образом, логическое мышление (т.е. оценка потенциальных результатов, их достоинств и недостатков) является важным компонентом любого плана управления проблемным поведением.



КПТ СДВГ

Можно использовать для этого модель КОНТРОЛЬ (CONTROL) – процесс, во время которого клиент ведет беседу с самим собой, чтобы остановить дисфункциональное мышление, делает самостоятельные заявления и/или инструкции и рассматривает варианты и альтернативы.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

С – control – контроль

Чтобы прервать дисфункциональный мыслительный процесс, человек должен произнести вслух или про себя “КОНТРОЛЬ” в качестве техники остановки мыслей. Кроме того, ему может быть выгодно временно отстраниться от ситуации.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

**О – off-line – автономная
обработка**

Беседа с самим собой и
самоинструкции применяются
для закрепления внимания на
более спокойных образах и
эмоционально нейтральном
состоянии.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

N – new solution – новое решение

Альтернативные решения генерируются с помощью самонаправляемых мыслей. Дополнительно будут полезны методы рационализации и решения проблем.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

T – test solution – тестирование решения

Решения могут быть протестированы путем мысленной репетиции и прогнозирования результатов, например, 1 - я могу купить телевизор сейчас в кредит, но иметь меньше денег каждый месяц в течение года, 2 - я могу сэкономить на покупке товаров и купить телевизор через 6 месяцев, 3 - купить более дешевый телевизор и т.д.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

**R – re-evaluation –
переоценка**

После рассмотрения вариантов
можно выбрать наиболее
предпочтительный,
проанализировав цели.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

**О – on-line – реальное
выполнение**

Как только решение принято, оно должно быть выполнено, решение становится актуальным. Нужно определить и включить вознаграждение за успешное выполнение метода КОНТРОЛЬ.



КПТ СДВГ

Метод КОНТРОЛЬ (CONTROL)

**L – look – поиск
преимуществ**

В целях дальнейшего
позитивного подкрепления
метода, необходимо оценить
результат, изучая преимущества
и положительный результат.



3. Двойная проверка. Поскольку беседа с самим собой и методы самообучения становятся все более автоматическим процессом, клиента следует поощрять к внедрению системы двойной проверки информации, предположений, убеждений и т.д. Она включает в себя процесс принятия решений, посредством которого клиентов можно побудить перепроверить или пересмотреть принятые решения, задав себе пять вопросов:

- Это то, чего я действительно хочу?
- Как давно я хотел это сделать?
- Что произойдет, если я это сделаю?
- Что произойдет, если я этого не сделаю?
- Каковы долгосрочные последствия?



КПТ СДВГ

Важно, чтобы человек помнил о цели, которая должна быть достигнута. Например, распространенной проблемой людей с РДВГ является то, что они совершают импульсивные покупки. Этой склонности не способствует практика магазинов активно поощрять импульсивные покупки, выставляя небольшие относительно дешевые товары на кассовых лентах. Взрослым с РДВГ следует напоминать о наличии в их домах большого количества неношенной неподходящей одежды или неиспользуемых аксессуаров.



КПТ СДВГ

В первое время можно использовать карточки с вопросами. Клиент также должен определить план на сессиях, который он затем применяет in vivo, например, покинуть магазин, не совершив покупку; пройтись пять минут и ответить на вопросы, указанные в карточке, прежде чем решить, возвращаться в магазин за покупкой или нет. Важно измерять и оценивать результат, чтобы продемонстрировать успех. В этом случае ведение учета покупок укрепило бы успех, выделив потенциальную экономию в течение определенного периода времени.

4. Техники отвлечения. Один из наиболее распространенных случаев проявления импульсивного поведения - это ситуации, когда человеку приходится ждать или стоять в очереди. Нетерпимость к задержкам вызывает у людей чувство скуки, разочарования и раздражения. Каждая минута кажется вечностью, и люди часто предпочитают получить краткосрочное вознаграждение, сдавшись и покинув очередь или потребовав немедленного внимания к себе. Проблема с первым сценарием в том, что клиенты не достигнут своей цели. Проблема со вторым сценарием - они с большой вероятностью спровоцируют конфронтацию. В таких случаях можно применять техники отвлечения, чтобы развить лучший самоконтроль (отвлекая себя от негативных размышлений по поводу ситуации). Эти техники можно практиковать заранее или в воображении.



КПТ СДВГ

- Фокус на объекте: сосредоточьтесь на объекте и опишите его в деталях.
- Фокус на человеке: посмотрите на человека, стоящего перед вами в очереди, представьте, как бы его звали, чем он зарабатывает на жизнь, где живет, какого персонажа он мог бы сыграть в фильме и пр. Будьте осторожны и не пяльтесь, так как это может быть воспринято как провокация.
- Использование чувств: сосредоточьтесь на каждом чувстве по очереди (слух, зрение, осязание, обоняние и вкус).
- Подсчет: сложные задачи для подсчета, такие как обратный счет.
- Словообразование: постарайтесь придумать как можно больше слов (названий животных, стран, городов, имен) на каждую букву алфавита.
- Фантазирование: представьте, где бы вы предпочли быть сейчас.
- Паззлы: кроссворды, поиск по словам и т.д.

5. Внешние стратегии. Может быть полезно пригласить родителей, партнеров и/или хорошего друга посетить некоторые сессии (если это уместно), поскольку это дает возможность наблюдать за техниками и закреплять их вне сессии. Друзья или родственники могут поддержать клиента, напомнив ему о техниках, изученных на сессии, отрепетировав техники и предоставив подсказки, когда это уместно, для их применения *in vivo*, например, побуждая клиента включиться в метод КОНТРОЛЬ и/или отслеживать прогресс и изменения в поведении. Положительные отзывы других людей также могут быть важным компонентом системы вознаграждения, поскольку похвала подкрепляет успешное и соответствующее поведение. Неуместное или неприемлемое поведение никогда не должно подкрепляться. Следует избегать исключений или допущений, таких как "о, это Паша, он немного сумасшедший". Очень важно, чтобы обратная связь была последовательной и конструктивной, а человек не чувствовал личной критики.



КПТ СДВГ

КОМОРБИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ часто чувствуют, что у них возникают трудности в межличностных отношениях, будь то дружба, романтические отношения, рабочие отношения или семейные отношения. Ведение переговоров о социальных отношениях может быть столь же трудным с людьми, которых они хорошо знают, с близкими знакомыми и с незнакомцами. Большинство подростков формируют и развивают социальные отношения в своем ближайшем окружении, например, в школе и университетах/колледжах. Однако молодые люди с РДВГ, как правило, заводят отношения по соседству, например, через партнеров по аренде жилья или тусуясь на улице. Возможно, это отражает потребность отдельных людей пользоваться более широкими социальными сетями и иногда заводить друзей среди сверстников, которые исключены из школы или не имеют работы. Дети с РДВГ часто растут, полагая, что их неправильно понимают или что они чем-то отличаются от других. Независимо от того, как сильно они стараются, отношения, как правило, идут наперекосяк, и они развиваются не так, как предполагалось или ожидалось.



КПТ СДВГ

Проблемы с управлением гневом и контролем импульсов могут привести людей с РДВГ к неустойчивым отношениям, которые легко прекращаются. В конце концов, они перестают пытаться, и им не хватает уверенности, чтобы завязать дружбу. Самосознание своих социальных трудностей вызывает стресс, а иногда и защитную позицию. Иногда эти чувства вымещаются на близких людях, таких как родители или партнеры. Они могут реагировать неестественным образом или пытаться гиперкомпенсировать ситуацию. Например, часто люди с РДВГ сообщают об ощущении, что им нужно "разыгрывать клоуна" в социальных ситуациях, чтобы замаскировать тревогу или проблемы с вниманием. Пребывание в центре внимания уменьшает потребность в том, чтобы они сосредотачивали внимание на других. Они также могут чувствовать, что, будучи забавными, они будут более привлекательны для других.



Однако, несмотря на то, что они являются душой компании, многие люди с РДВГ сообщают, что в целом чувствуют себя очень изолированными. Им трудно формировать значимые и длительные отношения из-за низкой самооценки и истории отвержения со стороны других. Они могут обнаружить, что другие люди нетерпимы к их симптомам РДВГ. Некоторые люди могут быть уязвимы для эксплуатации со стороны других из-за своей мотивации нравиться и снискать расположение в группе сверстников. Они могут стать частью "плохой компании", полагая, что плохие друзья лучше, чем их отсутствие.

Другие могут поощрять к антиобщественному поведению, например, путем доставки наркотиков или кражи из магазинов. Женщины, в частности, могут пытаться компенсировать это беспорядочным сексуальным поведением в попытке найти значимые отношения. Некоторые люди подвержены неуместному самораскрытию в попытке ускорить установление дружеских отношений. К сожалению, нарушение социальных отношений - это опыт, который часто приобретается в юном возрасте. Людям с РДВГ важно осознавать, что то, как они представляют отношения может влиять на то, как другие взаимодействуют с ними. Это включает в себя то, как они разговаривают с другими и выражают себя (вербальное общение), их невербальную позу и действия (язык тела), а также общее впечатление, которое они производят о себе (эмоциональные выражения, особенности РДВГ). Это предполагает повышение осведомленности о социальном поведении и изучение влияния, которое некоторые или все эти формы поведения оказывают на восприятие других людей.



КПТ СДВГ

Например, невнимательность при РДВГ может быть неверно истолкована другим человеком как отсутствие интереса к тому, что он говорит. Взрослый с РДВГ может восприниматься как непостоянный, потому что он переходит от одного человека к другому или от одной темы разговора к другой. Это может быть воспринято другими как недостаток искренности.



КПТ СДВГ

Из-за импульсивности люди с РДВГ также могут быть склонны к принятию поспешных решений и поспешным выводам. Это означает, что они могут принимать вещи за чистую монету, основываясь на первых впечатлениях. Например, если знакомый идет по коридору и не обращает на него внимания, он может сразу предположить, что он не нравится этому человеку и вести себя таким образом, который отражает это, что приводит к самореализующемуся пророчеству. Они могут не рассматривать другие объяснения отсутствия контакта, например, то, что человек спешит и занят срочным делом.



Громкое и буйное поведение может в некоторых культурах рассматриваться как признак общительности/дружелюбия/счастья, в то время как в других это может рассматриваться как грубость и несносность. Следовательно, терапевту необходимо учитывать культурные аспекты. Точно так же клиент должен думать о социальных обстоятельствах и ожиданиях окружающих, поскольку это поможет ему понять, как он должен себя вести. Различные социальные ситуации предъявляют целый ряд ожиданий в отношении того, как люди должны себя преподнести. Например, социальные требования, предъявляемые к собеседованию, сильно отличаются от требований, предъявляемых к пребыванию в группе друзей на вечеринке.



КПТ СДВГ

Людам с РДВГ может быть труднее адаптироваться к меняющимся социальным требованиям ситуаций, и они могут полагаться на социальный репертуар, который хорошо работает в одной обстановке, но совершенно неадекватен или неподходящий для другой. Терапевтические сессии должны быть структурированы таким образом, чтобы включать аспекты, важные для развития как микро-навыков, так и макро-навыков.

Микро-навыки включают в себя использование специальных методов обучения социальным навыкам для поощрения таких навыков, как соответствующий зрительный контакт, сила и тональность голоса, язык тела. **Макро-навыки** охватывают более сложные взаимодействия, такие как комплименты, конструктивная обратная связь, умение принимать решения и умение слушать.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ по своей природе не являются затворниками, они полны энтузиазма, общительные и дружелюбные люди. Таким образом, парадокс заключается в том, что они желают и стремятся к социальному признанию, но чувствуют тревогу, находясь в компании или в социальных ситуациях, и не уверены в том, как себя вести.



КПТ СДВГ

Выявление социальных проблем

Некоторые клиенты могут сообщать о "сотнях" хороших друзей, но при более тщательном опросе оказывается, что это случайные знакомые, и другой человек, вероятно, придерживается совершенно иной точки зрения на отношения. Чрезвычайно важно преодолеть защитную реакцию и смущение по поводу трудностей в социальных отношениях, поскольку терапевту будет трудно помочь, если клиент не осознает проблему. Таким образом, первым шагом к улучшению социальных отношений является **осознание проблемы** и **определение целевых областей для терапии**, на которые клиент, возможно, пожелает опереться, чтобы развить уверенность и мастерство при взаимодействии с другими людьми.



КПТ СДВГ

Для быстрой оценки социальных навыков может использоваться анкетирование, ее может заполнять сам клиент, его друзья и родные, можно сравнивать результаты. При этом расхождения в результатах теста могут быть использованы в качестве основы для дальнейшего обсуждения и лечения, чтобы помочь им выработать более точную интерпретацию намерений и эмоций, о которых сигнализируют другие.



КПТ СДВГ

Насколько ты хорош в...	Никогда не получается	Редко получается	Иногда получается	В основном хорошо получается	Всегда хорошо получается	Не знаю
Общение с друзьями						
Общение с незнакомцами						
Разговоры с незнакомцами на вечеринках						
Посещение вечеринок						
Встречи с друзьями						
Слушать людей						
Начинать разговор						
Задавать вопросы						



КПТ СДВГ

Насколько ты хорош в...	Никогда не получается	Редко получается	Иногда получается	В основном хорошо получается	Всегда хорошо получается	Не знаю
Отвечать на вопросы						
Признать, что чего-то не понимаешь						
Смотреть на людей, когда говоришь с ними						
Е суетиться						
Говорить понятно						
Понимать, как другие себя чувствуют						
Объяснять другим, что у тебя РДВГ						



То, как мы представляем себя - аспекты нашего голоса, речи и общения, информирует других о том, насколько приятно или легко с нами взаимодействовать. Слишком мало или слишком много разговоров могут вызвать трудности с тем, насколько хорошо другие способны слушать или понимать нас.

Люди с РДВГ часто перебивают других людей или встревают в их разговоры. Они могут сменить тему разговора или "уйти в сторону", и слушателю может быть трудно понять или уследить за тем, что они говорят. Люди с РДВГ часто сообщают о чувстве непрерывной умственной активности, которая может быть изнурительной как для самого человека, так и для людей, с которыми он общается. Они могут быть особенно возбудимы новизной и высокой стимуляцией и могут иметь тенденцию говорить быстро, слишком громко и слишком много, когда возбуждены. В такие моменты они могут испытывать "поток" идей и размышлений, которые, хотя и выражаются с энтузиазмом, слушателю трудно уследить за ними. Слушатель может быть подавлен или может заскучать.



Характеристики речи при РДВГ и предложения по улучшению

Особенность	При РДВГ	Восприятие другими	Как улучшить
Скорость	Говорят слишком быстро, другие могут не успевать за речью.	Ярка личность	Замедление темпа, дыхательные техники
Понятность	Бормотание или «съедание» слов из-за скорости	Не хватает уверенности в себе	Пытаемся говорить четко, артикулируя каждое слово
Интонация	Повышение тона голоса	Перевозбужден, иррационален, театрален	Понижение тона голоса
Беглость	Отвлекается и «соскальзывает» в разговоре	Незаинтересованность, неискренность	Отслеживание и структурирование того, что говорит
Громкость	Чрезмерно громко говорит	Агрессивен, пугает	Приглушение до умеренной громкости
Количество	Слишком много информации	Поверхностный, самовлюбленный	Быть более кратким, научиться обобщать информацию, быстрее переходить к сути



КПТ СДВГ

Скорость речи

Клиентам может быть полезно использовать разговор с самим собой, чтобы побудить себя притормозить. Практикуя этот навык, они могут казаться более спокойными, собранными, уверенными в себе и контролирующими ситуацию в общении с другими. Клиенты также должны научиться обращать внимание на физиологические изменения в организме, например, когда они возбуждаются из-за чего-либо, они могут чувствовать жар или замечать, что их сердце бьется быстрее. Выявление физических изменений позволит им понять, что они, возможно, говорят слишком быстро или чересчур страстно на какую-то тему.



КПТ СДВГ

Репетиция - еще один полезный метод повышения скорости и громкости вербального общения, и первоначально это может быть осуществлено путем чтения отрывков или повторения того, что говорит терапевт. Затем клиент должен перейти к ролевым ситуациям, и особенно полезно, если это можно записать и обсудить на сессиях. При воспроизведении записи клиент становится наблюдателем и лучше способен взглянуть на ситуацию с альтернативной точки зрения.



КПТ СДВГ

Особенность	Характеристика РДВГ	Развитие навыков
Начало разговора	Не дает собеседнику возможности заговорить	Обеспечение равного времени разговора
Прерывания	Встревает в разговоры, перебивает	Подбор времени вступления, ожидание, когда другие замолчат
Множество вопросов	Допрашивает других людей	Задавайте вопросы, чтобы стимулировать разговор
Задержка	Задержка с ответом после того, как кто-то задал вопрос	Старайтесь давать быстрый ответ
Актуальность	Отклонение от темы, что сбивает людей с толку	Поддержание актуального разговора
Интересный контент	Беседа мотивирована человеком с РДВГ	Создание интереса для других
Исправление	Обижается на ошибки, если другой ошибается	Вежливо поправляйте человека
Чрезмерный энтузиазм	Доминирует в разговоре, не задает вопросов другим и интересуется их мнением	Развивайте навыки слушания, задавайте вопросы



КПТ СДВГ

Разговорные навыки

Люди с РДВГ имеют тенденцию доминировать и монополизировать беседу, практически не обращая внимания на смену темы или уровень интереса слушателя к той или иной теме. Им также трудно прислушиваться к тому, что говорят другие, они отвлекаются и теряют нить разговора. Это может привести к тому, что они начнут вмешиваться и делать неуместные комментарии. Разговоры могут казаться очень односторонними, и клиент должен научиться балансировать между разговором и слушанием. Задавать вопросы другому человеку означает проявлять интерес к этому человеку. Сеансы записи и/или ролевые игры - это полезные методы для демонстрации подходящих и неподходящих навыков. Проблемы должны обсуждаться совместно с терапевтом.



Навыки слушания

Из вышеизложенного ясно, что навыки слушания являются большой проблемой для людей с РДВГ. Клиенты могут не уметь должным образом слушать по 2 причинам:

1. Они не дают человеку высказаться, тем самым проявляя незаинтересованность в его точке зрения. Это происходит, когда они становятся чрезмерно возбужденными (либо из-за беспокойства, либо из-за энтузиазма) и у них появляется мотивация заполнить паузу разговором и их мысли выплескиваются беспорядочным образом.
2. Они не уделяют должного внимания тому, что говорит человек, возможно, потому что их отвлекает шум или действия, происходящие вокруг, или потому что они сосредоточены на том, что собираются сказать дальше (внутренне отвлечены множеством идей и мыслей).



КПТ СДВГ

Особенность	Характеристика РДВГ	Развитие навыков
Внимание	Не удерживает внимание на том, что говорит собеседник	Развитие осознанности
Подтверждение	Кажется, что не слушает	Отвечайте так, как будто вы слышали, что было сказано. Либо переспросите
Ответы на вопросы	Не замечает вопроса или говорит «я не знаю»	Используйте подтверждения, например, кивки, слова «о, точно», делитесь своим мнением или давайте обратную связь в форме вопроса
Личное самораскрытие	Страх того, что люди будут совать нос в их личную жизнь/слишком сильное самораскрытие	Обменивайтесь информацией в зависимости от близости
Отражение	Забывает о том, что только что сказал другой человек	Повторяйте то, что слышите, так больше шансов запомнить, покажите другому, что вы слушаете его



КПТ СДВГ

Невербальная коммуникация

Невербальная коммуникация может выражать мысли и чувства без использования речи. Полезным упражнением является просмотр телевизионной программы с выключенным звуком с последующим расспросом клиента о том, что, по его мнению, говорит и что чувствует говорящий. Спросите клиента, почему он пришел к такому мнению, и научите его думать о тонких индикаторах языка тела. Это повысит осведомленность о том, как люди общаются невербально и как их воспринимают другие. Это также улучшит их способности чтобы правильно считывать невербальные сигналы.



КПТ СДВГ

Симптомы РДВГ сами по себе могут передавать неточную информацию о человеке, например, дефицит внимания может быть истолкован как отсутствие интереса. Постукивание ногой может быть неверно истолковано скорее как нетерпение и грубость, чем как беспокойство или симптом тревоги. Импульсивные прерывания или жесты могут показаться другим невежливыми или резкими и восприниматься как оскорбительные. Невербальные сигналы выполняют очень важную функцию в социальном взаимодействии и объяснение логики определенных невербальных сигналов для клиентов будет заставлять его чаще использовать их в своих социальных взаимодействиях.



КПТ СДВГ

Установление зрительного контакта

Зрительный контакт информирует других о том, что к ним прислушиваются и они интересны. Клиенты должны стараться периодически смотреть людям в глаза, так как избегание зрительного контакта может быть истолковано как то, что им наскучил разговор, они не проявляют интереса к разговору и/или не слушают. С другой стороны, смотреть человеку в глаза постоянно, не отводя взгляд, тоже может быть воспринято отталкивающе.



КПТ СДВГ

Выражение лица

Выражения лица сообщают другим о чувствах, например, улыбаются, когда счастливы, хмурятся, когда недовольны. Некоторые выражения лица могут вызывать нежелательную реакцию у окружающих, например, отсутствие улыбки при приветствии может быть истолковано как недружелюбие. Возможно, будет полезно вместе просмотреть фотографии и, используя список возможных чувств, посмотреть, насколько клиент и терапевт согласны в выражениях лица и в том, как они передают чувства человека на снимке.



КПТ СДВГ

Эмоции можно разыгрывать только с помощью мимики. Затем последующее введение позы тела и языка в эти ролевые игры поможет клиенту сформировать репертуар социальных сигналов. Можно использовать список эмоций, из которого терапевт и/или клиент могут выбрать эмоцию для проигрывания ситуации или для того, чтобы угадать изображаемую эмоцию (например, терапевт может разыграть ролевую игру вовремя приема пищи и изобразить чувство удовольствия, а клиент должен угадать).



КПТ СДВГ

Поза

Информирует других об отношении, например, сутулость может быть истолкована как лень/незаинтересованность. Вертикальное положение тела может сообщить окружающим о том, что им уделяется внимание. Фотографии в интернете также можно обсуждать с этой точки зрения.



КПТ СДВГ

Движения тела

Движения тела придают особый акцент тому, что говорится. Однако чрезмерное использование может раздражать других, например, возня или ерзанье, указание пальцем на кого-то может восприниматься как пугающее или провокационное. Кивок головой, когда кто-то говорит, показывает, что его поняли и что вы согласны с ним. Их и поддерживающий.



КПТ СДВГ

Физическая близость

Сообщает другим о намерениях. Дистанция и личное пространство будут разными у разных людей, например, вы стоите ближе к другу, чем к незнакомцу. Личные границы обычно нарушаются, когда человек ведет себя агрессивно и провокационно.



Распознавание эмоций

Неправильная оценка социальных ситуаций может быть результатом неправильного толкования социальных сигналов. Эти базовые навыки социального восприятия имеют решающее значение для распознавания соответствующего социального поведения и вовлечения в него. Их можно отрепетировать в ролевой игре и смоделировать соответствующую реакцию. В частности, люди с РДВГ могут быть менее способны распознавать эмоциональные сигналы из-за плохого контроля внимания. Это означает, что они находятся в невыгодном положении из-за неспособности соответствующим образом адаптировать свое поведение в ответ на настроение другого человека.



КПТ СДВГ

Социальная информация, основанная на вербальных и невербальных сигналах, постоянно требует прочтения и интеграции. Важно, чтобы ответ клиента мог быть смещен в соответствии сменяющимися сигналами и распознавание эмоций является важным аспектом процесса. Чтобы иметь возможность лучше понимать других, клиентов с РДВГ необходимо поощрять обращать внимание на "подсказки" или индикаторы (некоторые из которых могут быть неуловимыми) о том, как этот человек может себя чувствовать, то есть в каком настроении он может находиться.



КПТ СДВГ

Полезным упражнением с клиентами является просмотр видеозаписей социального поведения (телевизионные программы особенно хороши для этой цели) и анализ эмоций, представленных вместе. Благодаря положительному подкреплению суждений клиента у него появится большая уверенность в правильной интерпретации социальных ситуаций. Также может быть полезно развить тему дальше, поставив видео на паузу и обсудив последствия поведения/взаимодействия, как, по их мнению, отреагирует другой человек. Это побудит человека с СДВГ задуматься о последствиях поведения и рассмотреть альтернативные возможности вместо того, чтобы бросаться в дело обеими ногами и принимать поспешные решения или неверные предположения, основанные на неадекватной информации.



Модификация и регуляция социального поведения в различных ситуациях

До сих пор обсуждались методы обучения социальным навыкам, которые человек может использовать для улучшения вербальных и невербальных методов общения. Однако социальное взаимодействие - это динамичный процесс, который обычно предполагает быстрые изменения в оценке ситуации и способности реагировать соответствующим образом. Особой трудностью для людей с РДВГ является саморегуляция. Это означает, что они могут не очень хорошо изменять свое поведение в сложных социальных ситуациях, точно так же, как они могут испытывать трудности в определении едва заметных изменений в отношении других людей. Реагирование на изменяющиеся требования в социальных ситуациях становится проблемой, поскольку у них вырабатывается определенный способ поведения, который работает в одной обстановке, но не в другой. Поэтому может быть полезно разыграть изменяющиеся социальные требования и обратить внимание на изменения в моделях поведения.



КПТ СДВГ

Типы социальных ситуаций, которые могут быть проблематичными для людей с РДВГ, включают создание и поддержание дружеских отношений, общение с представителями противоположного пола, проблемы с общением с большим количеством людей в социальной ситуации, поддержание важных и/или формальных контактов, реагирование на критику, принесение извинений и/или признание ошибок, а также раскрытие статуса РДВГ.

1. Заведение и поддержание дружеских отношений

Хотя некоторым людям с РДВГ может казаться, что они находятся в центре внимания, на самом деле им может не хватать многих значимых отношений или настоящей дружбы. Признание того, что межличностные отношения требуют взаимных усилий и вклада, является хорошей отправной точкой. Однако людям с РДВГ гораздо труднее поддерживать дружеские отношения во взрослом возрасте, чем в детстве. Во взрослом возрасте существуют меньше "принудительных" социальных возможностей, чем те, которые были у них в детстве, таких как игры в школе. Таким образом, у детей с РДВГ, по крайней мере, есть круг сверстников, к которым они могут обратиться за подкреплением (как положительным, так и отрицательным) своего социального поведения. Тем не менее, заводить друзей и сохранять их давняя проблема. Это приводит к тому, что у некоторых взрослых появляется склонность импульсивно сворачивать отношения на ранней стадии.



КПТ СДВГ

Поэтому важно подкрепить идею о том, что отношения требуют настойчивости и гибкости, но для этого необходимо научиться точно воспринимать социальные ситуации. Проблемы с вниманием могут привести к тому, что люди забывают о договоренностях или не поддерживают связь. Стратегии тайм-менеджмента помогут людям планировать встречи с друзьями, напоминать им о назначенной встрече и запоминать важные даты, такие как дни рождения. Мы можем использовать телефоны для напоминания и для организации нашего поведения.



2. Разговоры с представителями противоположного/своего пола

Люди с РДВГ обладают естественным энтузиазмом, но это может привести к тому, что они станут возбужденными и чрезмерно активными при встрече с кем-то, к кому их влечет. Это может быть воспринято негативно. Их нетерпеливость может привести к тому, что они будут раздвигать границы и стремиться к эскалации интимных отношений более быстрыми темпами, чем это ожидается или приемлемо для другой стороны. Ролевые игры, призванные побудить индивидов обратить внимание на поведение и язык тела интересующего их человека, а затем сопоставить их и это может быть полезным упражнением для человека с СДВГ. Это учит их концентрировать свое внимание и подавлять импульсивные реакции и/или предположения.



КПТ СДВГ

3. Общение с незнакомыми людьми

В то время как большинство людей испытывают некоторую тревогу по поводу вхождения в социальные ситуации, в которых они никого не знают или знают очень мало людей, люди с РДВГ часто остро беспокоятся о своей способности справляться в таких социальных условиях. Это происходит потому, что в прошлом они часто получали негативные отзывы, когда клиент говорил что-то не то, что-то, привлекающее к себе нежелательное внимание, чувствовал себя глупым или воспринял незаинтересованность или отвержение со стороны других. Общественные мероприятия могут быть пугающими, и клиенту можно помочь, тщательно спланировав и отрепетировав соответствующее социальное поведение заранее.



Терапевт должен пересмотреть стратегии, которые клиент находил полезными в прошлом, наряду с техниками, которые он успешно использовал для решения проблем на предыдущих сессиях, которые могут быть адаптированы для этой цели, например, отвлекающие или вызывающие негативные мысли. На сессиях актуальные новости, представляющие интерес для клиента, могут быть отрепетированы в разговоре. Клиента следует направлять на соблюдение правил взаимодействия. Заранее готовясь к светскому мероприятию, клиент может выбрать три актуальные новости и/или рассказать интересные подробности, касающиеся недавнего личного мероприятия. Это вооружит клиента тем, о чем можно поговорить, если он беспокоится, что у него могут закончиться дела сказать и/или ляпнуть что-то неуместное и выглядеть глупо.



КПТ СДВГ

Хотя такая подготовительная работа на сессиях может повысить уверенность клиента в социальной обстановке, ему не следует все время говорить о себе или монополизировать беседу. Важная техника, которой нужно научить клиента, - это мотивировать другого человека рассказывать о себе, поощрять клиента задавать вопросы и выслушивать ответы. Целевой человек не должен чувствовать, что его допрашивают, но что человек, с которым они разговаривают, действительно заинтересован в том, что они хотят сказать. Ролевые игры на сеансах помогут клиенту найти правильный баланс.

4. Ведение важных и официальных бесед

Люди с РДВГ иногда могут казаться чересчур фамильярными из-за отсутствия формальности, плохого контроля над импульсами и/или беспокойства. Очень вероятно, что это будет воспринято окружающими как то, что они не воспринимают этот вопрос или ситуацию всерьез. Они могут показаться поверхностными, безразличными и/или безответственными. Чрезвычайно важно, чтобы люди с РДВГ надлежащим образом реагировали на формальность ситуации. Например, при взаимодействии с лицами, обладающими властью, на собеседовании, люди с РДВГ должны иметь в виду, что чрезмерная формальность воспринимается лучше, чем неформальность. На рабочем месте им необходимо придерживаться определенного уровня профессионализма при взаимодействии с коллегами и руководством.



КПТ СДВГ

Клиенту, возможно, потребуется разработать различные методы управления впечатлением, такие как манера обращения к представителям власти; проанализировать использование сленга и бранных слов, обычно используемых клиентом, на предмет приемлемости, поскольку некоторые слова являются неподходящими для официальных мероприятий и может даже вызвать обиду; и отслеживать скорость речи, поскольку серьезные и важные разговоры, скорее всего, будут вестись медленнее.



КПТ СДВГ

Одной из наиболее часто встречающихся формальных ситуаций является собеседование при приеме на работу. Люди с РДВГ часто оказываются в невыгодном положении на собеседовании из-за своих симптомов, которые в этой ситуации усугубляются тревогой, заставляя их отвлекаться, не до конца вслушиваться в вопросы, давать импульсивные ответы и ерзать на своем месте. Людям с РДВГ особенно важно хорошо подготовиться к таким мероприятиям. Первый шаг - разработать маршрут до места назначения с расписанием по времени. Опаздывать, выглядеть разгоряченным и покрасневшимся – не самое лучшее начало и неоправданно усилит беспокойство. Практика задавать вопросы для повторения или перефразирования может быть полезным навыком для развития и репетиции в процессе терапии.



5. Отказ от необоснованных просьб

Иногда люди с РДВГ могут соглашаться с необоснованными требованиями, поскольку стремятся угодить другим. Некоторые люди могут быть уязвимы для эксплуатации со стороны других. Это может означать, что они оказывают на себя давление, заставляя выполнять определенные роли или функции в соответствии со стандартами, которых они не могут достичь, и подводят человека, которого стремятся расположить к себе или произвести впечатление. Они могут вести себя так, что это причиняет вред другим людям, которые их любят. Клиенту необходимо распознать эту модель взаимодействия, признать ее и решить.



КПТ СДВГ

Сессии, которые фокусируются на восприятии социальной перспективы (путем оспаривания негативных мыслей и предположений; выявления дисфункциональных предположений о слабости и неудаче; и разыгрывания различных ролей), репетиции ситуаций, в которых признаются ошибки и приносятся извинения за них, подготовят клиента к применению этого на практике *in vivo*. Некоторых лиц могут попросить выполнить незаконные вещи, например, украсть предметы, доставить наркотики. Они могут подвергаться давлению со стороны сверстников, вынуждая рисковать и совершать опасные или безрассудные поступки.

Терапевт может научить клиента оценивать выполнимость просьб, составив список преимуществ и недостатков выполнения просьбы. Рекомендуется, чтобы первоначально они были изложены в письменной форме. Конечно, это невозможно во время социального взаимодействия, и стратегии откладывания принятия решений должны быть проработаны с терапевтом, например, клиенту можно помочь, отрепетировав такое заявление, как "Хорошо, я немного подумаю и вернусь с ответом" или "Я не буду говорить об этом прямо сейчас, так как мне нужно идти, но я позвоню тебе позже". Как только клиент привыкнет применять эту технику, его следует поощрять к тому, чтобы он научился применять ее как когнитивный процесс, чтобы он мог немедленно реагировать. Однако записи обладают огромной силой, и их не следует недооценивать. Важный выбор всегда следует делать, записывая преимущества и недостатки вариантов. Стратегии отказа брать на себя дополнительные обязанности или требования могут быть разработаны клиентом и терапевтом в виде ролевых сценариев, в которых клиент репетирует, как сказать "нет" и отказаться выполнить просьбу.

6. Работа с критикой

Люди с РДВГ привыкли к критике, их критиковали родители дома, учителя в школе и другие люди. Их, возможно, называли упрямыми, гиперактивными, неуправляемыми, разрушительными, оппозиционными, агрессивными, грубыми, непослушными, бесполезными или ленивыми. Взрослых учат, что критика всегда должна быть конструктивной, но этот метод выражения критики применяется не всегда. Даже если это так, то, что слышит ребенок или молодой человек с РДВГ, - это только деструктивная критика. Дети с РДВГ пытались добиться большего, они пытались совершенствоваться и радовать свою мать, учителя, соседей и друзей, но у них никогда не получалось как следует. Их намерения благие, но часто не достигаются из-за того, что что-то встает на пути или отвлекает их от намеченного курса действий. Но просто то, что их всегда критиковали и они привыкли к этому, не означает, что это больше не причиняет боли.



КПТ СДВГ

Со временем люди учатся создавать стену, которая защищает их от нападок и критики. Это может быть воспринято как отсутствие интереса к влиянию их поведения или отношения к семье и друзьям. Чем больше критики они получают, тем больше они защищают себя, игнорируя ее. Это означает, что полезная обратная связь будет игнорироваться. Что им нужно усвоить, так это описанный выше цикл негатива и то, как негативное отношение, являющееся их защитным механизмом, обеспечивает цикл обратной связи, который вызывает негативное поведение и критическое отношение со стороны других. Им нужно научиться прислушиваться к конструктивной части обратной связи, поскольку это может дать важный совет, и стать менее чувствительными только к одной части сообщения.



7. Извинение и признание ошибок

Умение извиняться - сложный навык, поскольку предполагает признание ошибки. Это заставляет некоторых людей чувствовать себя незащищенными. В детстве люди с РДВГ часто чувствовали себя виноватыми или ответственными за то, за что они не должны были отвечать. Они часто извинялись за проступки, которые они недо конца понимали, например, они не могут продумать исход данной ситуации, и им это явно не объяснялось, например, не привлекалось их внимание к потенциальным опасностям игры со спичками. Во взрослом возрасте некоторые люди часто становятся педантичными и склонными к спорам. Они больше заинтересованы в том, чтобы объяснить свою точку зрения и быть "правыми", чем думать о проблеме с другой точки зрения.



Невозможно быть правым все время, и способность идти на компромисс важна при ведении переговоров о межличностных отношениях. Терапевт должен помочь клиенту найти точки соприкосновения и компромисс, даже если это означает согласие с тем, что существует разница во мнениях. Однако, поскольку у некоторых взрослых с РДВГ есть защитное отношение и нетерпимость к установкам, которые не похожи на их собственные, они могут вести себя так, что это причиняет вред другим. Они должны распознать эту модель взаимодействия, признать ее и разрешить. Сессии, которые фокусируются на восприятии социальной перспективы (например, путем оспаривания негативных мыслей и предположений, которые могут выявить дисфункциональные предположения о слабости и неудаче; и разыгрывания различных ролей), репетиции ситуаций, в которых признаются ошибки и приносятся извинения за них, облегчат клиенту применение этого на практике.



8. Раскрытие статуса РДВГ

Один из самых сложных социальных вопросов для людей с РДВГ заключается в том, следует ли сообщать о том, что у них есть это расстройство, знакомым, коллегам, друзьям и семье. Если они решают раскрыть эту информацию, они должны оценить, на каком этапе своих отношений им следует это сделать. Это очень важный вопрос для взрослых с РДВГ и большой источник беспокойства. Некоторые люди решают проблему, рассказывая об этом всем, кого они встречают, независимо от ожидаемого результата. Другие люди очень осмотрительны и не рассказывают об этом даже близким членам своей семьи. Основная проблема, по-видимому, связана с беспокойством о том, как другие люди отреагируют на них, если узнают, что у них это расстройство.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ беспокоятся о возможной стигматизации или неточном понимании расстройства и полагают, что это повлияет на них в будущем, например, из-за дискриминации на рабочем месте. Например, клиент работает менеджером в супермаркете и он в ужасе от того, что его босс узнает, что у него РДВГ и что он принимает лекарства. Хотя он хорошо справляется со своей работой и получил повышение, он думал, что это помешает дальнейшему продвижению по службе, поскольку будет воспринят как человек, неспособный справиться с большей управленческой ответственностью. Этот клиент также может быть очень обеспокоен тем, что персонал, которым он руководит, обнаружит, что у него СДВГ, поскольку он полагает, что станет источником неприятностей и будет определен как "псих", нуждающийся в психиатрическом лечении. Это вызывает у него беспокойство и стресс, поскольку требуются усилия, чтобы скрыть расстройство. Клиент чувствует, что не может быть самим собой, и чувствует себя изолированным, что усиливает детское чувство непонимания, одиночества и обособленности от других.



КПТ СДВГ

Другие люди с РДВГ реагируют совершенно по-другому, они действуют без разбора, будучи откровенно открытыми по отношению к людям, которых они не очень хорошо знают, и предоставляя им много личной информации и ненужных подробностей о себе, включая их статус РДВГ. Это заставляет людей чувствовать себя некомфортно и замыкаться в себе, что воспринимается человеком с РДВГ как отвержение. В качестве альтернативы, другие люди могут воспользоваться человеком с РДВГ, рассматривая его социальную незащищенность как возможность эксплуатировать его (например, поощряя его к участию в антиобщественных действиях).



КПТ СДВГ

Как только клиент решит сообщить кому-либо о том, что у него РДВГ, это будет полезно, если он сможет предоставить этому человеку некоторую письменную информацию о РДВГ и/или объяснить из первых рук, как ему можно помочь и/или какие изменения можно внести в среду, которые оптимизируют производительность. Например, быть точным и лаконичным в инструкциях и в их взаимодействии, давать обратную связь (конструктивно), если он проявляет чрезмерный энтузиазм, перебивает других, стоит слишком близко, говорит слишком громко и т.д. Вместо того чтобы ожидать, что он запомнит много информацию, он может записать ее, например, имея список дел, списки покупок и т.д. Обращение за социальной поддержкой - это конструктивная стратегия совладания, и если люди не хотят "выходить наружу" публично, им может оказаться полезным обратиться в службы поддержки РДВГ. Часто в этих группах есть интернет-чаты, которые являются важным источником практической информации и эмоциональной поддержки и к которым можно получить анонимный доступ.



КПТ СДВГ

КОМОРБИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ТРЕВОГА



КПТ СДВГ

Тревога является распространенным состоянием в нормальной популяции, но ее распространенность увеличивается у лиц с РДВГ, для которых уровень сопутствующей патологии, по имеющимся данным, составляет около 25%. Из этого утверждения выходит, что у большей части людей с РДВГ нет тревожных расстройств. Однако, существует много людей, которые могут формально не соответствовать категории расстройств, но при этом испытывать проблемы с тревогой, которые обычно проистекают из прошлого опыта и неуверенности в себе, и которые могут препятствовать их прогрессу в лечении. Можно утверждать, что показатели сопутствующей патологии РДВГ и тревожности являются следствием сходства симптомов РДВГ с симптомами тревоги (например, беспокойство, невнимательность, неиссякаемая умственная энергия).



КПТ СДВГ

У взрослых с РДВГ тревога, вероятно, будет выражаться несколькими способами. Они чаще страдают от выраженной застенчивости или восприимчивости к смущению или унижению, проистекающих из детства. У большинства людей с РДВГ тревога начинается в школе как тревога по поводу успеваемости, или например, когда им приходится вставать в классе и читать вслух. Они допускают ошибки и пропускают слова или даже пропускают целые строки. Их сверстники дразнят их или задирают; над ними смеются и обзывают. В таких ситуациях они могут либо отстраниться, либо импульсивно наброситься. В любом случае, это имеет негативные социальные последствия, и детям с РДВГ начинает не хватать способности уверенно взаимодействовать со своими сверстниками. Некоторые дети компенсируют это, пытаясь чрезмерно угождать другим или запугивая других детей. Другие компенсируют это "клоунадой", они могут искать дружбы в школе у детей, не входящих в круг их сверстников, у детей старше или младше их самих, или предпочитая компанию взрослых.



КПТ СДВГ

С течением времени небольшие тревоги превращаются в большие; это особенно усугубляется по мере того, как они продвигаются по пути образования в взрослую жизнь, когда сталкиваются с более высокими академическими и социальными требованиями, и еще до того, как они осознают, где они находятся, тревожный ребенок с РДВГ вырабатывает способ взаимодействия с миром, основанный на неопределенности и незащищенности.

Тревога становится всеобщей, влияя на их убеждения и уверенность в том, добьются ли они успеха практически во всем, что они пытаются сделать. Это часто приводит к озабоченности или чрезмерному беспокойству по поводу уровня их компетентности для выполнения различных ролей и сфер деятельности. В современном обществе людей оценивают по успеху, по работе, которую они выполняют, по дому, в котором они живут, по машине, на которой они ездят. Эти проявления символизируют достижение. Необходимо выполнить множество требований, которые завязаны на способности выполнять несколько задач и брать на себя множество обязанностей и ролей. Мать, отец, жена, муж, дочь, сын, друг, член общины, молодежный лидер, наставник, менеджер, служащий, исполнительный директор: этими ролями приходится жонглировать, и может возникнуть ощущение, что в воздухе висит множество тарелок, которые нужно постоянно вращать.



КПТ СДВГ

Общество быстрое и занятое, и люди с РДВГ предпочитают скорость точности, поэтому, когда они работают в быстром темпе, они допускают ошибки и терпят неудачу. Чувство тревоги значительно усложняет все остальное, о чем человек должен думать или делать. Беспокойство влияет на когнитивные процессы, влияет на оценку ситуаций, вызывая внутреннее смещение акцента на преувеличенный самоконтроль и саморегулирование. Тревога увеличивает трудности с концентрацией внимания и импульсивность. Она может подавлять способность рассуждать рационально.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ, у которых уже есть когнитивная уязвимость, станут еще более уязвимыми в ситуации, провоцирующей тревогу, когда действуют менее компетентно. Симптомы РДВГ становятся гораздо более выраженными в те моменты, когда клиентам, вероятно, больше всего нужно сосредоточиться. Это вызывает трудности с нейропсихологической оценкой симптомов РДВГ (внимания и импульсивности), поскольку клиенты могут стать очень тревожными в условиях тестирования. Чтобы оценить индивидуальные различия в сильных и слабых сторонах, многие когнитивные тесты начинаются с очень простых заданий и постепенно становятся все более сложными. Это означает, что человек будет последовательно достигать стадии, когда он не сможет ответить на вопрос или решить проблему или головоломку. Это подчеркивает их трудности, а процедура тестирования может укрепить глубинные убеждения в том, что они "глупые", и/или напомнить им о негативном школьном опыте. Если люди становятся очень тревожными, они вряд ли будут хорошо справляться с заданиями и легко откажутся от них, в результате чего не смогут раскрыть свой потенциал.



У детей с сопутствующей тревожностью и РДВГ наблюдались большие нарушения в выполнении заданий. Тревога отвлекает некоторые ресурсы от обработки и хранения в системе рабочей памяти. Однако также было высказано предположение, что тревога выполняет мотивационную функцию, поскольку усиливает возбуждение, что, в свою очередь, может улучшить контроль внимания. Это, вероятно, происходит в задачах, которые не требуют сохранения информации (т.е. обработки в памяти), но требуют, чтобы человек подавлял реакцию, например, непрерывное выполнение или остановка заданий. При выполнении таких заданий дети с РДВГ и сопутствующей тревожностью могут проявляться лучше. К сожалению, такие исследования не проводились со взрослыми с сопутствующим РДВГ и тревожностью.



Трудности могут быть более заметными в соответствии с социальными, академическими или профессиональными требованиями и/или жизненным курсом клиента. Например, у человека могут быть общие проблемы с тревогой и социофобией в зависимости от сложившейся ситуации, а во время сильного стресса он может дополнительно испытывать симптомы паники. Обычно тревожное отношение ко всему и ко всем, с кем или чем они сталкиваются, может стать более специфичным для людей с РДВГ и проявляться как социальная тревожность. Ощущение отличия от своих сверстников заставляет некоторых людей регулярно сравнивать себя с другими, что приводит к тому, что они воспринимают свои негативные черты ярче, и акцентируют внимание на положительных характеристиках других людей. Некоторым людям может часто требоваться подтверждение в социальных ситуациях, например: "Все ли со мной было в порядке? Я не был бестактен, правда?".



КПТ СДВГ

Они беспокоятся, что на общественных собраниях за ними наблюдают другие, и становятся застенчивыми и неуклюжими. Некоторые люди пытаются компенсировать это, разыгрывая дурака и глупо шутя. В таких случаях цель лечения тревожности должна быть направлена не только на уменьшение тревожных ощущений, чувств и поведения, но и на то, чтобы успокоить человека, чтобы он не реагировал чрезмерно возбужденно, привлекая к себе излишнее внимание странным и/или неподобающим образом(иногда воспринимаемым другими как ребячество). Это делается не для того, чтобы ослабить естественную креативность и энтузиазм людей с РДВГ, а для того, чтобы побудить человека вести себя более сдержанно и зрело.



КПТ СДВГ

На прошлой неделе как часто вы испытывали симптомы	никогда	редко	иногда	часто	очень часто	постоянно
Генерализованная тревога						
Я тревожился о деньгах, например, не мог оплатить счета						
Я тревожился, что не справляюсь с работой						
Я тревожился о здоровье						
Я тревожился о будущем, о будущих неудачах						
Я тревожился об отношениях						



КПТ СДВГ

На прошлой неделе как часто вы испытывали симптомы	никогда	редко	иногда	часто	очень часто	постоянно
Социальная тревога						
Я чувствовал смущение						
Я избегал общественных мероприятий						
Я избегал толпы						
Я был обеспокоен своим общением						
Я беспокоился о новых знакомствах, не мог начать и поддержать разговор						



КПТ СДВГ

На прошлой неделе как часто вы испытывали симптомы	никогда	редко	иногда	часто	очень часто	постоянно
Паническое состояние						
Я чувствовал стеснение в груди						
Я чувствовал учащенное сердцебиение						
Я думал, что у меня сердечный приступ						
Я чувствовал головокружение и слабость						
Я чувствовал жар и холод						



КПТ СДВГ

На прошлой неделе как часто вы испытывали симптомы	никогда	редко	иногда	часто	очень часто	постоянно
ОКР симптомы						
Я чувствовал себя неуютно, если дома было грязно/не убрано						
Мне нужно было много раз проверять, прежде чем успокоиться						
Я делал что-то по заведенному порядку, иначе волновался						
У меня были навязчивые мысли						
Я был склонен к перфекционизму						



Терапия тревожности

Существуют два основных различия при лечении взрослых с РДВГ и сопутствующей тревожностью по сравнению с лечением взрослых без РДВГ, у которых есть тревожность:

- Важно признать совпадение симптомов тревоги и РДВГ и попытаться распутать симптомы, которые лучше устраняются с помощью методов, обсуждаемых на занятиях, для улучшения внимания и снижения импульсивности.
- Поскольку взрослым с РДВГ трудно откладывать удовлетворение, важно внедрить систему немедленного вознаграждения, чтобы положительно закрепить успех и достижение результатов на гораздо более частой основе, чем это обычно применяется.



КПТ СДВГ

Предлагаемая модель КПТ адаптирована к 4 основным этапам процесса терапии тревоги:

- Психообразование о модели тревожности с точки зрения КПТ
- Обучение справляться с негативными мыслями
- Развитие самоконтроля
- Изменение поведения



Психообразование

Психообразование является важной частью процесса лечения. Важно объяснить клиенту, что с ним происходит, когда он начинает беспокоиться, и рассмотреть необходимость обратиться к врачу. Процесс включает в себя обучение клиента тому, как его тревога влияет на его мысли, чувства и поведение, и объяснение того, что между этими факторами существует взаимосвязь. В определенной степени это также означает нормализацию тревожности как функционального процесса. Каждый человек в какой-то момент своей жизни испытывает тревогу. Это нормальная и здоровая реакция. Беспокойство обычно возникает во время стресса или опасности. Это позволяет подготовиться к реакциям борьбы или бегства. Люди понимают, что если бы их посадили в клетку с тиграми, они бы почувствовали тревогу. Их тревога заставила бы их обостренно осознавать надвигающуюся опасность и готовиться к самозащите.



КПТ СДВГ

Тревога заставляет системы организма работать быстрее, что влияет на эмоции, мысли, чувства и поведение. Тревога дисфункциональна, если этот процесс активизируется, когда человек находится не в клетке с тиграми, а когда он собирается пропустить крайний срок, потому что не выполнили задание или потому что ему нужно идти на вечеринку по случаю дня рождения своей сестры.



Объяснение когнитивно-поведенческой модели тревожности, то есть взаимосвязи между мыслями, чувствами и поведением в развитии и поддержании тревожности, обычно имеет смысл для клиента на интеллектуальном уровне. Например, объяснение того, что чувство беспокойства из-за пропущенного срока ожидания, установленного их руководителем на работе, может влиять на мысли (например, человек думает: "Я бесполезен, у меня всегда все не получается правильно. Меня не повысят", что может привести к физическим реакциям нервозности (тошнота, сухость во рту, чувство нервозности и напряжения, усиление паники). Помимо изучения взаимосвязей между мыслями, чувствами и поведением, клиент должен также понимать, насколько эти факторы динамичны и как они работают вместе, вызывая ухудшение функционирования. Усиливают ли они цикл или являются ли негативной спиралью растущей тревоги, когда мысли, чувства и поведение подпитывают друг друга по мере того, как становятся все более серьезными.



Пример СМЭР клиента с РДВГ

Мысли	Эмоции	Физические реакции	Поведение
Я не могу сосредоточиться Я потеряю концентрацию Наверное, со мной что- то не так, если я не могу это сделать Все остальные будут критиковать меня Я схожу с ума Я не могу с этим справиться Я бесполезен	Страх Чувство потери контроля Чувствую себя на взводе Раздражение Чувствую себя неуютно	Повышенное беспокойство Потные ладони Учащенное сердцебиение Бледность Боль в животе	Беспокойно расхаживаю Не желаю никуда выходить Придумываю отговорки, чтобы не делать дела Курю Употребляю алкоголь, чтобы успокоиться Выставляю себя дураком Веду себя импульсивно



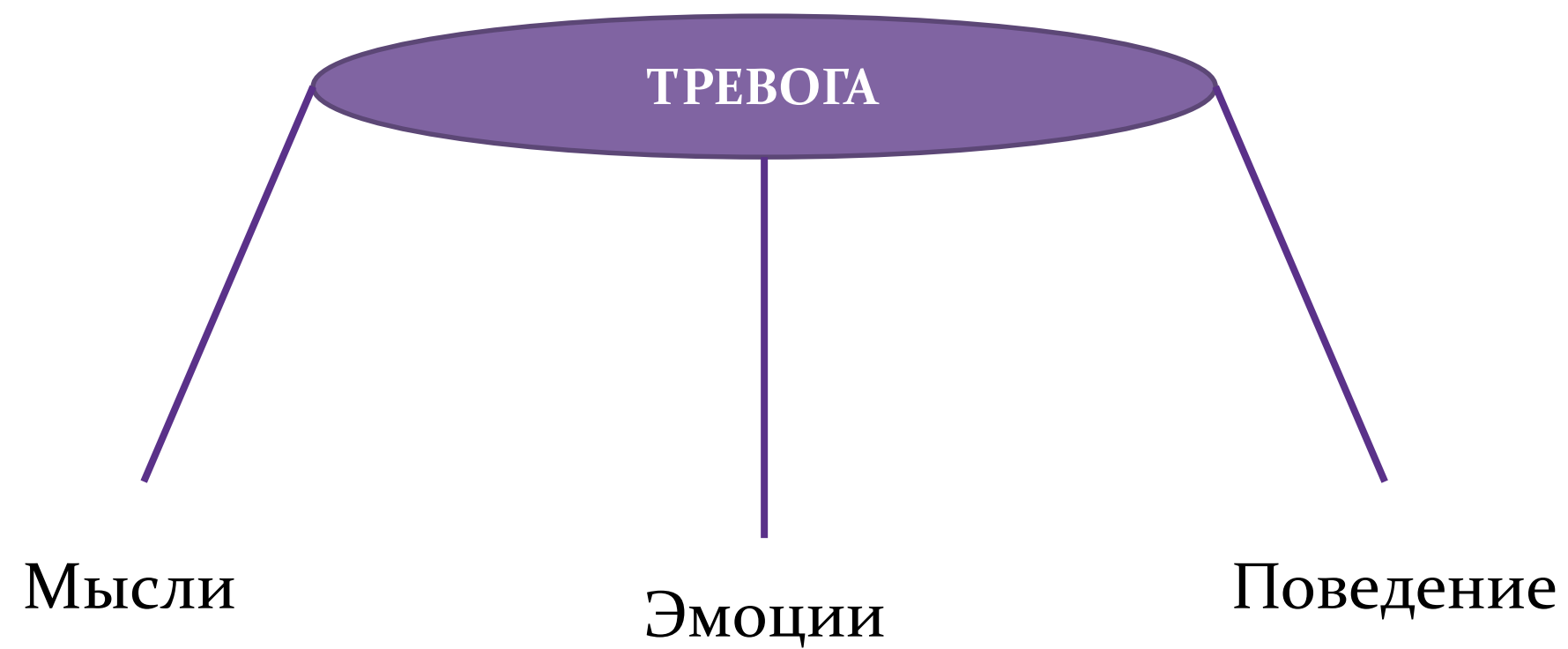
КПТ СДВГ

Тревогу можно описать как стул на трех ножках. Если одна из ножек выбита, то тревожный стульчик будет неустойчивым, упадет и будет разрушен.

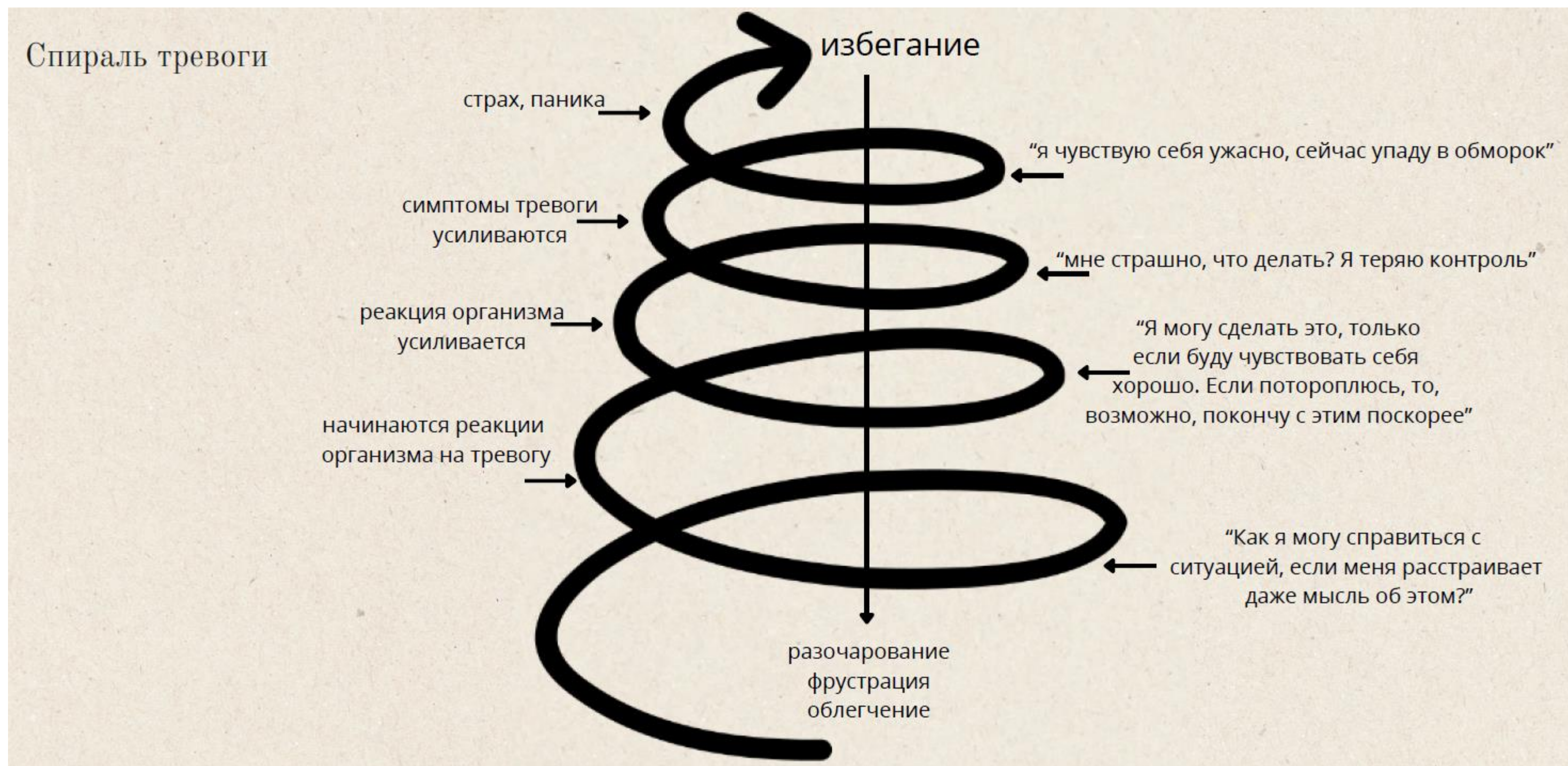
Тревога усугубляет когнитивный дефицит, и если клиент может научиться уменьшать свою тревогу, то у него больше шансов справиться с обстановкой и ситуациями, воспринимаемыми как провоцирующие тревогу. Ножки стола - это мысли, чувства и поведение. Клиенту следует сообщить, что вы собираетесь научить его способам нокаутирования каждой из этих «ножек», то есть использовать трехстороннюю атаку.



КПТ СДВГ



Спираль тревоги



КПТ СДВГ





КПТ СДВГ

Работа с негативными мыслями

Тревога связана с неприятными негативными мыслями. Они возникают автоматически и проносятся в голове в ситуациях, которые провоцируют тревогу. Например, если человек беспокоится о том, что о нем думают другие люди, то он может испытывать беспокойство, разговаривая с людьми, на которых он хочет произвести впечатление, но которых не очень хорошо знает. Это может означать, что человек изменит свое поведение, чтобы уменьшить чувство тревоги, например, не будет участвовать в разговоре, чтобы избежать оценки со стороны других.



КПТ СДВГ

Общие мысли, выражаемые нашими клиентами, включают:

- думают, что с ними, должно быть, что-то серьезно не так
- думают, что они ведут себя глупо
- думают, что их критикуют другие
- думают, что у них не все в порядке с психикой
- думают плохо о себе
- принижают себя
- думают, что они неудачники



КПТ СДВГ

Клиенты должны узнать, как то, что они думают и во что верят, влияет на их чувства и поведение. Например, если человек просыпается, услышав грохот посреди ночи, и думает, что это грабитель, он может испугаться и вызвать полицию. Но это случилось только потому, что он оставил окно открытым и подул ветер и из-за этого предмет могло сдуть. В итоге, если они это поймут, им будет легче встать и закрыть окно. Таким образом, разные мысли в одной и той же ситуации заставляют человека испытывать разные чувства и вести себя по-разному.



Негативные, вызывающие тревогу мысли трудно идентифицировать по целому ряду причин. Они привычны и мелькают в сознании каждого, а мы даже не осознаем этого. Они автоматичны и возникают без усилий, а некоторые мысли еще больше усиливают тревогу, например:

- “Я выставлю себя дураком” - предвидение
- “Я не смогу с этим справиться” - “я не смогу это вынести” - катастрофизация
- “Я не могу дышать, я задыхаюсь” - неверная интерпретация реакций организма
- “Я должен уйти отсюда” - мысли об избегании



КПТ СДВГ

Распространенным методом, который, как было доказано, полезен для того, чтобы помочь клиентам выявить негативные мысли, является ведение "дневника мыслей". Это запись о ситуации, в которой они находились, о том, что происходило у них в голове в то время и что они чувствовали. По сути это СМЭР. Затем эти чувства можно оценить по тому, насколько они в них верят. Например, запись в дневнике мыслей человека, у которого возникли трудности на работе, который испытывает давление со стороны своего работодателя, требующего уложиться в установленный срок, а также испытывает социальную тревогу по поводу общения с коллегами.



КПТ СДВГ

Время/дата	Ситуация	Эмоции/чувства	Мысли	Насколько я в это верю?
ПН, 4-4, 8.15	Готовлюсь к работе	Чувствую тревогу	Я не переживу эту неделю Думаю, я болен	40%
ПН, 4-е, 10.15	Начальник хочет меня видеть	Страх	Меня уволят	50%
ВТ, 5-е, 18.15	Иду в бар с коллегами	Смущение, тревога	Мне нечего сказать, они посчитают меня скучным	70%
СР, 6-е, 12.00	Крайний срок сдачи работы – конец рабочего дня	Паника	Не успею Не смогу сделать Все кончено	50%



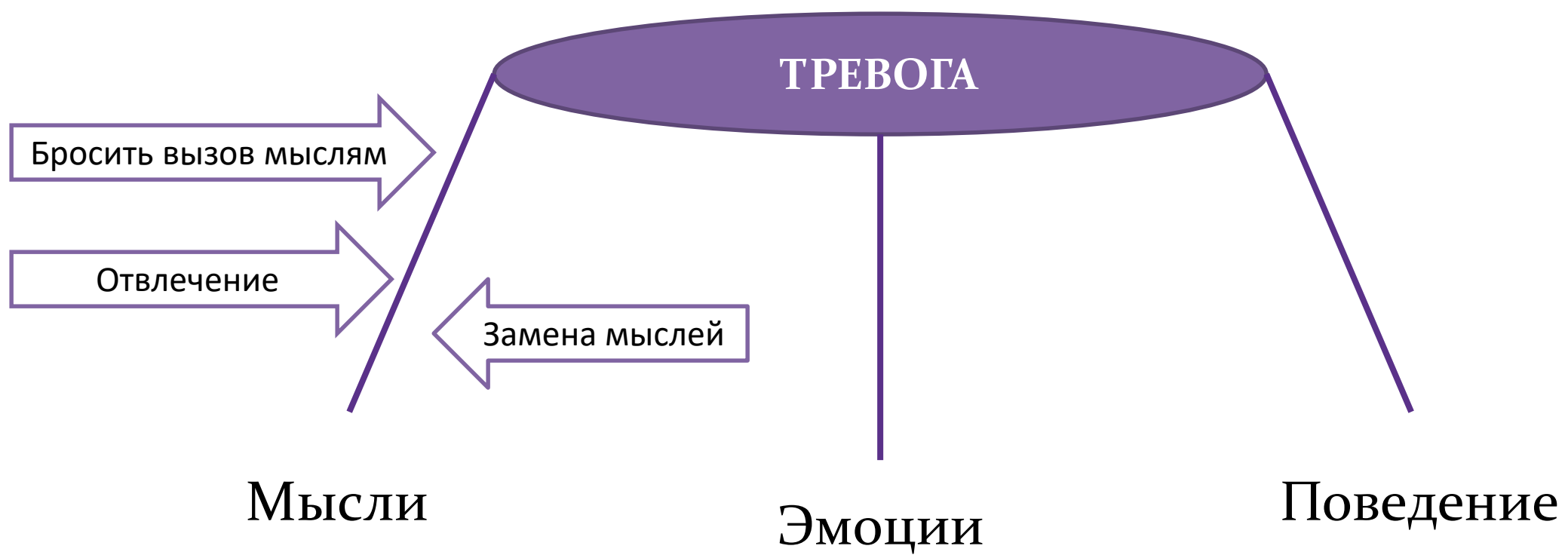
КПТ СДВГ

Как только человек научится применять когнитивные техники для борьбы с негативными мыслями, дневник также можно использовать для записи проблем, а затем повторно оценить, насколько сильно он в них верит. Используя этот метод, клиент сможет оценить успешность решения когнитивных задач демонстрируясь ослаблением его системы убеждений.

Время/дата	Ситуация	Эмоции/чувства	Мысли	Насколько о я в это верю?	Адаптивный ответ	Насколько я в это верю?
ПН, 4-4, 8.15	Готовлюсь к работе	Чувствую тревогу	Я не переживу эту неделю Думаю, я болен	40%	Я чувствовал себя также в прошлый понедельник	20%
ПН, 4-е, 10.15	Начальник хочет меня видеть	Страх	Меня уволят	50%	Я точно не знаю, зачем меня вызывают. Меня также вызывали в прошлую пятницу и похвалили	20%
ВТ, 5-е, 18.15	Иду в бар с коллегами	Смущение, тревога	Мне нечего сказать, они посчитают меня скучным	70%	Я могу просто поддерживать разговор, не обязательно активно участвовать	30%
СР, 6-е, 12.00	Крайний срок сдачи работы – конец рабочего дня	Паника	Не успею Не смогу сделать Все кончено	50%	Я все распланировал, если не буду отвлекаться - успею	25%



КПТ СДВГ





КПТ СДВГ

А рисунке выше показаны 3 техники, которые можно использовать, чтобы справиться с негативными мыслями:

- Бросить вызов негативным мыслям
- Заменить негативные мысли более позитивными
- Отвлечь внимание от негативных мыслей



КПТ СДВГ

На сессии терапевту нужно будет обучить клиента технике, отрепетировать ее с клиентом и определить, что работает лучше всего и когда. Например, с размышлениями о будущей работе лучше всего справляться с помощью когнитивных задач, замена негативных мыслей на позитивные может быть полезна для мотивации клиента завершить задание, отвлечение от негативным мыслей может быть полезно при преодолении социальной тревожности. Таким образом, проживание тревоги это процесс, и методы будут различаться по эффективности в зависимости от того, на каком этапе они применяются.



КПТ СДВГ

Когнитивные техники и процесс возникновения тревоги:

- При возникновении тревоги – выявляйте негативные автоматические мысли, выявляйте когнитивные искажения.
- В разгар тревоги – самоутверждения, позволяющие справиться с трудностями, самоинструкции, копинг-карточки, методы отвлечения внимания.
- При уменьшении тревоги – похвала, вознаграждение.



КПТ СДВГ

Точно так же, как мысли могут усиливать тревогу и плохое настроение, они также могут их ослаблять. Разные мысли в одной и той же ситуации заставляют людей испытывать разные чувства и вести себя по-разному. Это означает, что клиенты могут научиться изменять свое поведение, контролируя свои мысли. Этим навыком трудно овладеть. Терапевт должен начать с объяснения клиенту, что когда он чувствует тревогу или огорчение, то особенно уязвим к когнитивным ошибкам. По сути, это означает, что клиент смотрит на мир через очки, которые искажают то, что он видит. Распространенные ошибки мышления людей с РДВГ заключаются в том, что человек терпит неудачу и/или делает поспешные выводы ("все это совершенно безнадежно, это никогда не сработает, и я буду разорен, никто никогда больше не заговорит со мной").

Когнитивные искажения

- Все или ничего: клиент видит все в черно-белом цвете и не может понять, что есть какая-то золотая середина или серые зоны, например, «я никогда не смогу сосредоточиться».
- Чрезмерное обобщение: клиент делает общий вывод на основе одного события, часто предполагает, что что-то всегда будет происходить, даже если это произошло 1 раз, например, «в следующий раз я снова опоздаю на встречу».
- Катастрофизация: преувеличение вероятности событий, клиент думает, что все, что может пойти не так – пойдет не так, например, «из-за того, что я не оплатил счет за газ».
- Персонализация: клиент винит себя во всем неприятном, он верит, что все, что люди говорят и делают, является реакцией на него, например, «она вышла из комнаты, потому что я ее расстроил».



КПТ СДВГ

- **Негативный фильтр:** положительные аспекты ситуации игнорируются или неверно истолковываются, так что клиент настроен пессимистично, например, «при оценке моей работы мне сказали, что нужно усвоить новый навык, я бесполезен в своей работе».
- **Поспешные выводы:** у клиента автоматически возникает негативная интерпретация событий, даже при отсутствии фактов они склонны предсказывать будущее и читать мысли, когда есть мало доказательств, подтверждающих, например, «я был слишком медлителен, она думает, что я бесполезен».
- **Долженствование:** клиент считает, что он не соответствует стандартам или ожиданиям, не принимая во внимание, являются ли они разумными или реалистичными, они верят, что должны все делать правильно, например, «я всегда должен приходить вовремя».



Один из способов побудить клиента бросить вызов своему мышлению - заставить его представить, что он опытный юрист, который проводит "перекрестный допрос" мысли. Например, он мог бы задать себе следующие вопросы:

1. Какие у меня есть доказательства того, о чем я думаю?
2. Каковы доказательства того, что я не могу справиться? Подумай о случаях, когда я успешно справлялся в прошлом.
3. Не переоцениваю ли я вероятность того, что это событие произойдет?
4. Что самое худшее, что может случиться?
5. Что я могу с этим поделать?

К счастью, человек с РДВГ предрасположен к участию в когнитивной реструктуризации, поскольку имеет тенденцию позитивно реагировать на стрессовые ситуации. Это значит, что он стремится когнитивно переосмыслить ситуации и восприимчив к тому, чтобы думать о своих проблемах по-другому. Эта характеристика, вероятно, заставляет людей с РДВГ стойко переносить разочарования и придает им решимости попробовать еще раз.



Второй способ включения клиентов в когнитивную реструктуризацию состоит в том, чтобы научить их принимать точку зрения другого человека. Восприятие социальной перспективы - очень полезная техника, поскольку клиенты часто ожидают от себя чего-то такого, чего не ожидают от других. Терапевт может предложить клиенту представить, что к нему пришел друг, столкнувшийся с такой же проблемой. Что бы клиент мог сказать ему? Будет ли он относиться к другу также, как к себе в этой ситуации? Могут быть полезны методы, которые рассматривают альтернативные интерпретации или альтернативные результаты, например, замена мыслей типа “Я не могу справиться” на “Это сложно, но я справлюсь, если буду делать это шаг за шагом”.



КПТ СДВГ

Негативные мысли	Примеры когнитивной реструктуризации
Я просто недостаточно хорош	Я не идеален. Как и все, я хорош в определенных вещах и не очень хорош в других
Какой смысл пытаться?	Если не попробую, я не узнаю. Попытка сама по себе расширит мой опыт и мастерство. Никто не ожидает от меня идеальности
Что, если я совершу ужасную ошибку?	Все совершают ошибки. Совершать ошибки хорошо, потому что это лучший способ учиться
Мне нечего сказать, я скучный	У меня есть свое мнение, мысли и чувства. Я люблю читать и гулять. Возможно, мне нужно улучшить свою способность выражать себя. Я могу практиковаться в этом
Я никому не нравлюсь	Есть люди, которым я нравлюсь. У меня были отношения в прошлом, будут и в будущем



КПТ СДВГ

Негативные мысли	Примеры когнитивной реструктуризации
Все остальные проводят время лучше меня	Я не знаю этого наверняка. Просто потому что они кажутся более занятыми, это не значит, что они более удовлетворены
Было бы лучше, если бы я держался подальше от людей, потому что я не силен в отношениях	Если я останусь в стороне, я вообще не дам себе шанса. Наверное, со мной все будет в порядке, если я смогу расслабиться
Я могу эмоционально сломаться перед людьми и почувствовать себя смешным	У меня есть веская причина расстраиваться. Люди гораздо более понимающие, чем я думаю. Что плохого в проявлении эмоций?
Я безнадежен во всем. Я никогда не разберусь в себе	Просто делай шаг за шагом. Осуждать себя за все – это нонсенс. Я преодолевал и более сложные проблемы



КПТ СДВГ

Замена негативных мыслей позитивными

Проблема людей с РДВГ заключается в том, что у них часто нет большого количества успешного опыта, который мог бы уравновесить жизненные разочарования. Чаша весов, кажется, склоняется не в их пользу, и каждая их идея или каждый проект, который они начинают, заканчиваются ничем - обычно потому, что они не придерживаются ее и либо отвлекаются на что-то другое, что их интересует, и поэтому сдаются, когда задача становится более трудной, либо на завершение уходит больше времени, чем ожидалось. Это означает, что их негативные автоматические мысли могут иметь некоторую доказательную базу, и эта возможность делает их более сложным задачу оспорить это как "ошибку мышления".



КПТ СДВГ

Одно из решений заключается в замене негативных мыслей и предположений на позитивные мысли и убеждения, например, создание позитивных и мотивирующих самоутверждений. Выявление негативных мыслей и борьба с ними помогают уменьшить возникновение и эскалацию тревоги. Однако, как только человек вовлекается в полномасштабную тревогу, ему не всегда легко решать когнитивные задачи.



В таких случаях следует предложить клиенту перечислить когнитивные ошибки, которые были особенно актуальны. Очень уместно записать их на маленькие "карточки" и хранить в бумажнике или сумочке. Затем, если клиент становится очень встревоженным и не может вовлечь себя в альтернативный мыслительный процесс, все, что ему нужно запомнить, - это посмотреть на карточку, которая подтолкнет его к участию в процессе.

Замена на позитивные мысли вместо того, чтобы бороться с негативными мыслями, может быть более полезным методом для пациентов с РДВГ из-за их жизнестойкости и склонности не сдаваться. Это может быть более естественным способом для них справиться с негативными мыслями - идентифицировать их и немедленно наложить на них более позитивную и мотивирующую мысль. Например, если клиент думает: "Я не могу справиться с этой ситуацией, я потеряю контроль", он заменяет эту мысль на "я могу справиться. Я контролирую эту ситуацию".



КПТ СДВГ

Разговор с самим собой в форме позитивных самоутверждений и самоинструкций о том, как справиться с тревогой, может быть полезной стратегией, которая более доступна человеку на стадии прогрессирующей тревожности. Однако, замена негативных мыслей - это тоже процесс, требующий практики и терпения, но со временем делать это становится легче, поскольку процесс становится таким же автоматическим, как "старые способы" мышления.



КПТ СДВГ

Существует много позитивных утверждений, которыми можно заменить негативные мысли:

- Тревога не разрушительна, это нормальная человеческая реакция
- Я могу справиться с этими мыслями
- Не нужно будет убегать из ситуации или избегать ее, если я научусь справляться с тревогой
- Когда я расслаблюсь, беспокойство начнет ослабевать
- Расслабься, дыши спокойно и постарайся отпустить напряжение



Отвлечение от негативных мыслей

Следующим когнитивным методом, который может применяться, когда человек испытывает острую тревогу, является когнитивное отвлечение. Оно включает в себя отвлечение от негативных и разрушительных мыслей, которые усиливают тревогу. Чтобы оно работало, отвлечение должно включать в себя определенный и целенаправленный активный процесс, например, человек может заставлять себя заниматься ментальной арифметикой или подсчитывать предметы вокруг себя, а не чтением, например. В последнем случае клиент, скорее всего, обнаружит, что он прочитал текст целиком, но не воспринял информации. Активный процесс может быть как когнитивным, так и физическим. Если клиенты отвлекаются от негативных мыслей, занимаясь периодической интенсивной физической нагрузкой, это, вероятно, не только уменьшит негативное мышление, но и снимет чувство возбуждения и беспокойства.

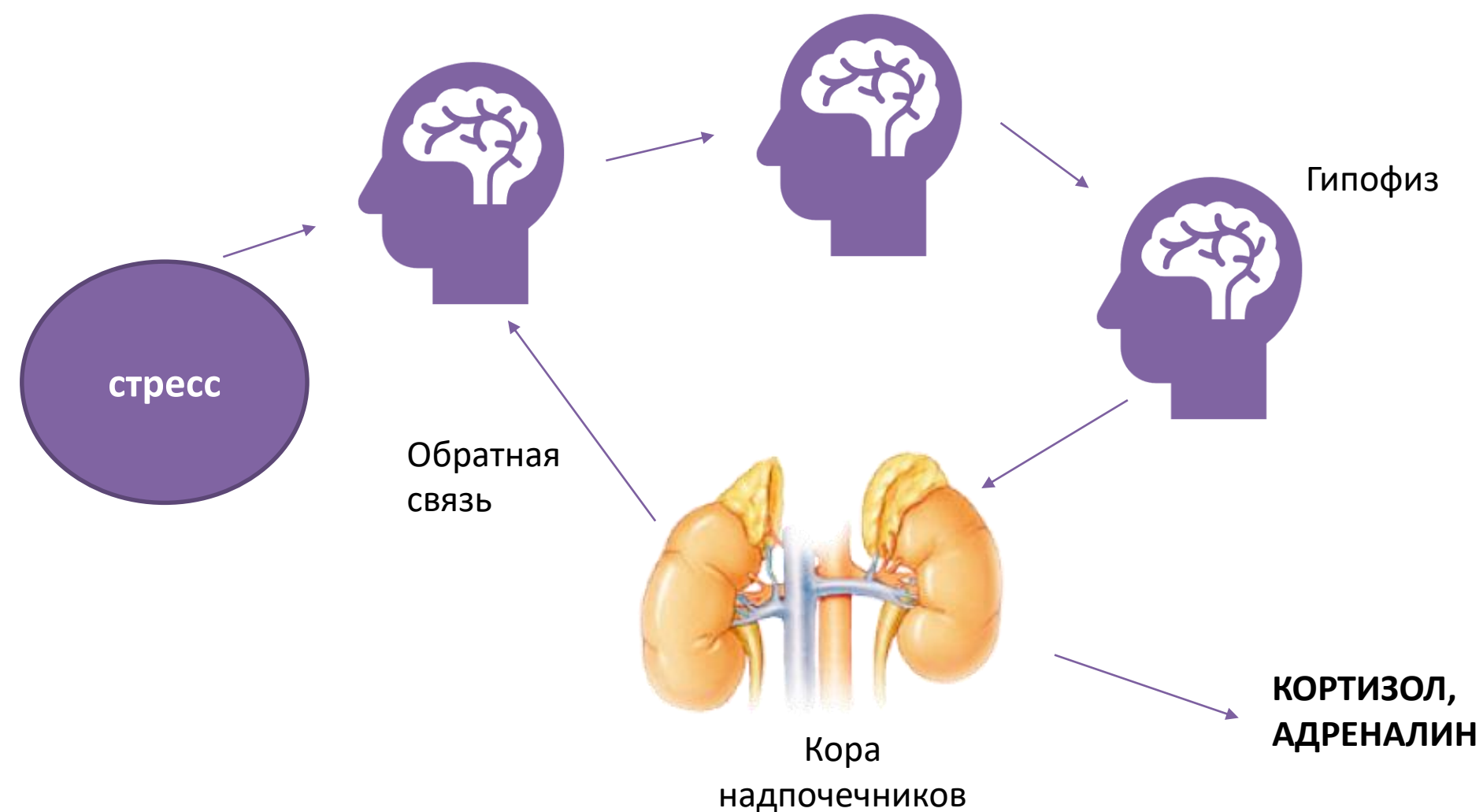


КПТ СДВГ

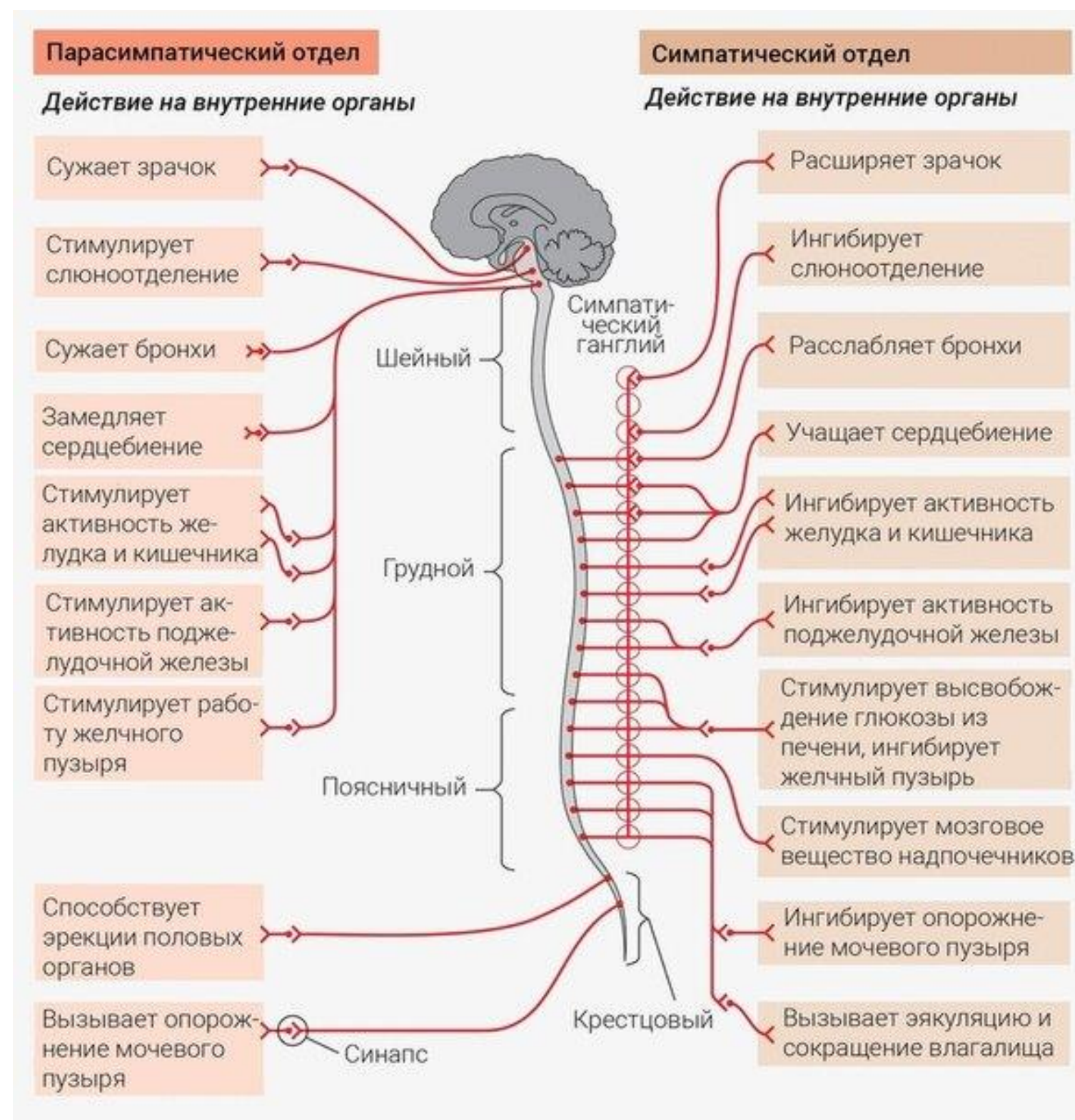
Чтобы понять, как тревога влияет на нас, необходимо осознавать физические ощущения, которые она может вызывать. К ним относятся одышка, тошнота, учащенное сердцебиение, головокружение, потливость и боли в груди. Люди с крайней тревожностью могут верить или верили в прошлом, что с их здоровьем что-то серьезно не так. Например, они могли интерпретировать эти физические симптомы или признаки как симптомы сердечной недостаточности и считают, что у них был или может быть сердечный приступ. Общие симптомы тревоги включают:

- чувства страха и паники
- ощущение потери контроля
- проблемы с фокусировкой на задаче (могут чувствовать себя сбитыми с толку)
- “наводнение” мыслями
- непрерывная ментальная энергия, которая не позволяет ничего делать
- чувство злости и гнева, агрессия
- чувство нервозности
- чувство несчастья
- чувствительно, гиперэмоциональность, лабильность

Симпатическая вегетативная гиперактивность
характеризуется частыми желудочно-кишечными симптомами, такими как тошнота и/или абдоминальные расстройства, учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, дрожь и/или сухость во рту.



КПТ СДВГ



Этот рисунок можно использовать для обсуждения распространенных физических проявлений тревоги. Реакции организма на тревогу человек может воспринимать как проблему физического здоровья, а не как симптомы лежащей в основе психологической проблемы или расстройства. В случаях острой тревоги, приводящей к приступам паники, некоторых клиентов даже госпитализируют в отделения неотложной помощи, поскольку они полагают, что у них сердечный приступ. Это особенно может произойти, если проблемы клиентов связаны с работой, стрессом и беспокойством по поводу производительности (например, невыполнение задач в срок и срыв сроков). Реакции организма на тревогу или соматические симптомы относительно легко идентифицировать, и клиентов следует научить использовать соматические индикаторы для запуска тревоги.



Мы можем предложить клиенту 10 правил для борьбы с тревогой:

1. Чувство паники - это преувеличение нормальных реакций организма на стресс.
2. Симптомы неприятны, но не опасны. Ничего ужасного не случится.
3. Перестаньте нагнетать панику пугающими мыслями о том, что должно произойти.
4. Сосредоточьтесь на том, что на самом деле происходит в вашем теле, а не на том, чего вы боитесь.
5. Подождите, пока страх пройдет. Примите его. Не боритесь с ним и не убегайте от него.
6. Обратите внимание, что как только вы перестаете усиливать пугающие мысли, страх начинает исчезать сам по себе.
7. Весь смысл практики в том, чтобы научиться справляться со страхом, не избегая его.
8. Подумайте о достигнутом вами прогрессе. Вы движетесь к успеху.
9. Когда вы почувствуете себя лучше, начните планировать, что делать дальше.
10. Когда вы будете готовы, начинайте делать что-то медленно, легко и расслабленно. Не нужно прилагать усилий или спешить.



Парадоксальная техника лечения поможет клиенту понять, что он может контролировать чувство паники. Контроль достигается путем индуцирования гипервентиляции, когда клиента просят делать быстрые и неглубокие вдохи. Через несколько минут лицо клиента покраснеет, он почувствует жар, что может быть похоже на начало сердечного приступа. Если у клиента начнется учащенное сердцебиение, он почувствует головокружение и потливость, клиент распознает эти симптомы как те, которые он испытывал, находясь в состоянии паники. Как только это понимание будет достигнуто, необходимо обратить состояние вспять, попросив клиента дышать медленно и глубоко, закрыть глаза и сконцентрироваться на своем дыхании и на том, как воздух наполняет их легкие. Затем терапевт может ввести успокаивающий разговор с самим собой, попросив клиента произнести про себя утверждения о том, как справляться с собой, указывая на то, что если они могут вызвать это состояние по своему желанию, то они могут уменьшить беспокойство.

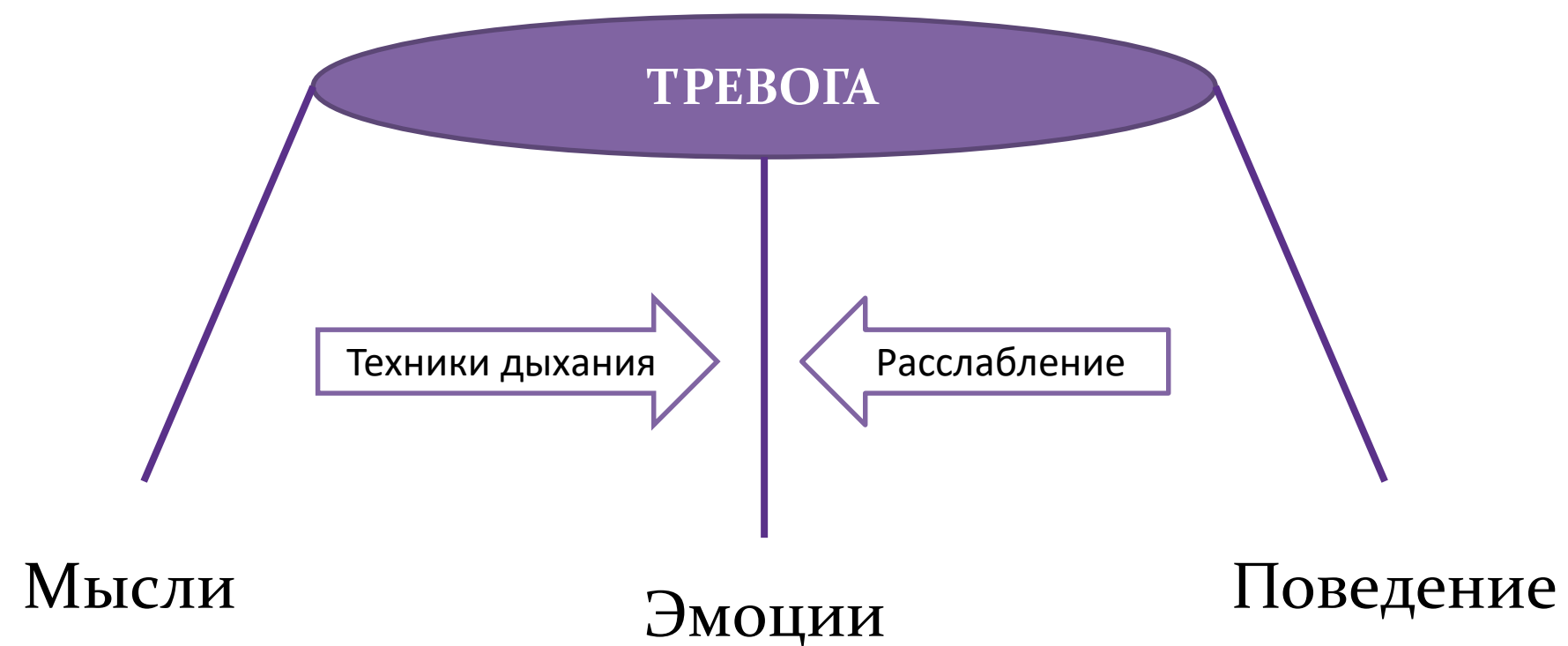


КПТ СДВГ

Это важная практика для самоконтроля. Клиенту полезно понять, что чувствует его тело, когда оно расслаблено, поскольку это означает, что он будет лучше осознавать признаки напряжения (т.е. это будет сигнализировать об изменениях в теле и указывать на наличие проблемы, которую он может решить). Когда тело находится в расслабленном состоянии, частота сердечных сокращений замедляется, дыхание становится медленным и регулярным, а напряжение в мышцах уменьшается. Клиент должен чувствовать себя спокойным, а свое тело - "тихим".



КПТ СДВГ





КПТ СДВГ

Этого можно добиться, используя техники релаксации, которые уменьшают мышечное напряжение и создают состояние физического спокойствия. Когда клиенты научатся управлять неприятными ощущениями и уменьшать их, они смогут адаптировать этот метод под себя. Однако, техники релаксации необходимо практиковать до тех пор, пока они не станут автоматическими. Для этого необходимо репетировать техники релаксации утром и вечером, предпочтительно перед отходом ко сну. Будет полезно, если клиент найдет какое-то тихое место, возможно, после теплой ванны, чтобы максимально повысить эффективность техник. Постепенно следует вводить техники в более краткой форме в течение дня, когда клиент чувствует беспокойство, если это уместно.



КПТ СДВГ

Существуют различные виды упражнений на расслабление, наиболее полезными для людей с РДВГ являются дыхательные упражнения и прогрессивные техники расслабления мышц. И то, и другое должно быть представлено клиенту на сессиях и затем практиковаться дома. Изначально практика должна быть задана как конкретное домашнее задание, но цель состоит в том, чтобы клиенты сделали расслабление частью своей повседневной жизни. Прогрессивные техники мышечной релаксации особенно хороши для профилактики, чтобы помочь клиенту вызвать и поддерживать расслабленное состояние ума. Они также с пользой применяются при появлении беспокойства в ситуациях, но могут быть неуместны в некоторых ситуациях, таких как собрания персонала, поскольку коллеги могут задаться вопросом, что они делают, дыхательные упражнения могут применяться в таких ситуациях более тонко и столь же эффективно.



КПТ СДВГ

Дыхательные упражнения

Это упражнения, которые могут помочь скорректировать дыхание. Для того чтобы освоить технику, дыхательная практика должна начинаться тогда, когда клиент чувствует себя достаточно спокойным и расслабленным. Клиенту следует напомнить, что он осваивает новый навык - поначалу ему может казаться странным или трудным дышать подобным образом. Важно продолжать практиковаться, несмотря на эти ощущения, поскольку постепенно клиент заметит улучшение.



Упражнение 1

1. Начните с того, что спокойно лягте на спину, положите одну руку на живот, а другую на верхнюю часть груди
2. Медленно вдохните. Скажите себе вдыхать и выдыхать мягко и ритмично, стараясь сделать 7-8 вдохов в минуту. Не задерживайте дыхание слишком надолго, просто медленно вдыхайте и выдыхайте. Сконцентрируйте свое внимание на дыхании.
3. На выдохе представьте, что ваше тело расслабляется все сильнее и сильнее. С каждым выдохом ваше тело все больше и больше погружается в состояние расслабления.
4. Практикуйте в течение 10 минут каждый день, и, как только почувствуете, что дышать таким образом получается легко и естественно, переходите к упражнению 2.



КПТ СДВГ

Упражнение 2

Повторите шаги из упражнения 1, но на этот раз в положении сидя или стоя. В течение как минимум 3 недель старайтесь осознавать свое дыхание в разное время в течение дня и при необходимости корректируйте его.

В целом, могут быть использованы любые техники релаксации, связанные с дыханием. Ориентируемся на ответ клиента.



Упражнения по мышечной релаксации

Терапевт может научить клиента вызывать состояние полного расслабления ума и тела, обучая его техникам прогрессивной мышечной релаксации. Помимо тревоги, эти техники уменьшают напряжение, головную боль, мигрень, снижают артериальное давление, облегчают хроническую боль и/или менструальные симптомы, улучшают сон. Упражнение можно выполнить за 10 минут или гораздо дольше. Клиент может лежать на кровати или сидеть на стуле с прямой спинкой. Клиент может начать с дыхательных техник и затем перейти к процедуре постепенного расслабления мышц, затем включить ментальное расслабление. При этом клиента просят мысленно сосредоточиться на различных частях тела и представить, как они расслабляются. Клиент также может использовать расслабляющие визуальные образы, например, представить, что он находится в спокойном месте.



КПТ СДВГ

Клиенты часто представляют себя на прекрасном пляже с белым песком и пальмами, он может увидеть цвета, услышать шелест ветра и увидеть солнечные блики на воде. Поначалу клиентам может быть трудно самостоятельно практиковать технику прогрессивной мышечной релаксации, поскольку они должны выучить последовательность и запомнить, что делать. Они останавливаются и начинают заново, поскольку им приходится читать инструкции, что мешает процессу расслабления. Постоянно повторение на сессии может помочь с этим.



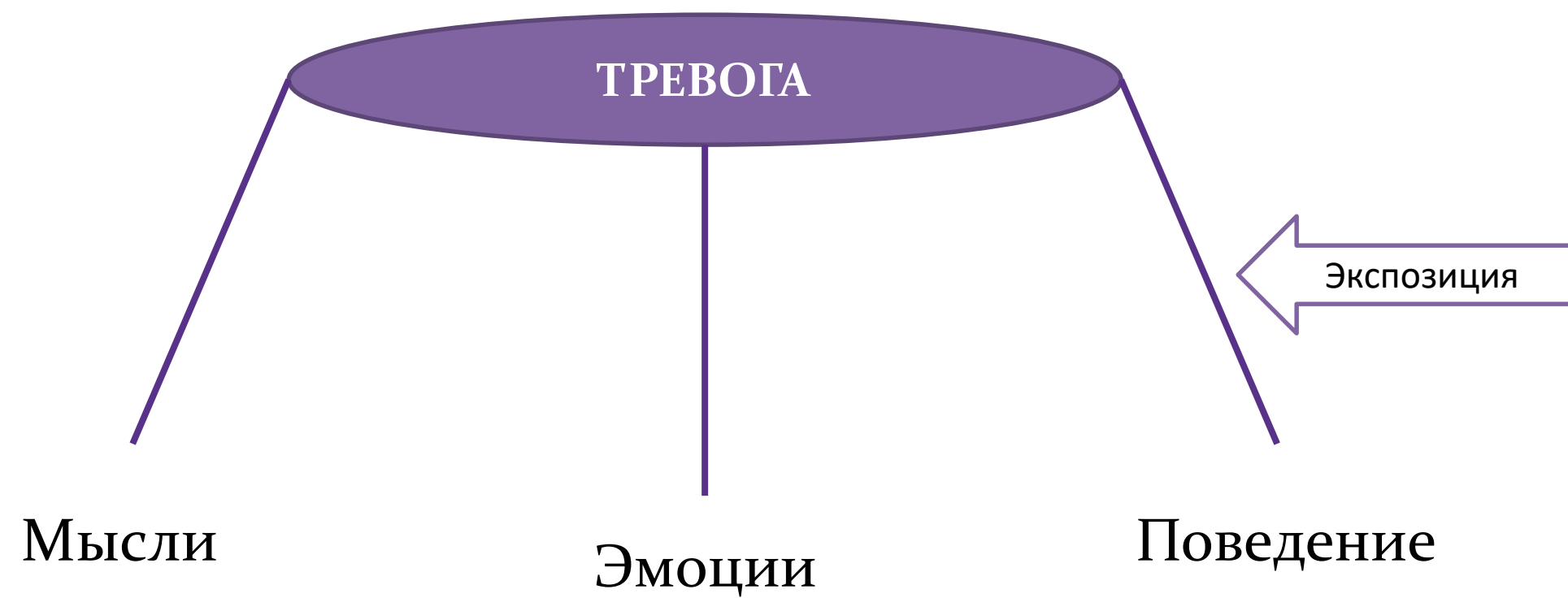
Упражнение

Перед каждым упражнением напрягайте мышцы примерно на 5-7 секунд. Расслабляйтесь примерно на 30 секунд между каждым напряжением. Тренируйтесь в тихой, комфортной обстановке.

1. Сожмите правую руку в кулак, затем расслабьте.
2. Опустите правый локоть на стул, одновременно подтягивая руку к груди. Затем расслабьтесь.
3. Сожмите левую руку в кулак, затем расслабьте.
4. Опустите левый локоть на стул, одновременно подтягивая руку к груди. Затем расслабьтесь.
5. Выгните спину дугой, затем расслабьтесь.
6. Плотно сощурьте глаза, одновременно наморщив нос, затем расслабьте его.
7. Плотно сожмите зубы, одновременно оттягивая уголки губ в преувеличенной улыбке. Затем расслабьтесь.
8. Раздвинув зубы, сожмите губы вместе, одновременно прижимая язык к небу. Затем расслабьтесь.
9. Опустите подбородок вниз, как будто пытаетесь коснуться им груди, одновременно отводя голову назад. Затем расслабьтесь.
10. Сделав глубокий вдох, прижмите лопатки друг к другу сзади, как если бы вы пытались соединить их. Затем расслабьтесь.
11. Сделав глубокий вдох, напрягите мышцы живота (или напрягите мышцы живота, втягивая их или выталкивая наружу). Затем расслабьтесь.
12. Упритесь пятками в пол, затем расслабьтесь.
13. Направьте пальцы ног на себя, затем расслабьтесь.
14. Направьте стопы вниз, одновременно поворачивая ступни внутрь и поджимая пальцы ног. Затем расслабьтесь.



КПТ СДВГ





КПТ СДВГ

Изменение поведения

Поведенческое избегание, вероятно, является самым серьезным и негативным поведенческим проявлением тревоги. Когда мы чувствуем тревогу, мы, как правило, хотим избежать того, что воспринимаем как психологическую угрозу. Наша естественная реакция - избегать неприятных ситуаций.



КПТ СДВГ

Общие чувства, которые выражают клиенты, включают:

- нежелание выходить на улицу
- рассеянность, потеря концентрации и отвлечение от задания
- избегание социальных ситуаций
- придумывание отговорок, чтобы чего-то не делать
- избегание отстаивания своих интересов и границ
- успокоение посредством курения, употребления алкоголя, наркотиков, пищи
- перенапряжение, сверхактивность, высокая энергия
- поглощенность мыслями



КПТ СДВГ

На краткосрочной основе избегание полезно, поскольку это самый быстрый способ для клиентов защитить себя и облегчить свою тревогу. Однако, конечно, это нефункционально, поскольку означает, что клиент учится справляться, избегая ситуаций, вызывающих беспокойство, таких как поход на работу, вечеринки, завершение важных задач. Это усугубляет порочный круг негативных мыслей. К сожалению, это становится привычным, и клиент вовлекается в процесс избегания всякий раз, когда сталкивается с ситуациями, вызывающими тревогу, например, думая: "Я не могу этого сделать, в последний раз, когда я пытался, я не смог этого сделать и сдался и не стал этого делать". Таким образом, этот когнитивный и поведенческий процесс является самоподкрепляющимся.



КПТ СДВГ

Вместо того чтобы столкнуться с проблемой лицом к лицу и решить ее, клиент избегает ее и делает проблему еще более сложной для решения в следующий раз. Страх ведет к избеганию, что приводит к еще большему страху, который приводит к еще большему избеганию, и так далее. Чем больше клиент избегает ситуации, тем сильнее становится его тревога. Постепенно становится хуже, и тревога распространяется на другие ситуации и обстоятельства. Со временем поведение избегания снижает уверенность и самоуважение.



КПТ СДВГ

Уверенность развивается благодаря достижениям, и важная часть управления тревогой состоит в том, чтобы начать смотреть в лицо страхам и перестать избегать ситуаций, провоцирующих тревогу. Это очень трудно сделать, поэтому важно, чтобы клиент (и терапевт) не ожидал слишком многого слишком скоро или чтобы не ставились нереалистичные цели. Успех будет включать в себя структурирование терапевтом иерархического графика поэтапного выполнения задач, которые сложны для клиента. Используя этот подход, клиент научится планировать постепенный путь по развитию уверенности и вновь приступить к действиям, которых они избегали, и достигать их.

Последовательность шагов экспозиции:

1. Составьте список ситуаций, которые клиент избегает из-за своих негативных переживаний
2. Попросите клиента оценить каждую ситуацию по шкале от 0 до 10 (0=отсутствие тревоги, 10=максимальная тревога)
3. Попросите перечислить ситуации в порядке их тяжести (проранжируйте) - поставьте наименее сложную задачу в начало списка, а наиболее сложную - в конец списка
4. Разбирайтесь с каждой ситуацией по очереди - сначала с наименее сложной. Необходимо вознаграждать клиента (или мотивировать его искать вознаграждение) за успешное выполнение задачи (или этапа). Успешное выполнение наименее сложной задачи из списка облегчит ему путь к столкновению с другими его страхами и поможет подготовиться к самой сложной задаче.
5. Ведите учет прогресса в выполнении поставленных задач
6. Попросите и помогите клиенту оценить, как он справился. Мотивируйте его награждать себя в случае позитивного результата. Поначалу самым важным аспектом успеха может быть просто “смотреть в лицо” ситуации. Постепенно он сможет оценить, насколько хорошо может управлять своими чувствами.



КПТ СДВГ

7. Необходимо продумать небольшие вознаграждения за каждый этап и большое вознаграждение за выполнение задания.

8. Просите клиента практиковаться - ПРОДОЛЖАТЬ ПРАКТИКОВАТЬСЯ - чем больше, тем лучше он будет справляться с ситуацией. Преодолевая страхи шаг за шагом, он постепенно вернет себе уверенности и самоуважение.

ПОМНИТЕ: не ожидайте слишком многого слишком скоро и гордитесь любым достигнутым прогрессом



КПТ СДВГ

Пример

Список ситуаций, которые избегаются:

- Поход в супермаркет
- Закончить отчет по работе
- Записаться к врачу

Оценка ситуаций:

- Пойти в супермаркет (привлечь к себе внимание) – 10 б
- Закончить отчет по работе (придется сдать его на проверку) – 8 б
- Записаться к врачу (боюсь услышать плохие новости) - 9 б



КПТ СДВГ

Перечисление ситуации в порядке убывания	Вознаграждение
Закончить отчет на работе	Выпить горячий шоколад
Записаться к врачу	Купить себе новый шампунь
Пойти в супермаркет	Принять расслабляющую ванну



КПТ СДВГ

Сложности в терапии	Как проявляются	Решение в КПТ
Забывание ДЗ	Клиент соглашается на экспозицию, но дома ничего не делает, «вылетает из головы»	Использовать телефонные напоминания, визуальные сигналы, записывать ДЗ (фото или голосовая заметка)
Трудности с планированием экспозиций	Клиент не понимает, как разложить задание на шаги	А сессии вместе разбить задачу на микро-шаги, закрепить его в приложении/ письменно
Прокрастинация или избегание	Клиент откладывает тревожные задания на потом, отвлекается	Поведенческая активация: делать задания в формате «5 минут старта» + быстрые награды
Импульсивное прерывание экспозиции	При росте тревоги клиент резко выходит из ситуации, избегает до конца	Репетиция «остаться хотя бы на 30 секунд дольше», обучение самоподдерживающему диалогу
Невозможность поддерживать рутину (релаксация)	Клиент делает упражнения нерегулярно	Встраивать практику в существующие привычки (дыхание утром перед завтраком), использовать аудио-гайды



КПТ СДВГ

Сложности в терапии	Как проявляются	Решение в КПТ
Перегруз от эмоций	Клиент говорит «я не выдержу такую тревогу»	Навыки дистресс-толерантности из ДБТ: заземление, дыхание, когнитивное оспаривание мысли
Негативные мысли про терапию	«Я не справляюсь даже с заданиями, значит я безнадежен»	Когнитивная реструктуризация: работа с мета-мыслью, акцент на маленьких успехах
Низкая приверженность к терапии	Пропуски сессий, забывание времени, опоздания	Использовать внешние источники напоминания о встречах, вовлекать коуча/партера/родителя, фиксировать дату и время на сессиях
Фокус только на симптомах РДВГ	Клиент уходит в жалобы про организацию, забывание, но избегает работы с тревогой	Интегрировать работы: сначала наладить базовые внешние инструменты (списки, календарь), а потом делать экспозицию.



КПТ СДВГ

КОМОРБИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ФРУСТРАЦИЯ И ГНЕВ



КПТ СДВГ

Каждый из нас иногда злится, это естественная эмоция. Большинство людей испытывают гнев, когда воспринимают несправедливость или чувствуют, что их права были нарушены, однако из-за своих симптомов люди с РДВГ могут быть предрасположены к лабильному или взрывному темпераменту. У них вырабатываются неадаптивные способы справляться с чувством гнева и выражать свои чувства неподобающим образом. У людей с РДВГ чувство гнева, скорее всего, будет выражаться внешне, чем подавляться внутренне, из-за их неспособности подавлять реакцию и из-за низкого порога раздражительности и скуки. Однако отрицание гнева и подавление гневных чувств не является чем-то необычным, особенно у тревожных людей. Когда гнев выражается открыто, другие люди, скорее всего, воспринимают это как негативную черту характера и считают человека с РДВГ непредсказуемым, а в некоторых случаях пугающим и опасным.



КПТ СДВГ

Взрослым с РДВГ может быть трудно переносить фрустрацию, и, в частности, их может раздражать отсутствие у них достижений и невыполнение заданий. Они также раздражаются, когда друзья и родственники, имея в виду только хорошее, начинают указывать им, что делать, пытаются организовать за них их жизнь, жалуются на отсутствие целеустремленности и мотивации. Обычно имеет место цикл негативизма между родителями (особенно матерями) и детьми с РДВГ. Исследования СРДВГ в детском возрасте показали, что негативные взаимодействия являются взаимным процессом, причем РДВГ влияет на то, как ребенок реагирует на своих родителей и, следовательно, на то, как родители ведут себя по отношению к своим детям.



Трудности с управлением гневом могут привести к многочисленным негативным последствиям, включая разрыв отношений, увольнение с работы и прочее. Нередко у людей с РДВГ накапливается чувство гнева по отношению к психиатрическим/психологическим службам. После постановки диагноза и лечения это часто выражается в недовольстве услугами из-за того, что они не удовлетворяют их потребностям. Люди с РДВГ обычно имеют долгую историю обращения как в детские, так и во взрослые психиатрические службы. Они могут чувствовать, что их проблемы не были восприняты врачами/специалистами всерьез, а также могут чувствовать себя неправильно понятыми партнерами и друзьями.



КПТ СДВГ

У некоторых людей может быть склонность обвинять других в том, что они с самого начала не выявили расстройство и не оказали надлежащей поддержки. Они могут чувствовать разочарование и злость, если считают, что ранее им был поставлен неправильный диагноз, навешен ярлык или о них неправильно думали. Это будет нелегко для терапевта - люди с таким опытом могут иметь проблемы с созданием терапевтического альянса. Терапевты должны быть осведомлены об этих проблемах, и им, возможно, потребуются чутко внедрять методы управления гневом на ранних этапах терапии, чтобы установить взаимопонимание и завоевать доверие.



Гнев - это нормальная эмоция, испытываемая каждым человеком. Таким образом, цель лечения состоит не в том, чтобы «убрать» гнев, а в том, чтобы улучшить контроль и адаптивно использовать гнев. Это может быть особенно эффективно для мотивации изменений.

Гнев – это здоровая эмоция, которая позволяет людям решать проблемы, устанавливать контроль и/или изменять ситуацию. Вторым аспектом гнева является то, что он выполняет функцию предупреждения. Он сигнализирует о потенциальной опасности и защищает нас от вреда. Нет ничего необычного в том, что гнев возникает в определенных ситуациях, где активизируются другие эмоции, такие как страх или печаль. Ситуации, в которых имеет место предполагаемая или фактическая несправедливость, скорее всего, вызывают гнев, и это представляет собой адаптивную реакцию на неудовлетворенность окружающей средой. Управление гневом заключается в выявлении эффективных способов выражения клиентом своего недовольства, не причиняя страданий ни себе, ни другим.



Люди с РДВГ могут злиться по следующим причинам:

1. Они принимают все близко к сердцу. Люди с РДВГ могут с большей вероятностью интерпретировать любую угрозу или обвинение как личное оскорбление и злиться в результате этих чувств. Например, если член семьи потерял что-то и спрашивает, видели ли ее другие члены семьи или пользовались ли ею, клиент может предположить, что его в чем-то обвиняют (например, одолжил без спроса, украл вещь). Поскольку человек чувствует, что его (неоправданно) в чем-то обвиняют, он чувствует себя расстроенным и сердитым.



2. Потеря контроля над ситуацией. Если человек с РДВГ чувствует, что у него ничего не получается, он, как правило, легко сдается. Лучше сдаться, чем продолжать работать над задачей, бороться с ней в одиночку и чувствовать себя безнадежным и глупым. Его неспособность достичь цели может вызвать внутренний гнев, а отказ может усугубить фрустрацию. Эта ситуация также может вызвать раздражение у других людей и привести к конфронтации. Чувство гнева в таких обстоятельствах имеет второстепенную функцию, поскольку высокое эмоциональное возбуждение отвлекает. Человек сосредотачивается на своих чувствах, позволяя себе отвлечься или избежать ситуации, такой как незавершенное задание.



3. Чувство угрозы. Ситуациями, в которых человек подвергается прямому вызову или угрозе, может быть трудно управлять любому человеку. Однако люди с РДВГ более склонны к катастрофическим последствиям и чрезмерно остро реагируют на критику, даже если она конструктивна, из-за приобретенного чувства никчемности или несовершенства. Если они действительно оказываются в провокационной ситуации, когда кто-то издевается над ними или запугивает их, они могут действовать импульсивно и реагировать агрессивно, не задумываясь о последствиях своего поведения.



4. Усвоенное поведение. У людей с РДВГ, возможно, с годами выработались неадаптивные модели реагирования на фрустрацию и гнев. Возможно, они и не особенно сердиты, но ведут себя так, что можно предположить, что это так, поскольку именно так они научились себя вести. Это создает неправильное представление о нем у других людей, которые воспринимают его как "колючего" и чрезмерно чувствительного.



5. Плохой контроль импульсов. Этот симптом сам по себе может привести к обострению чувства гнева, в результате чего человек с большей вероятностью будет выплескивать свой гнев агрессивным или насильственным образом по отношению к другим, себе или собственности. Таким образом, люди с меньшей вероятностью уйдут от серьезной словесной конфронтации и с большей вероятностью ответят физической агрессией. Они часто вступают в драки или уничтожают имущество. Некоторые из них могут импульсивно причинять себе вред и злоупотреблять психоактивными веществами по этой причине.



КПТ СДВГ

6. Чувство обиды. Чувство гнева может накапливаться медленно, особенно если человек чувствует, что его осуждают или стигматизируют другие. Они могут испытывать неприязнь к людям, которым, кажется, живется легче.



7. Фрустрация из-за трудностей с концентрацией внимания. Это может быть очевидно при оценке человека с РДВГ, когда он начинает раздражаться на себя за то, что не может сосредоточиться или поддерживать внимание. Они злятся, когда допускают ошибки, забывают инструкции или долго заканчивают работу. Взрослые с РДВГ имеют некоторое представление о своих трудностях, и часто можно наблюдать, как они дают неправильный ответ, а затем позже исправляются, осознавая свою ошибку. Однако гнев часто может усугубить проблемы с вниманием, поскольку люди могут отвлекаться на свои гневные мысли и терять концентрацию на поставленной задаче.



8. Разочарование в связи с отсутствием помощи. В окружении взрослых с РДВГ, скорее всего, есть специалисты, которые либо отвергают расстройство РДВГ как клинически значимое состояние и/или которым не хватает знаний и понимания об этом расстройстве и их особых потребностях. Это происходит в сфере образовательных услуг, социальных услуг и здравоохранения. Часто человек обращался в несколько служб для детей и взрослых и рассказывал свою историю снова и снова. Это может стать препятствием для терапевта, и это может препятствовать терапевтическому прогрессу.



КПТ СДВГ

9. Гнев как механизм избегания столкновения с другими эмоциями. Чувство гнева может быть более предпочтительно по отношению к выражению других эмоций, таких как страдание и печаль, чтобы избежать выражения того, что может быть воспринято как "более слабые" эмоции. Этот симптом чаще встречается у мужчин с РДВГ.



10. Стимулы для возбуждения. Переход в состояние сильного возбуждения обеспечивает состояние сильного стимула и возбуждения. Это может удовлетворить желание поиска острых ощущений или и избавить от чувства скуки и однообразия. Например, агрессивный спор с большим количеством драматизма, криками, жестикуляцией, хлопаньем дверьми может вызвать у человека выброс адреналина. Это действует как положительное подкрепление поведения, а выброс адреналина является "наградой", таким образом увеличивая вероятность того, что они повторят это поведение. Гнев также может казаться полезным, если разгневанный человек способен избежать неприятной или скучной ситуации.



11. Источник общения. Многие люди обладают слабыми социальными навыками и испытывают трудности в общении и выражении своих мыслей и чувств. Это может быть вызвано дефицитом определенных навыков и/или неуверенностью в себе, которая была негативно подкреплена историей дисфункциональных социальных взаимодействий со сверстниками. Люди могут реагировать гневом по двум причинам: они могут неправильно оценивать социальные ситуации и намерения других и реагировать агрессивно (дефицит социальных навыков) и/или испытывать обиду и гнев по отношению к людям, с которыми они взаимодействуют в мире, который они воспринимают как суровый и предвзятый по отношению к ним.



12. Утверждение превосходства. У людей с РДВГ обычно низкая самооценка, и это, вероятно, закладывается в раннем детстве. Все становится только хуже по мере того взросления, а неудачи становятся самоисполняющимся пророчеством. Чтобы защититься от чувства уязвимости и скрыть его, они могут использовать агрессию, чтобы передать сообщение: "Я лучше тебя". Терапевт может продемонстрировать ему во время лечения, простое вовлечение в этот процесс (даже когда чувства гнева на самом деле нет) будет иметь ятрогенный эффект, приводящий к "настоящему" чувству гнева.



13. Агрессивное поведение во время вождения. На дорогах у водителей есть много возможностей вызвать чувство гнева: люди едут слишком быстро, слишком медленно, подрезают, не указывают, не уступают дорогу, резко останавливаются, мигают фарами, сигналият или делают жесты. Вождение по оживленным дорогам и в часы пик даже в лучшие времена вызывает стресс, и каждый знает, каково это - оказаться за рулем, когда чувствуешь раздражение и фрустрацию. Однако существует повышенный риск того, что люди с РДВГ будут испытывать ярость при вождении, а также попадут в дорожно-транспортные происшествия. Это происходит из-за того, что люди садятся за руль без должной осторожности и внимания; они могут отвлекаться от вождения разговорами с пассажирами или пейзажем; они могут вести машину безрассудно. Поэтому люди с РДВГ чаще ведут себя провокационно на дорогах, выпрыгивают из своих машин на светофорах и угрожают другим водителям.



КПТ СДВГ

Дисфункциональное управление гневом

1. Обострение ситуации путем открытого выражения агрессии
2. Подавление гнева



Эскалация

Человек с предрасположенностью к эскалации, скорее всего, явно выразит свои чувства гнева. Его порог проявления раздражения намного ниже, и он может быть лабильным по темпераменту. У таких людей, вероятно, будет много импульсивных симптомов, трудности с контролем поведения и эмоциональной регуляцией приводят к тому, что они с большей вероятностью будут бурно реагировать в стрессовых и сложных ситуациях. Например, если кто-то проталкивается перед ними в очереди или если кто-то делает личное замечание, они вряд ли подавят импульс к агрессивной реакции, сделав замечание либо устно, либо посредством невербального выражения (например, пристально глядя на человека). Это может привести либо к незаметной эскалации агрессии, либо к быстрой эскалации, в зависимости от серьезности реакции, от того, как их чувства были сообщены и в зависимости от ответа другого человека.



КПТ СДВГ

Некоторые люди испытывают чувство власти и возбуждения, намеренно провоцируя и запугивая других людей, что обладает подкрепляющим свойством, обеспечивая немедленное вознаграждение. Это также может казаться функциональным, поскольку означает, что индивид избегает проявления других эмоций, таких как собственный страх и тревога, и/или проявления чувства уязвимости. Также может быть положительное подкрепление со стороны другого человека, который в этой ситуации отступает. Конечно, долгосрочные последствия такого поведения включают потерю друзей, уничтожение предметов, физические травмы и уголовные приговоры.



Подавление

Этот второй тип гнева - скрытый или подавленный гнев. Когда их спрашивают, люди часто отрицают, что чувствуют гнев, и не признаются в ситуациях, которые заставили их разозлиться или расстроиться. Человек с предрасположенностью к подавлению гневных чувств выражает свои чувства скрытно. Они могут быть пассивно-агрессивными и уступчивыми. Может показаться, что они хорошо справляются со стрессовыми ситуациями, но все это время внутри них медленно накапливаются чувства обиды и гнева. В таких случаях люди могут внезапно взорваться, причем спусковой механизм, казалось бы, безобиден. Их реакция будет казаться другим несоразмерной триггеру. У них может быть репутация непредсказуемых людей, неуправляемых.



КПТ СДВГ

Другой способ, которым подавленный гнев может высвободиться, - это в обстоятельствах, когда он развился из оставшихся переживаний. Гнев, который был "закупорен", может всплыть на поверхность в, казалось бы, не связанных между собой ситуациях, которые напоминают человеку о более раннем опыте и его чувствах по этому поводу. Таким образом, это неуместный гнев, который может вызвать большое замешательство у окружающих. Чтобы избежать неуместного выражения этого типа гнева, клиенту необходимо развить понимание трудных ситуаций, с которыми он сталкивался в своей жизни, соотнести их со своими чувствами, научиться выражать их надлежащим образом и двигаться дальше.



КПТ СДВГ

Терапия гнева

При лечении людей с проблемами гнева терапевт должен начинать с психообразования. Это достигается в рамках КПТ, когда человек учится распознавать чувство гнева, физиологические реакции, мысли и поведение. Затем им предлагается определить стадии гнева, предпосылки, поведение и последствия гнева. Затем вводятся конкретные методы управления гневом, такие как техники отвлечения внимания, беседы с самим собой и методы релаксации.



Психообразование: распознавание гнева

Как и в случае с другими эмоциями, гнев может быть концептуализирован как включающий три взаимосвязанных компонента: **физический, когнитивный и поведенческий**. Клиентам следует подумать о том, когда они в последний раз злились. В каких частях тела они замечают изменения, когда злятся? Такие изменения вызваны повышением уровня адреналина, поскольку организм готовится столкнуться с угрозой. После появления физических симптомов автоматически возникают негативные или агрессивные мысли, которые могут усиливать физические симптомы гнева. Негативными мыслями могут быть: "Я ненавижу этого человека", "Я хочу убить его". Негативные мысли может привести к гневному поведению, такому как сжатие кулаков, выпрямление спины, вторжение в личное пространство, которое также может остаться незамеченным человеком. Видеосъемка ролевых игр может быть полезным методом выявления тех форм поведения, которые должны быть в центре внимания терапевтического вмешательства.

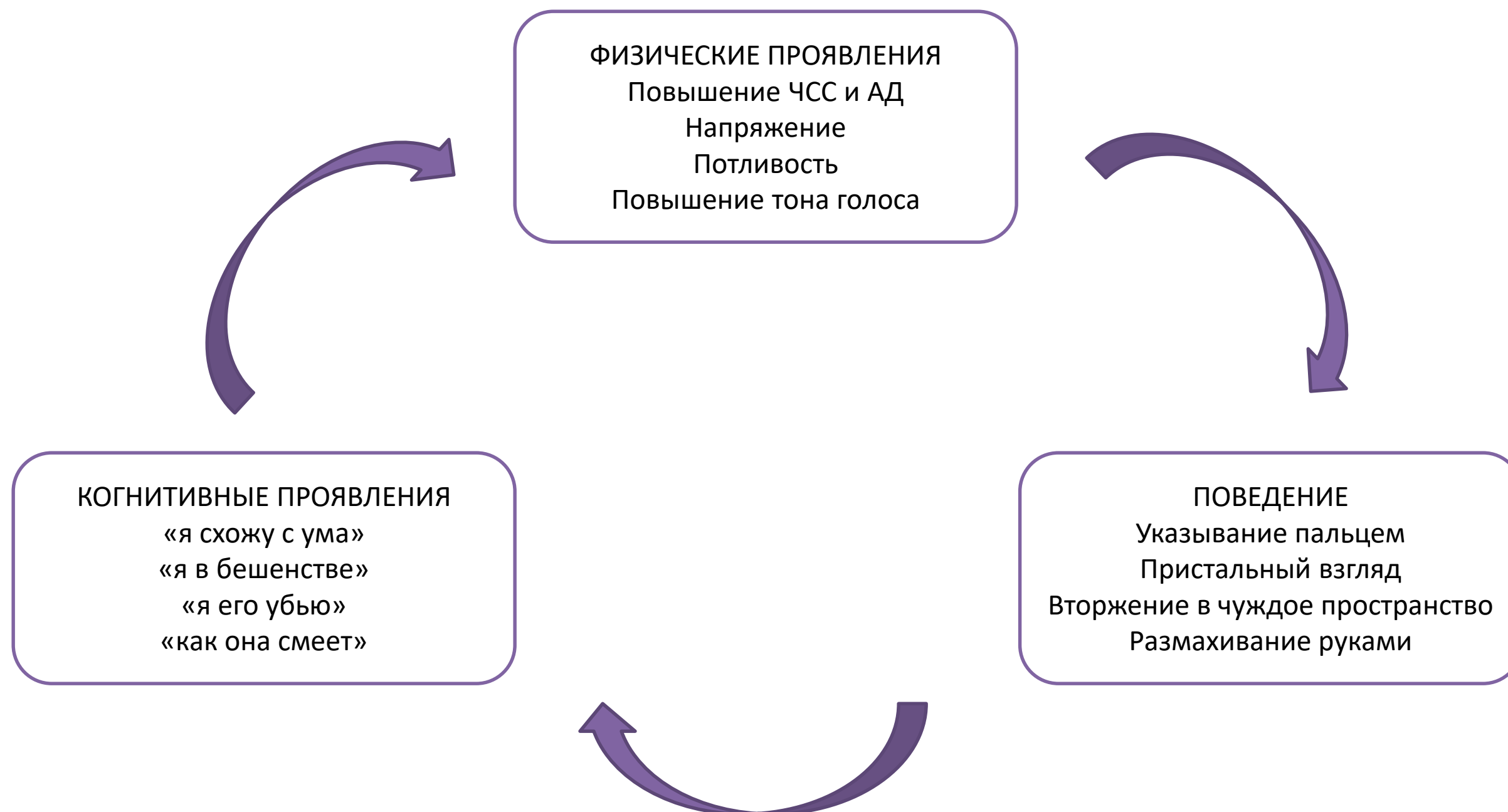


КПТ СДВГ

Однако негативные мысли возникают так быстро, когда человеком овладевает гнев, что это может означать, что возможна только идентификация чувств или первоначальные "инстинктивные реакции". В таких обстоятельствах важно побудить клиента остановиться и не отвечать на вопросы. Простого поощрения человека остановиться и подвести итоги, то есть сделать паузу, прежде чем действовать, может быть достаточно, чтобы предотвратить перерастание гнева в насилие.



КПТ СДВГ





КПТ СДВГ

Следует поощрять клиентов обращать особое внимание на язык тела, поскольку это важный и первичный показатель гнева. Их следует попросить определить физические признаки гнева, как их собственные невербальные признаки, так и признаки других людей. Если люди лучше осведомлены о своих собственных признаках гнева, они также с большей вероятностью смогут распознать их в других. Раннее выявление ситуации, выходящей из-под контроля, означает, что у человека есть более длительный период для рационального мышления, прежде чем высокий уровень возбуждения заставит его отреагировать. Также он будет иметь время для использования техник, позволяющих разрядить ситуацию или уйти из нее.



КПТ СДВГ

Гнев можно понимать как трехэтапный процесс, включающий **предпосылки возникновения гнева, поведение во время гнева (выражение гнева) и последствия гнева.**

Поэтому полезно установить личный образец или "схему" для выражения неуместного гнева. Для некоторых людей, вместо того чтобы начинать с изучения собственного гневного поведения клиента, может оказаться полезным и менее угрожающим подумать о ком-то другом, чей гнев они недавно наблюдали. Следуя этому примеру, они могут чувствовать себя более комфортно, рассказывая о стадиях своего собственного гнева.



- *Предшественники гнева.* Часто существуют общие триггеры гнева, например, нахождение рядом с определенными людьми в определенных местах (например, семейные торжества, аттестация на работе). Клиентов следует поощрять искать общие черты в ситуациях, когда они впадают в гнев. Затем они могут разработать стратегии либо для избегания подобных ситуаций, либо для подготовки, чтобы они могли более адекватно справиться с ситуацией. Это может включать подготовку самоутверждения для того, чтобы сохранять спокойствие, заранее обдумывая, что они могли бы сказать, а также для того, чтобы определить, на какие компромиссы они, возможно, готовы пойти, чтобы разрядить ситуацию.



КПТ СДВГ

- *Разрядка гнева (поведение).* Клиент должен научиться распознавать свои физические признаки гнева и выработать способы поведения и мышления, позволяющие ему надлежащим образом проявлять свой гнев, чтобы не терять контроль.
- *Последствия.* Следует попросить клиента поразмышлять о том, как он вел себя и как справился с этой ситуацией. Клиент может изучить как положительные, так и отрицательные последствия.



КПТ СДВГ

Терапия гнева

Нелегко научиться управлять чувством гнева, особенно когда люди предрасположены к импульсивным реакциям, что может означать, что они совершают вспышки гнева и не могут удержаться от того, чтобы не наброситься на кого-нибудь. Одно дело практиковать методы управления гневом во время сессий, и совсем другое – применять их, когда человек чувствует себя расстроенным и возбужденным. В сочетании с лабильным темпераментом это может означать, что люди испытывают значительные трудности с контролем гнева. Важно отойти от представления о том, что проблема заключается именно в человеке. Это проблема, которая есть У человека. Точно так же, как человек может заставить себя чувствовать внутренний гнев, думая о ситуациях и людях, которые заставляли его расстраиваться в прошлом, он может заставить себя чувствовать себя менее сердитым.

Это вопрос контроля гнева, и клиент должен чувствовать себя способным справиться с ним. Возможно, будет полезно на практике продемонстрировать этот процесс на сессиях, попросив клиента "пережить заново" и описать сценарий, провоцирующий гнев, в воображении. Когда он начинает испытывать гнев, клиенту следует напомнить, что он сам заставил себя чувствовать таким образом, его физическое и когнитивное состояние претерпело некоторые фундаментальные изменения. Терапевт должен указать на изменения в организме, попросить клиента записать, что с ним происходит (потеющие ладони, учащенное сердцебиение, ощущение жара на лице и прочее). Клиента также следует попросить посмотреть в зеркало и описать, что он видит (красное лицо, нахмуренные брови). Если клиент не может заново пережить предыдущий опыт, провоцирующий гнев, или может сделать это, не вызывая физических симптомов гнева, тогда может быть полезно разыграть ролевую игру, сценарий, которой является значимым и релевантным для клиента.



КПТ СДВГ

Участвуя в описанном выше процессе, клиенты могут научиться распознавать, как они ведут себя, когда злятся, и как другие воспринимают язык их тела.

Ролевая игра или "переживание заново" могут проходить кадр за кадром, как при просмотре видео, и вместе клиент и терапевт могут обсудить факторы, способствующие эскалации и деэскалации. Например, что почувствовал клиент, когда терапевт указал на него пальцем или встал ближе к нему? Заметил ли он изменения в лице и/или теле терапевта? Однако наиболее важным является урок о том, что если гнев вызывается намеренно в рамках сессии - он находится под контролем клиента, и поэтому у него также есть возможность контролировать гнев вне сессии.



КПТ СДВГ

Конечно, терапевту необходимо проявить здравомыслие, прежде чем разыгрывать сценарии, провоцирующие гнев, в рамках сессий. В некоторых случаях может оказаться разумным договориться с клиентом о присутствии третьей стороны, которая может помочь, участвуя в ролевой игре. Как только клиент научится распознавать свои чувства гнева и осознавать, что он может осуществлять контроль над ними, следующим этапом будет обучение клиента стратегиям, которые помогут ему управлять своим чувством гнева.



КПТ СДВГ

1. Отвлечение внимания
2. Разговор с самим собой
3. Расслабление



Отвлечение внимания

Осознание того, что ситуация обостряется и становится конфронтационной, обычно означает, что у человека есть выбор. Вариант состоит в том, чтобы решить выйти из ситуации, отвлекаясь. Если человек замечает ранние признаки чувства гнева, он может отвлечься, отойдя от ситуации и занявшись нейтральным, не связанным с ней делом. Однако, не эффективно сначала уйти из ситуации, а затем рассказывать о ней множеству людей. Искать социальную поддержку и спрашивать мнение друзей - это совсем не то же самое, что жаловаться множеству людей и направлять на них свой гнев. Поэтому, отвлекаясь, внимание следует переключить на позитивное или нейтральное занятие, а не на то, которое еще больше разожжет гнев человека или направит его на кого-то другого. Это разрушительно, поэтому терапевт должен поощрять клиента к конструктивному поведению.



КПТ СДВГ

Это особенно актуально в тех случаях, когда человек не может уйти из ситуаций на неопределенный срок, например, в рабочих отношениях. Дистанцируясь от ситуации, физиологическая реакция уменьшится, и человек сможет мыслить более рационально и спокойно. Затем клиент может придумать конструктивный ответ и вернуться к ситуации в лучшем расположении духа.



КПТ СДВГ

Беседа с самим собой

Успокаивающий разговор с самим собой - это развитие способности позитивно говорить с самим собой. Это достигается путем совместной разработки фраз, которые клиент может сказать сам себе, чтобы помочь контролировать чувство гнева. Некоторые люди называют это "позитивным мышлением", но речь идет не просто о мышлении, это преднамеренная когнитивная репетиция позитивных самоутверждений, которые поощряют и подтверждают способность человека справиться с ситуацией и осуществлять самоконтроль. Для каждого человека утверждения будут отличаться, но могут включать такие утверждения, как "Я справлюсь с этим", "Я не собираюсь показывать гнев человеку, на которого я злюсь", "Я выше этого".



Фразы можно практиковать, заново переживая переживание гнева или разыгрывая его снова и включая успокаивающие высказывания в разговоре с самим собой. При работе в режиме воображения клиент должен представить себе прошлую ситуацию, которая вызвала у него чувство гнева, а затем представить, как он разговаривает сам с собой и набирается мужества, чтобы лучше справиться с ситуацией и добиться более позитивного завершения. Терапевт может подсказывать утверждения, сделанные в ходе беседы с самим собой, но их следует прослушать несколько раз, пока клиент не сможет самостоятельно применять эту технику. Оно очень важно, чтобы клиент мог представить, что он конструктивно справляется с ситуацией, что он представляет, как контролирует свои чувства и определяет положительный результат.



Расслабление

Можно использовать техники релаксации. Эти техники очень полезны для того, чтобы справиться с чувством гнева, а также тревоги, потому что они заставляют человека сосредоточиться на себе. Это означает не только то, что клиенты учатся регулировать свое дыхание, но и то, что они концентрируются на своем внутреннем состоянии и дистанцируются от внешних проблем. Конечно, техники релаксации не очень помогают контролировать острую реакцию человека с лабильным темпераментом in vivo на провокационную ситуацию. Однако эти техники помогут людям контролировать чувство обиды. Практикуя дыхательные упражнения, вызывая состояние релаксации, чередуя напряжение и расслабление мышц и задействуя расслабляющие мысленные образы, клиент может управлять чувством гнева, обидой, неудовлетворенностью. Следует поощрять клиента регулярно практиковать техники релаксации по мере необходимости включать их в свой ежедневный/еженедельный распорядок дня. Клиенту может быть полезно послушать музыку, которую он находит особенно успокаивающей.



КПТ СДВГ

Переосмысление ситуации

Клиент начнет учиться распознавать чувство гнева в себе и в других, выявлять признаки или триггеры, указывающие на то, что конфликт или конфронтация выходит из-под контроля, устанавливать самоконтроль, управлять чувствами возбуждения и снижать напряженность ситуации. Еще один способ управления конфликтами и конфронтацией состоит в том, чтобы научить клиента снижать вероятность того, что трудная ситуация станет угрожающей или спровоцирует гнев. Способ включает в себя когнитивное переосмысление ситуации и контроль над ней путем улучшения способа общения клиента.

При этом можно применить формулу СДВГ.



КПТ СДВГ

С - структурируй ситуацию

Д - дай описание своим чувствам

В - внеси ясность

Г - готовность к последствиям



КПТ СДВГ

С - структурируй ситуацию - разберись в ситуации, изложи факты о ней нейтрально и безоценочно.

Д - дай описание своим чувствам - опиши, как себя чувствуешь, основывая свое описание на фактах, используй утверждения “Я чувствую...”, а не “Он заставил меня чувствовать...” (такие фразы могут вызвать неприязнь и обиду).

В - внеси ясность - помоги другому понять, как он может улучшить ситуацию. Это очень важный этап, который часто остается за рамками процесса урегулирования. Очень важно дать другому человеку понять, чего именно ты хочешь, другой человек не "читает мысли".

Г - готовность к последствиям - определи последствия при любом исходе ситуации.



КПТ СДВГ

Работа с оскорблениями и критикой

Люди с РДВГ особенно восприимчивы к гневу, возникающему как после оскорблений, так и после критики. Возможно, это связано с тем, что они с большей вероятностью будут защищаться из-за того, что на протяжении всей своей жизни получали множество критических замечаний и отзывов от родителей, учителей, друзей, братьев и сестер, и теперь хотят защитить свою самооценку. Они также с большей вероятностью импульсивно отреагируют, не выслушав человека до конца и не поняв полностью сказанного, без точной оценки намерений другого человека и предположения о злом умысле. Однако, если клиенты смогут научиться отличать оскорбления от критики, они, скорее всего, смогут адекватно реагировать на оба типа высказываний.



Оскорбления по своей сути предназначены для того, чтобы заставить человека чувствовать себя плохо и/или злиться. В работе с оскорблениями клиента следует попросить подумать о самом страшном оскорблении, которое кто-то сказал в его адрес и которое заставило его

- Почему это заставило вас чувствовать себя плохо? (например, угрожало ли это вашей семье, мужественности и т.д.)
- Что было такого в этом заявлении, что вас расстроило? (например, было ли это именно то, что было сказано или то, как это было сказано, тоже расстроило вас? Был ли это тон его голоса? Было ли это из-за поведения человека? Был ли это особый язык тела?)
- Как вы думаете, почему этот человек сказал все это?



КПТ СДВГ

Сделав шаг назад и получив возможность рассмотреть оскорбление как комментарий, который был направлен на то, чтобы расстроить клиента, он, возможно, сможет понять, почему это его разозлило. Однако, что более важно, он сможет порассуждать о мотивации, стоящей за таким неприятным комментарием. Это поможет ему избавиться от гнева, поняв, что это эмоция внутри другого человека, которая выражается неуместно и недоброжелательно.



КПТ СДВГ

Это должно помочь клиенту увидеть оскорбления такими, какие они есть, и отвергнуть их как правду о себе. Если клиент чувствует, что его оскорбляют, беседа с самим собой в форме успокаивающих высказываний поможет ему контролировать свои чувства и сдерживать импульс к агрессивному ответу, например: "Я знаю, что он говорит это только для того, чтобы вывести меня из себя, я не доставлю ему такого удовольствия", "Я знаю, что я порядочный человек, и это главное".



Критика - это необходимая и часто полезная форма обратной связи. Конечно, лучше когда критика конструктивная, однако любому человеку может быть трудно воспринять ее, особенно если она оформлена негативно. Ниже приведен пример разницы между конструктивной или негативной критикой:

- негативная критика - “этот отчет действительно трудно читать. Он настолько плохо структурирован, что трудно уследить за тем, что вы пытаетесь сказать. Вам нужно научиться структурировать отчеты, иначе вы никогда не сможете донести суть дела”.
- конструктивная критика - “вы написали хороший отчет и высказали много интересных замечаний. Это можно было бы сделать лучше, если бы вы больше структурировали его, используя подзаголовки”.



КПТ СДВГ

Из-за личной истории неудач и/или недостаточной реализации своего потенциала люди с РДВГ привыкли к критике и, к сожалению, оскорблениям. Это означает, что им трудно признавать любую обратную связь, которая не является положительной и приносящей удовлетворение, потому что они сверхчувствительны к воспринимаемой критике, даже когда она подается деликатно и конструктивно. Как только они воспринимают любую форму критической обратной связи, они чувствуют угрозу и становятся раздраженными и/или злыми. Они, скорее всего, проигнорируют сказанное или интерпретируют комментарий чрезмерно обобщенно (обычно без того, чтобы выслушать его или обсудить комментарий полностью и надлежащим образом).



КПТ СДВГ

Они могут реагировать на воспринимаемую критику одним из двух способов, оба из которых предполагают чрезмерную реакцию:

- Будут проявлять агрессию
- Будут чувствовать себя чрезмерно обиженными. В этом случае они могут воспринять комментарий как неизменный личностный недостаток, вместо того, чтобы воспринимать критику как относящуюся к своему мнению.



Чтобы справиться с критикой, людям с РДВГ необходимо внимательно прислушиваться к тому, что им говорят, и убедиться, что они полностью понимают проблему. Дефицит внимания может привести к тому, что они пропустят более раннюю часть высказывания и просто поймут конец, а это означает, что их реакция будет основана на пропущенной информации, неточной оценке и интерпретации того, что было сказано. Конструктивная критика обычно начинается с положительного комментария, и, если это было упущено, они, скорее всего, воспримут комментарий или отзыв как личное оскорбление. Клиент должен самостоятельно контролировать свои чувства и быть более способным распознавать признаки усиливающегося проявления раздражительности и гнева, которые могут спровоцировать неадекватную реакцию или ту реакцию, о которой они могут пожалеть.



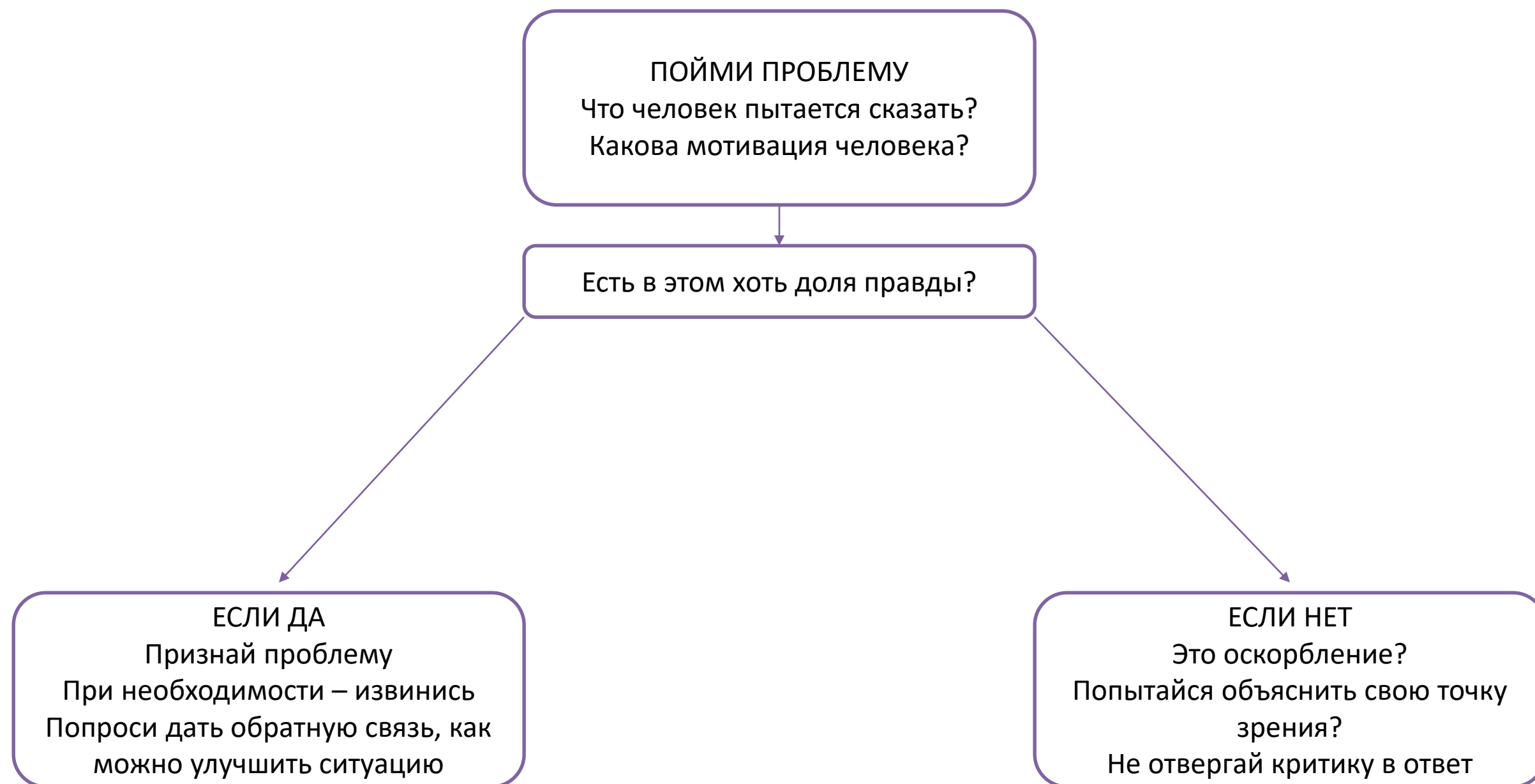
КПТ СДВГ

Таким образом, они будут распознавать "предупреждающие знаки" внутри себя, когда получают обратную связь, комментарии или критику, которые они воспринимают как негативные или угрожающие. На этом этапе они должны быть в состоянии прервать процесс гнева, попросив человека объяснить проблему или прокомментировать ее более подробно. При повторении комментария они могут услышать фрагменты, которые ранее были пропущены. Они лучше поймут проблему и определят мотивацию другого человека. Конечно, может быть станет ясно, что человек оскорблял, но в равной степени может стать ясно и то, что человек, критикующий клиента, пытается помочь, предлагая хороший совет и конструктивную обратную связь. Поощряйте клиента принять это с достоинством, даже если он все еще слегка возбужден и раздражен.



КПТ СДВГ

Играйте в ролевые игры на сессиях, помогая клиенту высказывать конструктивную критику другим(избегая быстрой и прямолинейной подачи информации), так и получать ее. Важно разыгрывать роли в обоих аспектах, потому что предоставление и получение конструктивной критики – это взаимный процесс, и понимание динамики обеих сторон поможет человеку лучше воспринимать критические отзывы в будущем. Давать конструктивную критику означает формулировать критику полезным образом, подчеркивая положительные аспекты, предлагая предложения по улучшению и поддерживая человека в внесении изменений или исправлений. Надлежащее принятие конструктивной критики означает заявление о признании проблемы, прояснение любых недоразумений, изложение общего понимания и плана действий. В некоторых обстоятельствах может оказаться уместным принести извинения за допущенные ошибки.





Ассертивность

Некоторые люди с СДВГ подавляют свой гнев. Они могут быть уступчивыми в поведении и соглашаться с пожеланиями и/или предложениями других, которые обычно отвергают. Это означает, что со временем у них внутри может зародиться сильное чувство обиды. Этим людям будет полезно научиться быть более напористыми и выражать свои собственные желания и потребности, а не соглашаться с позицией или поведением, с которыми они не согласны и которые позже вызовут у них гнев. Может показаться странным, что люди, страдающие проблемами с гневом, также могут испытывать трудности с самовыражением, но эти два понятия не являются несовместимыми. Поскольку у этих людей низкая самооценка, некоторые с большей вероятностью смирятся с ситуацией, чем будут жаловаться или пытаться что-то изменить.



КПТ СДВГ

Их гнев накапливается внутри, потому что:

- Они злятся на себя за то, что не могут постоять за себя
- Они злятся на других людей, которые используют их в своих интересах

Эти чувства медленно усиливаются, пока у некоторых людей они непредсказуемо не взрываются.



КПТ СДВГ

Быть ассертивным не значит быть агрессивным или пассивным. Агрессивные люди, как правило, проявляют чрезмерную силу в общении с другими, в то время как пассивные люди, как правило, покорны. Их глубинные потребности не удовлетворяются, что вызывает у них чувство обиды и/или гнева.

Быть ассертивным - значит уметь прямо и честно выражать свои чувства, не причиняя боли другим (как при агрессии) и не испытывая чувства обиды или принижения себя (как при пассивном поведении).



КПТ СДВГ

Терапевтические сессии изначально должны носить психообразовательный характер и позволять человеку понять разницу между самоутверждением и агрессией. Ассертивность предполагает умение постоять за себя, оставаясь при этом спокойным и вежливым. Этот навык требует действовать в своих наилучших интересах, но не вызывая гнева или агрессии у других. Как ассертивность, так и агрессия могут быть связаны с чувством гнева, но для того, чтобы быть ассертивным, требуется способность выражать гнев, не причиняя боли и не зля других. Например, кто-то, кто ведет себя напористо, может выразить свой гнев, но без угроз в адрес другого человека, без оскорблений, без наказаний и сарказма. Способ донести это до клиента - побудить его задуматься о результате, которого он хочет достичь. Чего они на самом деле хотят от взаимодействия?



КПТ СДВГ

Затем покажите клиенту, как этого добиться, используя шаги, описанные ранее в формуле СДВГ; то есть скажите человеку, что он чувствует, скажите ему, чего он хочет, скажите ему о результате. Выразите это спокойно и изложите это фактологически и недвусмысленно. Затем попросите клиента определить результат отказа от ассертивности. Если они продолжают вести себя агрессивно, вряд ли получат то, чего на самом деле хотят, и достигнут желаемого результата. Важна манера выражения. Следует поощрять клиентов выражать свои мысли от первого лица, потому что сообщения "я" являются ассертивными и передают чувства, например: "В данный момент я очень зол". Напротив, сообщения типа "Ты" с большей вероятностью будут восприняты как агрессивные, например: "Ты заставляешь меня чувствовать себя очень сердитым". Тон и манера выражения могут быть проиграны по ролям на сессии. Терапевт также должен искать возможности во время терапии признать и активно укреплять ассертивное поведение.



КПТ СДВГ

В ситуациях и ролевых играх следует обращать внимание на функциональные характеристики речи и язык тела, которые выражают асертивность в противоположность агрессии.

- Сделайте шаг назад - не стойте слишком близко, так как вторжение в личное пространство другого человека может быть воспринято как угроза. Это, скорее всего, обострит ситуацию и увеличит вероятность того, что она будет иметь отрицательный исход.
- Поддерживайте зрительный контакт и твердое выражение лица - это позволяет собеседнику увидеть, что клиент серьезно относится к тому, что он говорит. Помогите клиенту попрактиковаться в выражении лица и избежать "угрожающих взглядов", можно попросить его практиковаться перед зеркалом.
- Поддерживайте громкость голоса и темп на постоянном уровне - не кричите и не шепчите. Увеличение громкости и скорости речи может показаться собеседнику угрожающим, тем самым увеличивая вероятность того, что он разозлится и ситуация может обостриться. Если собеседник уже рассержен, использование нормальной громкости голоса также может помочь ему успокоиться. Напротив, очень тихая или безучастная речь может раздражать другого человека.
- Используйте формулу СДВГ, описанную ранее.



КПТ СДВГ

КОМОРБИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ДЕПРЕССИЯ



КПТ СДВГ

Депрессия является распространенным сопутствующим заболеванием у взрослых с РДВГ. В клинических выборках с РДВГ 16-31% взрослых страдают депрессией. Кроме того, 19-37% взрослых с РДВГ страдают дистимией, более легкой, но стойкой формой депрессии с низким настроением в качестве основного признака. Таким образом, клиенты с РДВГ, скорее всего, будут испытывать перепады настроения. Также полезно установить, имели ли место депрессивные эпизоды в прошлом, и если да, то, необходимо научить клиента приемам, позволяющим предотвратить перерастание его плохого настроения в более укоренившуюся депрессию в будущем. Когда депрессия сочетается с РДВГ, у человека также появляются дополнительные симптомы, такие как повышенные проблемы с концентрацией внимания и чувство вялости. Даже к легкой депрессии следует относиться серьезно и рассматривать ее как приоритетную, особенно с учетом того, что люди с РДВГ чаще совершают попытки самоубийства в контексте депрессивного заболевания. Если у них возникают мысли о самоубийстве, они могут импульсивно воплощать свои идеи в жизнь.



КПТ СДВГ

Существует несколько возможных объяснений того, почему люди с РДВГ могут быть подвержены большему риску депрессии. Например, они с большей вероятностью пережили неблагоприятные события в раннем детстве. Вполне вероятно, что родители детей с РДВГ не лишены своих проблем. Нелегко быть родителем и в лучшие времена, а воспитанием ребенка с РДВГ, который бросает вызов авторитету, нарушает правила и разрушает стабильную семейную жизнь, трудно управлять. Кроме того, у многих родителей не диагностирован РДВГ, а это означает, что они сами могут быть неорганизованными и хаотичными в своем стиле воспитания, и неспособными обеспечить надлежащую структуру и стабильность для своих детей. Как в школе, так и дома ребенок с РДВГ, скорее всего, подвергался чрезмерной критике.



КПТ СДВГ

Неуспеваемость в учебе обычно изначально не осознается как связанная с РДВГ, и истолковываемые другими как "лень". Трудности в отношениях, по-видимому, являются постоянной проблемой; в детстве у них, возможно, были трудности с установлением поддерживающих отношений; став взрослыми, они испытывают трудности с поддержанием дружеских отношений и испытывают недостаток в интимных отношениях. У них может быть низкая самооценка. Неудивительно, что эти переживания predispose человека к подавленному настроению и развитию депрессии в какой-то период его жизни.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ могут обнаружить, что наряду с плохим настроением они становятся особенно раздражительными и нетерпимыми. Они могут чувствовать себя виноватыми за те обидные вещи, которые они говорят и делают импульсивно по отношению к людям, которых они любят и о которых заботятся. Дефицит внимания также может усугубляться, что приводит к тому, что у человека еще меньше шансов выполнить поставленные задачи и это лишает его ощущения достижения цели. Люди могут отвлекаться от конструктивной деятельности и поглощаться своими собственными внутренними негативными автоматическими мыслями, которые характеризуют депрессию. Это приводит к нарушению сна с бессонницей и ранним пробуждением.



КПТ СДВГ

Внутренний конфликт между чувством беспокойства и отсутствием мотивации может быть источником дискомфорта и эмоционального истощения. Взгляд на мир через темные очки и ощущение безысходности вокруг приводит к тому, что некоторые люди пытаются справиться с этим, увеличивая потребление алкоголя или наркотиков. Такие механизмы совладания эффективны лишь временно. Алкоголь заглушает их печали, а наркотики дают кратковременный эффект облегчение (и, возможно, временное улучшение симптомов, в зависимости от предпочтительного вещества). Однако кратковременными последствиями являются похмелье и симптомы абстиненции, включая плохое настроение.



КПТ СДВГ

Регуляция настроения является серьезной проблемой для взрослых с РДВГ, и их способность регулировать настроение ухудшается при депрессии из-за повышения эмоциональной лабильности. Люди могут обнаружить, что они становятся плаксивыми без очевидной причины. Они также гораздо чаще бывают обидчивыми или вспыльчивыми. Действительно, у пациентов с РДВГ плохое настроение часто проявляется в виде гнева и понимается другими как плохой характер. Это может приводить к потребности скрывать свои чувства отчаяния и тщетности от других.

Когнитивная модель депрессии

Хорошо зарекомендовавшая себя когнитивная модель депрессии Бека может быть адаптирована для описания опыта взрослых с РДВГ, у которых проявляются депрессивные симптомы. Люди с РДВГ, вероятно, смогут подробнее рассказать о многочисленных ранних негативных переживаниях в жизни. Обычно они подвергаются критике со стороны родителей и учителей, которые говорили им, что они ленивы, глупы или неспособны учиться. По сравнению с их сверстниками могут быть даже объективные свидетельства, например, оценки за тесты, которые, возможно, заставили их чувствовать себя менее способными, чем другие, и заставили их усвоить идею о своем низком статусе. Благодаря этому типичному детскому опыту с РДВГ у людей, вероятно, сформировались представления о себе, связанные с чувством неполноценности. Распространенная схема заключается в том, что индивид отличается от других каким-то уникальным образом и что другие более способные, успешные, симпатичные и т.д. Такие схемы приводят к формированию дисфункциональных убеждений.



Обычно это утверждения типа "если... то", и они поддерживают низкую самооценку. Например, "Если я не буду изображать клоуна и развлекать людей, то они не захотят проводить со мной время", "Если я не завершу отчет на этой неделе, мой босс подумает, что я никуда не поеду, и уволит меня". Эти предположения недоступны на сознательном уровне, но, вероятно, повлияли на то, как люди с РДВГ взаимодействуют с другими и какие ожидания они возлагают на себя. Эти ожидания часто нереалистичны и чрезмерно высоки, что приводит к перфекционизму и педантичности в своих попытках их достичь. Это вызывает стресс, и чтобы уменьшить его, некоторые люди с СДВГ предпочитают довольствоваться нетребовательными видами деятельности, в которых у них больше шансов добиться успеха. Однако в глубине души они знают, что они не преуспевающие, что им не хватает уверенности в себе, чтобы проявить себя и раскрыть свой потенциал, что заставляет их чувствовать себя несчастными и глубоко неудовлетворенными. Они некритично воспринимают критику со стороны других и могут оказаться втянутыми в абьюзивные отношения.



КПТ СДВГ

Из-за невнимательности импульсивности люди с РДВГ с большей вероятностью столкнутся с негативными жизненными событиями, такими как потеря работы (либо потому, что они импульсивно уходят, либо их увольняют), развод или попадание в несчастные случаи и т.д. Когда происходят такие события, это ускоряет активацию ранее сформированных дисфункциональных схем и приводит к увеличению числа негативных автоматических мыслей о самих себе. В процессе этого индивидуальные дисфункциональные убеждения становятся осознанными, и человек может осознавать множество негативных мыслей о себе, проносящихся в его голове. Эти мысли могут быть настолько быстрыми и разрушающими, что человек чувствует себя полностью подавленным и, образно говоря, побежденным ими. Неспособность модулировать когнитивные способности и эмоции означает, что у человека могут развиваться такие симптомы, как лабильные перепады настроения в виде подавленности и гнева; безнадежность и чувство потери контроля над будущим; рассеянность и озабоченность; а также потеря творческих ресурсов, интереса и энергии, которые обычно легко доступны человеку.



КПТ СДВГ

Человеку с РДВГ нелегко концентрироваться на задании и в лучшие времена, но когда его собственные мысли и чувства становятся "внутренними отвлекающими факторами", концентрироваться становится особенно тяжело. Если плохое настроение перерастает в депрессию, человек может стать замкнутым, нерешительным и полностью сдать. В свою очередь, это подтвердит лежащую в основе схему, и будут активированы дисфункциональные убеждения, которые существуют сами по себе. Это, в свою очередь, усиливает поведение и удерживает человека вовлеченным в порочный круг депрессии.



Однако, по-видимому, у человека с РДВГ есть положительный аспект, который может защитить его от сползания в клиническую депрессию – это жизнестойкость и способность когнитивно переосмысливать социальные проблемы и разочарования. Действительно, из интервью с людьми с РДВГ выясняется, что общей характеристикой для них является способность приходить в норму и пробовать снова. Лабильность настроения означает, что состояние их настроения меняется (иногда быстро), и эти колебания могут подстегнуть их творческий потенциал и интерес к жизни. Альтернативным объяснением может быть то, что они не в состоянии противостоять импульсу попробовать еще раз, когда другие могут прийти к выводу, что тот или иной вариант нежизнеспособен.



КПТ СДВГ

Проблемы с концентрацией внимания могут также способствовать повышению жизнестойкости, ограничивая способность рассуждать о последствиях негативных ситуаций и предсказывать или предвосхищать будущие проблемы. Однако нужно предупредить, что в то время как у некоторых людей эта характеристика может служить защитным фактором, у других она может предрасполагать к депрессии, поскольку приводит к тому, что они переживают большее количество негативных событий или неудач. События могут накапливаться и достигать критической массы, когда жизнестойкость больше не может вернуть их к позитивному настрою, и люди остаются с наследием неудач и сожалений, которые кажутся непреодолимыми.





Стили негативного мышления при РДВГ

Стили негативного мышления напрямую связаны с настроением. Когда настроение колеблется, как это часто бывает у людей с РДВГ, их когнитивные способности колеблются, и это может вызвать у человека чувство растерянности, неуверенности и огорчения. Кроме того, люди с депрессией и РДВГ, скорее всего, будут резкими или раздражительными, что, вероятно, увеличит частоту негативных социальных контактов. Это может привести к социальной замкнутости для уменьшения чувства раздражения, посредством избегания людей или ситуаций, которые будут заставлять их чувствовать себя таким образом, либо они начинают воспринимать себя как "неприятного" человека. **Когнитивная триада** – это сосредоточение внимания на негативных аспектах "я", мира и будущего (Бек, 1963). Легко понять, как может развиваться эта позиция, когда у человека есть основополагающая схема, согласно которой он глуп и бесполезен (сам), другие находят его ленивым и раздражительным(мир), и что завтрашний день мрачен и неизменен (будущее).



КПТ СДВГ

Возможно, именно этот последний аспект не позволяет людям с РДВГ полностью капитулировать перед клинической депрессией, поскольку зачастую они смотрят на мир как на вызов. Они видят, что возможен лучший результат, потому что чувствуют, что не реализуют свой потенциал. Это означает, что они верят, что у них есть потенциал, даже если они не осознают его в полной мере. Такие убеждения являются "пищей" для когнитивных проблем и альтернативного мышления, которых можно достичь, развивая естественный интерес и любознательность человека с РДВГ к новым задачам. Их таланты необходимо выявлять и использовать. Стил мышления при РДВГ определяется скоростью. Люди с РДВГ непроизвольно реагируют как в поведенческом, так и в когнитивном плане. Их часто отвлекают мысли, которые "берутся из ниоткуда" и они перескакивают с одной идеи на другую, когда пытаются сосредоточиться на чем-то одном. Когда эти мысли негативны, они вызывают особое беспокойство.



КПТ СДВГ

Характерные черты негативных мыслей заключаются в том, что они:

- автоматические - они просто всплывают в голове и не генерируются сознательно
- искаженные - они учитывают только негатив
- бесполезные - они поддерживают порочный круг плохого настроения
- правдоподобные - они не ставятся под сомнение, потому что кажутся "правдивыми"
- произвольные - они возникают не по выбору, и их трудно отключить



КПТ СДВГ

Люди с СДВГ с большей вероятностью признают правдоподобность негативных автоматических мыслей, потому что им трудно думать о последствиях и оценивать мысли. Психообразование относительно негативных автоматических мыслей важно в любой терапии депрессии. Однако это будет особенно важно для людей с РДВГ, поскольку их слияние с такими мыслями может быть исключительно сильным. Люди с РДВГ - страстные люди, и когда они чувствуют себя подавленными, они будут чувствовать себя страстно подавленными. Научиться распознавать негативные автоматические мысли непросто, и для этого потребуются практика. Люди с РДВГ часто ищут объяснение своему негативному жизненному опыту. Их необходимо познакомить с типичными когнитивными ошибками.

Ошибки мышления могут дополнительно быть связаны со склонностью взрослых с РДВГ делать быстрые, ошибочные выводы из-за неспособности остановиться и включиться в процесс последовательного мышления, этот бессистемный подход к жизни означает, что взрослые с РДВГ не развивают способность рассуждать рационально. Наиболее распространенной мыслительной ошибкой людей с РДВГ является склонность к поспешным выводам, что проистекает из их плохого контроля над импульсами. Например, человек с РДВГ может думать, что он не нравится своему начальнику. Однажды его попросили пойти поговорить со своим начальником, и он сделал поспешный вывод, что его собираются уволить с работы. Руководствуясь этой мыслью, он вошел в главный офис, накричал на своего начальника, написал заявление на увольнение и ушел. Это произошло в отсутствие какой-либо информации, указывающей на то, что его собирались уволить. Позже он узнал, что его собирались повысить в должности.



КПТ СДВГ

Люди с РДВГ нуждаются в большей практике в терапии негативных мыслей из-за проблем с вниманием и трудностей в усвоении концепций. Они также с большей вероятностью импульсивно сдадутся и быстро решат, что не могут этого сделать. Поэтому крайне важно, чтобы клиент выполнял домашнее задание. Более ранняя неудача усилит негативную схему и приведет к избеганию. Нужно постоянно контролировать, чтобы клиент завершал запись мыслей (можно использовать голосовые сообщения).



КПТ СДВГ

Точно так же, как мысли могут усугубить плохое настроение, их также можно использовать для улучшения настроения. Объяснение того, как можно обратить вспять порочную спираль, может стать сильным мотиватором и вселить чувство надежды. Осознание того, что различные, более негативные мысли в одной и той же ситуации могут привести к переживанию положительных чувств и привести к позитивному поведению, может улучшить настроение. Этим навыком трудно овладеть, поскольку клиент должен научиться устанавливать контроль над лабильностью, которую, как он долгое время считал, он не может контролировать.



Следует поощрять клиента рассматривать альтернативные интерпретации, например, заменять такие мысли, как "Я не могу справиться", на "это сложно, но я справлюсь, если буду делать это шаг за шагом". Однако людям с РДВГ, вероятно, будет трудно рассматривать альтернативы оригинальному мышлению из-за проблем с исполнительным функционированием и относительной негибкости. Это кажется ироничным, учитывая, что они часто обладают сильным творческим талантом. Проблема здесь в том, что они обладают способностью генерировать множество оригинальных идей, но не делают этого спонтанно, поскольку либо придерживаются какое-то время они жестко придерживаются одного аспекта и вообще не рассматривают альтернативные идеи или решения, или они сдаются и переходят к совершенно другой теме, оставляя задачу незавершенной или проблему нерешенной. Эту ригидность необходимо преодолеть, научив клиента расслабляться и позволять новым идеям течь потоком.



КПТ СДВГ

Упражнение: вызов негативному мышлению

1. Каковы доказательства того, что вы не можете справиться? Запишите случаи, когда вы успешно справлялись в прошлом.
2. Представьте, что ваш друг пришел к вам с этой проблемой - что бы вы ему сказали?
3. Рассматривали бы вы это таким же образом, то есть полагая, что решений нет?
4. Что самое худшее, что может случиться? Не переоцениваю ли я вероятность того, что это произойдет?



КПТ СДВГ

Одним из положительных аспектов работы с людьми с РДВГ является то, что, как только они овладеют навыками мозгового штурма и принятия перспективных решений, они, похоже, быстро развивают эти навыки и внедряют их в свою повседневную жизнь. Это, скорее всего, отражает тот факт, что эти методы задействуют их творческий потенциал и изобретательность, и, как только они овладеют навыком альтернативного мышления, у них не возникнет трудностей с применением этого процесса. Ключевым моментом является умение перестать автоматически принимать оригинальную мысль или идею и включиться в процесс логического или альтернативного мышления. На более фундаментальном уровне клиента можно побудить прервать автоматическое реагирование, связав процесс с визуальным образом, например, новой идеей, красной вспышкой, знаком "стоп".



КПТ СДВГ

Как только негативные мысли определены и мыслительный процесс остановлен, клиент может возможно, вам поможет научиться заменять негативную мысль более позитивной. Может быть полезно составить список возможных негативных и позитивных мыслей. Метод включает в себя разделение листа бумаги на две колонки и написание списка негативных мыслей на одной стороне страницы, а затем списка позитивных самоутверждений на другой стороне. Убедитесь, что пункты не являются глобальными абстрактными мыслями или схемами, а относятся к мыслям об этом моменте времени.



КПТ СДВГ

Поведенческая активация

У клиентов с **СДВГ + депрессией** поведенческая активация — один из ключевых инструментов, но её реализация отличается от «классической» при депрессии.

Зачем нужна поведенческая активация:

- При депрессии активность падает, что усиливает негативное настроение.
- При РДВГ активность есть, но часто дезорганизованная, хаотичная.
- При сочетании возникает «двойной барьер»: низкая энергия и низкая организация. Поэтому поведенческая активация становится способом вернуть клиенту структуру и мотивацию.



Особенности при РДВГ

- **Импульсивность:** клиент выбирает «активацию» не по плану, а спонтанно → может уйти в прокрастинацию (например, вместо прогулки 2 часа в телефоне).
- **Нарушения планирования:** трудно удерживать долгосрочный график активностей.
- **Проблемы с началом действий:** даже приятные активности не запускаются без внешних напоминаний.
- **Эмоциональная лабильность:** небольшие неудачи («не сделал прогулку вчера») быстро превращаются в глобальное самокритичное обесценивание.
- **Риск гиперфокусировки:** клиент может застрять на одной активности, игнорируя остальные сферы жизни.



Подводные камни

1. Слишком большие шаги

1. Классическая поведенческая активация предлагает список приятных и значимых активностей. При РДВГ это часто вызывает перегруз: список длинный, клиент не знает, с чего начать.
2. Нужно дробить до мини-задач («5 минут прогулки», «открыть книгу и прочитать 1 страницу»).

2. Отсутствие системы напоминаний

1. Если полагаться только на память, то клиент забудет.
2. Нужен телефон, визуальные сигналы, чек-листы.

3. Перфекционизм и самокритика

1. Клиент думает: «Я должен делать всё идеально» → срыв → усиление депрессии.
2. Важно акцентировать: «Любой шаг = успех».



4. Неправильная оценка удовольствия

1. При РДВГ стимулы «быстрой награды» (игры, соцсети) могут доминировать, а «долгосрочные полезные активности» будут избегаться.
2. Нужно учить балансировать между «немедленным удовольствием» и «ценностными действиями».

5. Усталость от гиперстимуляции

1. Иногда клиент начинает слишком много активностей → быстро выгорает.
2. Задача терапевта — помогать регулировать уровень нагрузки.

Как адаптировать поведенческую активацию под РДВГ

- **Еженедельный календарь:** записывать активность в конкретное время (а не «когда будет настроение»).
- **Мини-формат:** правило 5 минут («начни с минимального»).
- **Напоминания:** телефон, визуальные сигналы, голосовые записи.
- **Чёткая связь с ценностями:** каждую активность привязать к значимым сферам («Звоню другу → поддержка отношений»).
- **Система быстрых наград:** за каждую выполненную активность — маленькая «плюшка» (например, чашка кофе, 5 минут соцсетей).
- **Отслеживание настроения:** дневник «Активность → настроение» помогает увидеть прямую связь, что укрепляет мотивацию.
- **Социальная поддержка:** партнёр, друг, родитель может «поддержать выполнение» (сообщить, спросить, сделать вместе).



Важные акценты для терапевта

- Не перегружать клиента сразу большим количеством активностей.
- Подчёркивать **процесс, а не результат** (главное — попробовать, а не сделать идеально).
- Использовать **ин-сесссионные практики**: часть активации делать прямо на сессии (например, клиент пишет другу сообщение или идёт по лестнице).
- Снижать самокритику: провалы интерпретировать как «данные для эксперимента», а не доказательство неудачи.



КПТ СДВГ

КОМОРБИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

НАРУШЕНИЕ СНА



КПТ СДВГ

Многие люди с РДВГ сообщают о трудностях со сном. Нарушения сна сами по себе могут вызывать недостаточное функционирование префронтальной коры и приводить к таким симптомам, как недостаточная концентрация внимания и импульсивность у людей без РДВГ. Таким образом, проблемы со сном могут усугубить существующий когнитивный дефицит при РДВГ. Трудности со сном могут быть вызваны сопутствующим расстройством, таким как депрессия, тревога или злоупотребление психоактивными веществами. Некоторые люди сообщают, что чувствуют себя слишком беспокойными, чтобы заснуть, как будто они постоянно "в движении" и не могут расслабиться.



Есть основания предполагать, что существует специфическая взаимосвязь между проблемами с вниманием и расстройствами сна из-за тесной связи между системами мозга, участвующими в регуляции областей сна/возбуждения, и теми, которые участвуют в регуляции внимания и аффекта. Сон (ночью) и внимание/бдительность (в течение дня) может быть концептуализирована как противоположные крайности одного и того же континуума. Нарушение внимания и бдительности в дневное время может повлиять на ночной сон, и наоборот. Возможно, проблема с регулированием системы возбуждения приводит к тому, что люди с РДВГ не могут достичь как полной бдительности, так и глубокого сна и позволяет им функционировать только в состоянии полудремоты в течение дня и ночи. Беспокойство является одним из основных симптомов РДВГ, и это может мешать людям расслабиться и/или достичь адекватного сна.



КПТ СДВГ

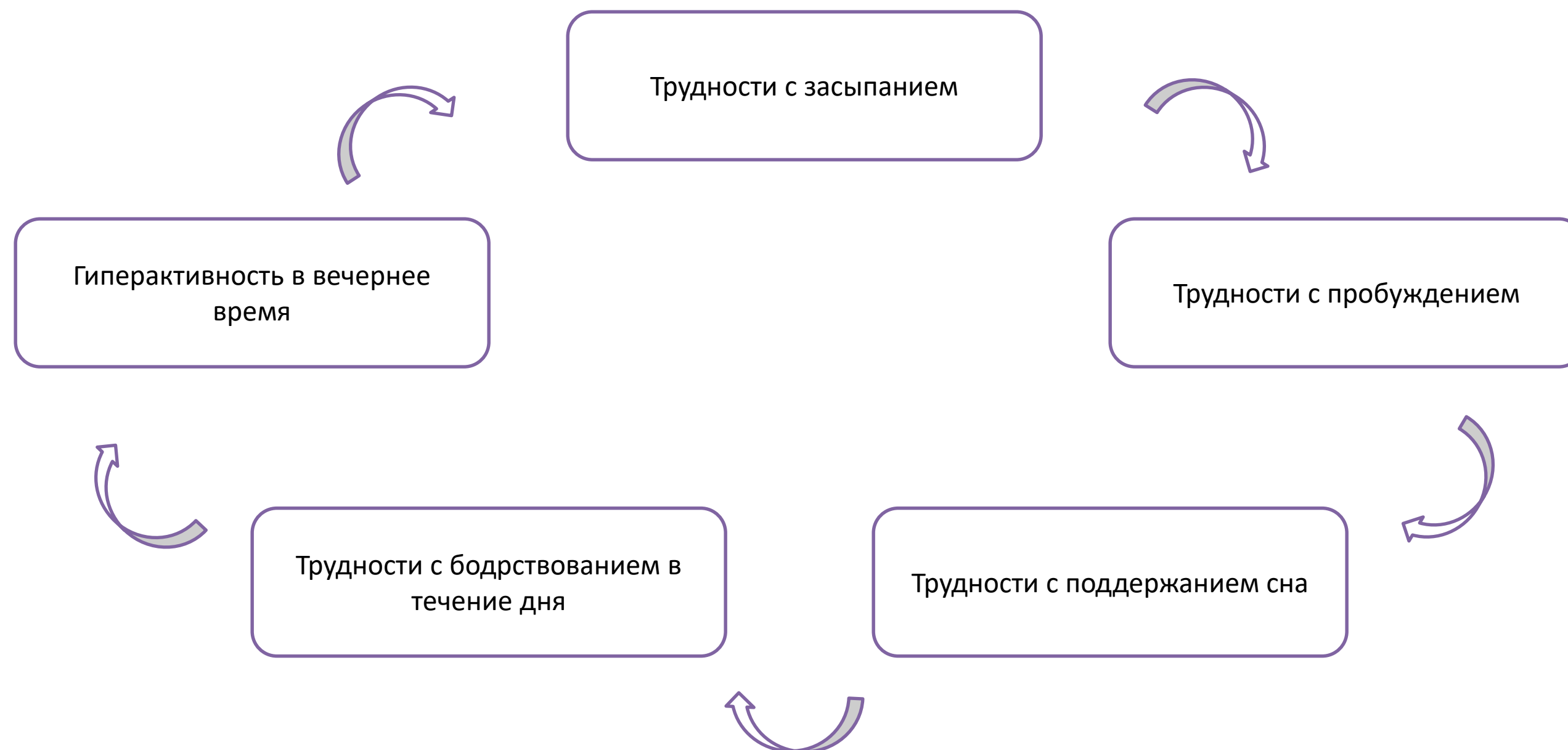
Взрослые клиенты обычно сообщают о том, что испытывают трудности с непрерывной умственной деятельностью, и эта проблема вполне может сохраняться всю ночь и мешать им спать. Это может негативно сказаться на их способности посещать занятия днем, когда они могут быть более склонны к сонливости из-за недосыпания. Кроме того, трудности людей с РДВГ с организацией и расстановкой приоритетов часто приводят к тому, что они пытаются выполнять задания очень поздно ночью, что сокращает время их сна. Когда они все-таки ложатся спать, они могут быть заняты своими незавершенными делами.



КПТ СДВГ

Исследования РДВГ у детей свидетельствуют о том, что они более склонны к бессоннице, храпу, синдрому беспокойных ног и дневной сонливости больше, чем дети без РДВГ. Эти проблемы сохраняются во взрослом возрасте.

Дисфункциональный цикл сна





КПТ СДВГ

Многие люди с РДВГ испытывают все три проблемы со сном (засыпание, пробуждение, поддержание бдительности), потому что они взаимосвязаны. Им трудно заснуть, потому что по вечерам они бодрствуют и, как правило, занимаются стимулирующими видами деятельности, такими как работа или интенсивное общение. Им может быть трудно заснуть, в конечном итоге они спят урывками, а затем им трудно проснуться утром, так как все еще чувствуют усталость. Поскольку они не выспались ночью, они чувствуют сонливость, и им трудно сохранять бдительность в течение дня. Однако по мере того, как день подходит к концу, они постепенно чувствуют себя более бодрыми и начинают активничать. Достижения, достигнутые вечером, когда они считают, что они более бдительны, негативно подкрепляют этот цикл. Со временем этот цикл негативного подкрепления превращается в дисфункциональный паттерн, другими словами, в расстройство сна.



Люди с РДВГ часто описывают трудности с засыпанием и продолжением сна. Их проблемы могут включать любую из следующих: задержка засыпания, недостаточная продолжительность сна, частые пробуждения, раннее окончательное пробуждение. Однако большинство клиентов, жалующихся на бессонницу, переоценивают, сколько времени им требуется, чтобы заснуть, и недооценивают, как долго они на самом деле спали. Некоторые люди с РДВГ могут обнаружить, что они становятся более беспокойными позднее в течение дня и в результате обнаруживают, что вечером вовлекаются в занятия, которые несовместимы со сном (спорт, компьютерные игры или серфинг в Интернете). Гиперактивность по вечерам у других людей с СРДВГ может быть связана с тем, что им легче сосредоточиться вечером, возможно, потому, что в это время тише и возможность отвлекаться сведена к минимуму, например, когда их дети легли спать. Кроме того, некоторые вечерние мероприятия могут стать необходимыми для людей с РДВГ, поскольку их склонность к прокрастинации в течение дня означает, что им приходится наверстывать время и выполнять задачи, работая допоздна.



Другие описывают постепенное чувство вялости по утрам, но становятся все более бдительными и энергичными по ходу дня. Проблемы с пробуждением по утрам часто связаны с недостаточным количеством сна ночью многие люди с РДВГ описывают, что им чрезвычайно трудно заснуть далеко за полночь, даже когда им нужно рано вставать на работу или на учебу, следовательно, эта проблема может быть отсроченной реакцией на позднее начало сна. Некоторые "полуночники" могут адаптировать свой график к циклу сна-бодрствования и, возможно, при необходимости смогут организовать свой день так, чтобы он начинался позже, чем у большинства. Это будет особенно хорошо работать для самозанятых лиц, хотя это может привести к отсутствию структуры и потребовать больше времени в течение дня те, кто не может быть таким гибким, обнаруживают, что пытаются функционировать из-за недостатка сна. В конечном итоге они чувствуют себя разбитыми и раздражительными, особенно по утрам. Это может привести к обострению когнитивного дефицита, связанного с РДВГ, из-за переутомления.



КПТ СДВГ

Конечно, опоздания и переутомление негативно повлияют на успеваемость человека в учебе и на работе. Эта проблема со сном также может вызвать проблемы в семье, если утренние обязанности распределяются ненадлежащим образом, например, партнеры клиентов могут сообщать, что чувствуют себя очень обиженными, если их оставляют поднимать детей и готовить их к школе, в то время как партнер с РДВГ продолжает спать все утро. Большинство людей с РДВГ испытывают трудности с поддержанием внимания. Однако некоторым людям с РДВГ также трудно поддерживать достаточный уровень возбуждения или бдительности, когда они не выполняют стимулирующие умственные задачи или физическую активность, они могут чувствовать сонливость и постоянно зевать, они могут засыпать на лекциях или собраниях, в некоторых случаях, несмотря на достаточный ночной сон. Опять же, это может оказать огромное влияние на их образование, карьеру и социальные отношения.



КПТ СДВГ

Обструктивное апноэ сна

Нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Распространенной формой является обструктивное апноэ во сне, при котором дыхательное горло сжимается во время дыхания, когда мышцы расслабляются во время сна. Мозг реагирует, заставляя человека открыть дыхательное горло, что обычно приводит к фырканию или затрудненному дыханию. Это может происходить сотни раз за ночь. Апноэ во сне связано с ожирением или потерей мышечного тонуса и может привести к громкому храпу. Это часто связано с чрезмерной дневной сонливостью, переутомлением и нарушением внимания, особенно бдительности.



Ночные ужасы

Ночные ужасы - это экстремальные и анимированные версии ночных кошмаров. Спящий испытывает чувство ужасной опасности, человеку может физически и акустически казаться что-то страшное, и человек будет пытаться защитить себя. Ночные ужасы могут отличаться от ночных кошмаров тем, что они с меньшей вероятностью запоминаются. Это может быть особенно пугающим для человека, поскольку он может просыпаться ночью с учащенным сердцебиением и другими симптомами, похожими на приступ паники, и все же не распознавать триггеры. Это может привести к катастрофическому толкованию проблем со здоровьем. У взрослых пациентов ночные кошмары, по-видимому, более вероятны в контексте дневных тревог, когда стресс или озабоченность могут негативно повлиять на сон и содержание сновидений.



Синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног - это расстройство, которое вызывает неприятные ощущения ползания мурашек, покалывания в ногах и ступнях и желание пошевелить ими для облегчения. Синдром беспокойных ног может привести к постоянному движению ног в течение дня и повторным пробуждениям в течение ночи. Неясно, приводит ли дискомфорт, вызванный этим состоянием, к плохому качеству сна, что, таким образом, влияет на концентрацию внимания и гиперактивность, или, наоборот, синдром беспокойных ног и РДВГ являются частью симптомокомплекса, при котором в обоих расстройствах участвует дофаминергический дефицит.



Психообразование о сне

Клиентам важно получить представление о процессе и функциях сна, чтобы они могли определить, где возникают их проблемы со сном, и следовательно понять, как улучшить свой сон. Цикл сна является хорошей отправной точкой в психообразовании, поскольку позволяет клиенту осознать, что сон - это не просто одно устойчивое состояние, а проходит через фазы, и на самом деле иногда просыпаться ночью - это нормально. Анализ функций сна с клиентом может быть полезным упражнением для выявления любых неправильных представлений о том, что происходит, если они не высыпаются в достаточном количестве или их сон некачественный. Кроме того, следует объяснить причины проблем со сном клиенту, поскольку он может быстро распознать закономерность своих проблем со сном и сможет помочь разработать подходящие стратегии для улучшения своего сна.



КПТ СДВГ

На сон может влиять множество различных факторов, включая психологические, поведенческие, экологические или биологические. Психологические факторы включают симптомы, связанные с РДВГ, такие как беспокойство, а также другие расстройства настроения. Поведенческие трудности, особенно неадаптивный режим сна, могут повлиять на сон в ночное время. Хотя они часто очень очевидны, внешние триггеры из окружающей среды могут быть причиной проблем со сном, поскольку они будят человека. Биологические факторы могут быть особенно актуальны для людей с РДВГ, поскольку не только принимаемые ими лекарства могут влиять на качество их сна, но и другие особенности образа жизни могут играть определенную роль.

Психологические факторы нарушения сна:

- беспокойство/непрерывная умственная активность - человек все еще чувствует себя очень активным перед сном и ему очень трудно успокоиться и расслабиться.
- беспокойство конкретно о сне - беспокойство о том, выспится ли человек, или будет чувствовать усталость утром, из-за этого засыпание затрудняется
- несовместимые со сном действия - игра в компьютерные игры, использование телефона в постели перед сном, работа в кровати, из-за этого спальня может терять свою функцию, как место отдыха.
- хроническая тревога или депрессия - вызывает размышление о проблемах, таких как события дня, все эти мысли могут не давать уснуть (увеличивается умственная активность).
- нарушение цикла сон-бодрствование (активность-отдых) - нерегулярный режим сна может быть вызван нерегулярным отходом ко сну и пробуждением. У людей с РДВГ это может происходить из-за дезорганизации, заставляющей их откладывать дела на последнюю минуту и засиживаться допоздна, чтобы их выполнить. Либо человек работает по ночам (режим работы).

- бессонница из-за сонливости в дневное время - распространенной проблемой людей с РДВГ является то, что они не встают утром и валяются в постели до обеда или позже. Это влияет на их способность засыпать ночью. Аналогичным образом, дневной сон может обеспечить кратковременное облегчение, но не способствует хорошему ночному сну.
- ночные приступы паники - люди с РДВГ часто прокрастинируют и откладывают дела на последнюю минуту, это может привести к тому, что они будут паниковать поздно вечером из-за задач, которые они не выполнили к сроку. Затем они могут либо не спать всю ночь, работая над заданием, либо нарушить установленный срок, что затем может повлиять на их сон из-за беспокойства или ночных ужасов.



Факторы окружающей среды:

- непредсказуемая сенсорная стимуляция (шум, свет и прочее). Учитывая их отвлекаемость, люди с РДВГ более чувствительны к внешним стимулам, когда пытаются уснуть. Например, голоса за окном, шум уличного движения, свет и так далее.
- значимые сигналы - из-за своей отвлекаемости люди с РДВГ могут быть более чувствительными к предсказуемым значимым сигналам, таким как дневной свет по утрам, пробуждение детей и прочее. Дети с РДВГ чаще страдают нарушениями сна, которые влияют на качество сна родителей.
- интенсивная сенсорная стимуляция - например, высокие или низкие температуры могут повлиять на сон, а также влажность и так далее.

Биологические факторы:

- стимулирующие препараты - у некоторых пациентов с РДВГ стимулирующие препараты, такие как метилфенидат, могут облегчить симптомы РДВГ и обратить вспять беспокойство. Однако у многих людей стимуляторы могут также поддерживать бодрствование.
- побочные эффекты лечения проблем со здоровьем или психических расстройств -например, антидепрессанты могут влиять на сон.
- чрезмерное употребление кофеина/энергетиков для облегчения симптомов РДВГ.
- обильные порции еды незадолго до сна – переваривание пищи не способствует сну, так как организм более активен в такие периоды. Многие люди с РДВГ забывают поесть, а затем вечером чувствуют невероятный голод и едят много перед сном.



КПТ СДВГ

- Энергозатратные физические упражнения незадолго до сна – из-за своей гиперактивности люди с РДВГ обнаруживают, что в конце дня им нужно потратить избыток энергии. Активная физическая нагрузка помогает разбудить организм и может затруднить засыпание.
- Проблемы с соматическим здоровьем – особенно болевой синдром.
- Потребность в мочеиспускании – употребление большого количества воды или алкоголя вечером может привести к тому, что человек будет часто пробуждаться ночью.
- Затруднение дыхания во сне – обструктивное апноэ может привести к нарушению сна и когнитивному дефициту.



Вмешательство при нарушениях сна первоначально требует тщательного мониторинга проблемы, чтобы получить данные, исходя из которых можно измерить изменения. Процесс должен включать рассмотрение множества факторов, которые могут влиять на сон, таких как уровень активности, диета, кофеин, алкоголь, лекарства и т.д. Также важно полностью изучить ожидания человека относительно сна, например, определив, сколько, по его мнению, ему нужно спать и что происходит с ним, когда он этого не достигает. Потребности во сне варьируются у разных людей. Возможно, 40-летний клиент считает, что ему следует стремиться спать столько же, сколько он спал, когда ему было 18 лет. Таким образом, терапевт может просветить клиента по этому вопросу и помочь ему установить оптимальное количество сна. Методы борьбы с нарушениями сна могут быть основаны на мониторинге проблем со сном и изменении моделей поведения и/или включать в себя большую когнитивную направленность, причем последний метод более эффективен, если на качество сна влияют факторы настроения.



КПТ СДВГ

КОМОРБИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СИМПТОМЫ/СОПРОТИВЛЕНИЕ**



КПТ СДВГ

Взрослые с СРДВГ часто сталкиваются не только с невнимательностью или импульсивностью, но и с нарушением эмоциональной регуляции. Сильные вспышки гнева (“мелтдаун”) или эмоциональная замкнутость (“шатдаун”) являются обычным явлением и могут подавлять как самого человека, так и его близких. Эти трудности часто возникают из-за связанных с РДВГ нарушений в управлении и эмоциональной регуляции.

Когнитивно-поведенческая терапия хорошо подходит для решения этих проблем, обучая конкретным навыкам (организации, совладанию с трудностями, когнитивной реструктуризации) и улучшая эмоциональную саморегуляцию.



Кроме того, некоторые взрослые с РДВГ демонстрируют экстремальное поведение, связанное с избеганием требований – патологическое избегание требований. ПИТ описывает вызванную тревогой потребность избежать повседневных требований или предполагаемых требований к выполнению. Исследования показывают, что черты РДВГ (невнимательность, импульсивность, эмоциональная нестабильность) в большей степени, чем черты аутизма, предсказывают паттерны, подобные ПИТ. На практике ПИТ при РДВГ может выглядеть как хроническое промедление, откладывание или демонстративный отказ от выполнения заданий или инструкций.



Эмоциональные срывы/мелтдауны (нарушение регуляции при РДВГ): интенсивные всплески эмоций (гнев, плач, ярость), которые кажутся неконтролируемыми. Взрослые описывают их как “взрыв”, когда накапливаются стрессовые факторы. Распространенными триггерами являются сенсорная перегрузка, хроническая фрустрация (невыполненные задания, критика) и крайнее истощение. Например, дисфория, чувствительная к отвержению - сильная эмоциональная боль от воспринимаемой критики – может спровоцировать нервный мелтдаун. Во время приступа взрослые с РДВГ могут кричать, швыряться предметами или впадать в гневные истерики, часто испытывая непреодолимую ярость или панику.



Когнитивные шатдауны: внутренняя форма нарушения регуляции, при которой человек мысленно “отключается”. Это проявляется как психический паралич или диссоциация: пустой взгляд, неспособность говорить или внезапная остановка активности. Отключения обычно происходят при сильной перегрузке: слишком большом количестве вариантов или задач, интенсивном сенсорном воздействии или острой тревоге (например, страхе неудачи). Человек может отстраниться от ситуации (уйти в тихое место) и почувствовать оцепенение или истощение. С точки зрения КПТ, шатдаун - это состояние, при котором разум защищает себя, замирая.



КПТ СДВГ

Патологическое избегание требований: ПИТ предполагает отказ от выполнения рутинных требований, вызванный крайней тревогой, или бегство от них. Люди ведут себя так, как будто любая просьба представляет угрозу их самостоятельности. Они могут спорить, тянуть время, отвлекать других или наотрез отказываться выполнять задания, которые кажутся другим обычными. Например, просьба помыть посуду может спровоцировать немедленный, полный тревоги отказ или переговоры (“Я сделаю это позже, я занят”), чтобы восстановить контроль. В отличие от простого неповиновения, ПИТ основан на высокой тревожности и необходимости избегать предполагаемого контроля.



Функциональный анализ

Используя подход КПТ, мы разбиваем каждую проблему на предпосылки (триггеры), мысли/познания, эмоции, поведение и последствия:

- **Мелтдаун**
 - Предшествующие факторы: накопление стрессовых факторов (например, сенсорная перегрузка, длительная фрустрация, воспринимаемая критика).
 - Когнитивные факторы: катастрофизация и обвинение себя/других (например, “Это невозможно”, “Я не могу с этим справиться”, “Они никогда меня не слушают”).
 - Эмоциональные факторы: сильный гнев, тревога, отчаяние.
 - Поведение: крики, плач, физическая или вербальная агрессия, самоповреждение. Человек может потерять понимание ситуации.
 - Краткосрочные последствия: временная эмоциональная разрядка или внимание со стороны окружающих (внезапное избавление от стресса).
 - Долгосрочные последствия: чувство вины, стыда, испорченные отношения, усиление избегания (“Если я закричу, по крайней мере, некоторые требования на время исчезнут”).

- **Шатдаун**

- Предшествующие факторы: внезапная перегрузка (например, слишком много задач одновременно, непреодолимый выбор, яркий свет или шум, страх неудачи).
- Когнитивные факторы: негативные мысли (“С меня хватит”, “Это уже слишком”, “Я все равно потерплю неудачу”). Размышления о прошлых ошибках могут спровоцировать шатдаун.
- Эмоциональные факторы: сильное беспокойство или паника, которые могут переходить в оцепенение; ощущение “замороженности”.
- Поведение: отказ от активности (сидение неподвижно, выход из комнаты), молчание, неспособность реагировать или действовать. Человек может закрывать глаза, отворачиваться или казаться отстраненным.
- Следствие: немедленное снижение спроса, но задачи остаются незавершенными, а негативное представление о себе усиливается (например, “Я ничего не могу сделать”). Пропущенные мероприятия или обязанности могут впоследствии усилить тревогу.

- **Патологическое избегание требований**

- Предпосылки: любое явное требование или просьба (рабочие задачи, домашние хлопоты, планы), особенно если они воспринимаются как срочные или навязанные. Также внутренние потребности (голод, встречи) могут вызывать беспокойство. Неопределенность и строгие правила усиливают избегание.
- Когнитивные факторы: ощущение контроля или загнанности в ловушку (“Они мной командуют”, “Я должен сбежать”), сильный страх перед негативными последствиями.
- Эмоциональные факторы: тревога на уровне паники или ужас перед требованиями. Часто сопровождается гневом или раздражительностью из-за предполагаемой потери самостоятельности.
- Поведение: стратегии активного избегания – переговоры (“Можно я займусь этим позже?”), отвлечение внимания от того, кто требует, уход из помещения, прямой отказ или агрессия. Может показаться, что человек явно манипулирует или настроен оппозиционно.
- Последствия: кратковременное облегчение (отсутствие неотложных задач), чувство восстановления контроля. Долгосрочные последствия - задачи остаются невыполненными, и тревога может усилиться, усиливая цикл избегания.

Мелтдаун: КПТ стратегии

- Психообразование: объясните эмоциональную чувствительность, связанную с РДВГ. Помогите клиенту распознать ранние признаки приступа (например, мышечное напряжение, учащенное сердцебиение). Понимание того, что РДВГ провоцирует интенсивные реакции, может уменьшить чувство стыда.
- Когнитивная реструктуризация: выявите катастрофические или черно-белые мысли, подпитывающие вспышку гнева (например, “Я всегда все порчу”, “Они должны знать, что я стараюсь”). Бросьте вызов и замените его реалистичными альтернативами (“У меня сейчас трудные времена, но я могу воспользоваться перерывом или попросить о помощи”). Это может предотвратить эскалацию конфликта.
- Маркировка и масштабирование эмоций: научите клиента использовать такие инструменты, как “Термометр чувств” (оценка гнева от 1 до 10), чтобы сделать паузу и заметить нарастающие эмоции. Научите клиентов выражать словами то, что они чувствуют (разочарование, обиду, страх), что задействует когнитивный контроль.



- Навыки релаксации/стрессоустойчивости: учите клиента практиковать глубокое дыхание, постепенное расслабление мышц или заземление (фокусируясь на сенсорном восприятии) во время сессии и после него. В моменты сильного стресса предложите клиенту выполнить упражнение "СТОП" (остановиться, перевести дыхание, понаблюдать за чувствами, отстраниться (от ситуации), действовать осознанно). Эти техники прерывают всплеск гнева.
- Поведенческие техники: ролевая игра или разработка сценариев для работы с триггерами. Например, научите клиента немедленно уходить в себя (брать тайм-аут в тихом месте), когда эмоции достигают установленного порога, вместо того, чтобы выплескивать их наружу. Такая пауза для “остывания” предотвращает полный срыв.

- Умение справляться с ситуацией в реальном времени: поощряйте использование успокаивающих высказываний во время гнева (например, “Теперь я могу сделать паузу”) или противоположных действий (делайте что-нибудь успокаивающее, когда вы сердитесь, например, включайте тихую музыку). Моделирование этих процессов во время сеанса помогает клиенту учиться.
- Закрепляйте успех: хвалите и/или вознаграждайте за любое сокращение вспышек гнева. Даже небольшие успехи (например, “я разозлился, но ушел”) следует признавать, чтобы повысить уверенность в себе.



Шатдаун: КПТ стратегии

- Нормализация и сострадание: подтвердите, что шатдауны - это понятный способ преодоления (мозг защищает себя). Подчеркните, что это не болезнь, а защита. Поощряйте заявления о сострадании к себе.
- Когнитивная реструктуризация: учите клиента бросать вызов мыслям типа “Я беспомощен” или “я всегда терплю неудачу”. Используйте сократовские вопросы (“Каковы доказательства того, что ”всегда“?”), чтобы сформировать реалистичные убеждения (например, “Я уже делал трудные вещи раньше, теперь я могу попробовать сделать небольшие шаги”).
- Активизация поведения: составьте ежедневное расписание, включающее даже небольшие приятные занятия (хобби, физические упражнения, общение). Это разрушит порочный круг инерции. Даже короткая прогулка или прослушивание любимой музыки могут активизировать работу системы.

- Поэтапное начало выполнения задания: используйте такие методы, как правило 5 минут: посвятите работе над сложной задачей всего 5 минут. Исследования показывают, что как только мозг человека с РДВГ приступает к выполнению задания, за ним часто следует импульс. Постепенно увеличивайте время по мере роста уверенности.
- Разбивка задач: разбейте большие задачи на маленькие конкретные шаги с помощью наглядных контрольных списков. Выполнение каждого мини-шага дает ощущение достижения и уменьшает паралич.
- Поддержка окружающей среды: устраняйте отвлекающие факторы. Поддерживайте порядок в рабочем пространстве. Используйте таймеры или приложения для запуска и перерывов.
- Разработка рутины: создайте последовательный распорядок дня (одинаковые пробуждения, рабочие блоки, перерывы), который снизит нагрузку на принятие решений, которые могут привести к отключению. Структура успокаивает.



КПТ СДВГ

- Домашнее задание: проведите небольшие поведенческие эксперименты, например, клиент пробует одну кратковременную ситуацию, вызывающую отключение, с помощью плана преодоления (уходит или выполняет 5-минутное задание) и отмечает результат.
- Подкрепление: положительная обратная связь при любом повторном участии имеет значение. Например, если клиент приступил к выполнению задания, несмотря на то, что чувствовал себя подавленным, вознаградите его за усилия (самостоятельно выбранное вознаграждение или похвала). Это создает цикл поведенческой активации.

ПИТ: КПТ стратегии

- Уменьшите предполагаемую угрозу: формулируйте просьбы мягко. Вместо команд используйте приглашения или язык сотрудничества: “Мы могли бы попробовать сделать то-то и то-то вместе” или “Вы хотели бы справиться с задачей X или задачей Y?”, чтобы создать ощущение контроля.
- Предлагайте выбор: по возможности, позвольте клиенту выбирать, как и когда удовлетворять его требования (два разумных варианта). Такая автономия может уменьшить беспокойство, которое провоцирует избегание.
- Когнитивные стратегии: обращайтесь к жестким мыслям (“Они не могут меня заставить”, “Это все испортит”) с помощью гибкого мышления. Рационально рассмотрите наихудший сценарий (“Даже если это будет трудно, я смогу справиться с некоторыми из них”).

- План "если-то": используйте намерения по реализации для борьбы с циклом избегания с положительной валентностью. Например: “Если я почувствую, что хочу избежать выполнения задачи (тогда) я займусь этим всего на 5 минут”. Наличие заранее разработанного плана (с небольшими шагами) разрушает замкнутый круг избегания.
- Постепенное воздействие: начните с очень небольших, не представляющих угрозы требований. Например, сначала скажите клиенту выполнить одноминутную рутинную работу и вознаградить себя. Постепенно увеличивайте сложность/продолжительность требований, чтобы выработать терпимость.
- Положительное подкрепление: увеличивайте вознаграждение за выполнение заданий. Это может быть угощение, свободное время или похвала.



КПТ СДВГ

- Управление тревогой: поскольку тревога способствует избеганию требований, учите клиента расслаблению/осознанности и поощряйте хороший сон, физические упражнения и употребление меньшего количества кофеина. Более спокойная обстановка делает требования менее угрожающими.
- Совместная работа по решению проблем: на занятии проработайте реальную проблему спроса. Проведите совместный мозговой штурм решения (например, как разбить большую задачу на части). Вовлечение клиента в планирование повышает заинтересованность.
- Устанавливайте четкие границы: проявляя гибкость, соблюдайте и постоянные ограничения. Используйте “примирительное рукопожатие” – договаривайтесь о реалистичных требованиях и способах преодоления (например, “я попрошу сделать перерыв через 20 минут”).
- Психообразование о ПИТ: объясните концепцию избегания, вызванного тревогой (а не “непослушания”). Понимание того, что в основе стремления к бегству лежит страх, может уменьшить чувство самообвинения.



Работа с сопротивлением

Взрослые с РДВГ часто проявляют характерное для терапии поведение сопротивления, которое может препятствовать прогрессу. Распространенные паттерны включают в себя:

- **Избегание:** клиент может уклоняться от обсуждения сложных тем или откладывать выполнение домашних заданий по терапии и согласованных задач. Это может проявляться в хроническом запаздывании с началом выполнения задач или в повторяющихся словах “Я сделаю это позже”, что приводит к незавершению задачи и ее невыполнению.
- **Отклонение от темы:** когда возникает чувство дискомфорта или ответственности, клиент может сменить тему, пошутить или увести разговор в сторону от себя. Эта схема помогает избежать пристального внимания или эмоционального дискомфорта.

- Пропущенные сеансы и опоздания: взрослые с РДВГ часто пропускают встречи или опаздывают на них. Терапевты сообщают о более высокой частоте срывов назначений (“нарушенных соглашений”) среди взрослых с РДВГ. Эти неявки часто интерпретируются как сопротивление, но могут быть вызваны забывчивостью или плохим управлением временем, а не отсутствием интереса.
- Чрезмерная интеллектуализация: некоторые клиенты прибегают к аналитическим или абстрактным разговорам, сосредотачиваясь на теориях, внешних деталях или второстепенных вопросах, чтобы избежать обсуждения своего собственного поведения или чувств. Переходя в режим “лекции” или обсуждения концепций, клиент отвлекает внимание от личных трудностей.

- Эмоциональная замкнутость: сталкиваясь с эмоционально заряженными темами или отзывами, клиент может замкнуться или замолчать. Эта замкнутость может включать в себя отстраненность, односложные ответы или заметное сглаживание аффекта. Это защитная форма избегания, позволяющая избежать чувства подавленности или стыда.
- Конфронтация: иногда клиент может начать спорить или защищаться, оспаривая предложения терапевта (“Да, но...”) или полностью отвергая вмешательство. Эта оппозиционная позиция может проявляться в виде гнева или раздражения, направленных на терапевта или сам процесс терапии, что приводит к тупиковой ситуации.



КПТ СДВГ

Функциональный анализ

С точки зрения КПТ, сопротивление – это не просто упрямство, оно часто служит функциональной цели клиента. При РДВГ у взрослых такое устойчивое поведение часто коренится в основных симптомах и эмоциональных переживаниях, связанных с расстройством. Понимание того, что стоит за сопротивлением, может способствовать эффективному вмешательству.

- Исполнительная дисфункция: связанные с РДВГ нарушения в организации, памяти и саморегуляции способствуют поведению, которое выглядит как “сопротивление”. Например, плохая рабочая память и способность планировать могут привести к забыванию домашних заданий или пропуску занятий. По сути, “нарушенные соглашения” являются результатом дисфункции – клиент намеревается выполнить их, но не может инициировать или запомнить задачи. То, что выглядит как избегание, может быть неспособностью удерживать внимание и следовать своим намерениям. Слабые исполнительные функции означают, что человек “не понимает, что нужно делать, и поэтому не делает этого”. Это когнитивное препятствие может проявляться в виде хронической прокрастинации и кажущейся ненадежности, а не в умышленном отказе.

- Эмоциональная реактивность: взрослые с РДВГ часто борются с эмоциональной импульсивностью и плохой регуляцией эмоций. Они могут слишком остро реагировать на предполагаемую критику или трудности в терапии. Мягкое внушение может вызвать непропорциональный гнев, а незначительная неудача - сильное разочарование. Такая повышенная реактивность связана с чувствительностью к отвержению – отрицательная обратная связь (или даже нейтральная обратная связь) может восприниматься как личное неприятие. Некоторые клиенты могут вспыхнуть от гнева, когда их критикуют, в то время как другие очень расстраиваются или резко уходят, когда чувствуют себя подавленными. Таким образом, конфронтационная позиция в терапии может быть защитой от обиды; легче спорить или бросаться наутек, чем сидеть с чувством неадекватности. Эмоциональная дисрегуляция также может привести к борьбе, бегству или остановке реакции во время сеанса (например, к спорам, избеганию или эмоциональному замыканию).

- Стыд и стремление защищаться: многие взрослые с РДВГ несут тяжелое бремя стыда из-за многолетних негативных отзывов, неудач и ощущения, что они “недостаточно хороши”. Со временем у них может развиться глубоко укоренившийся страх подвергнуться критике или осуждению. В психотерапии это может проявляться как защитное поведение: оправдание ошибок, обвинение внешних факторов или отрицание важности целей. Примечательно, что стыд часто проявляется в виде гнева, защитной реакции или склонности к избеганию или замкнутости. Клиент может казаться сопротивляющимся, но внутренне он защищает хрупкое самоощущение. Например, если терапевт спрашивает о незаконченном домашнем задании, клиент может уклониться (“Это задание все равно было бессмысленным”) или стать угрюмым и молчаливым – реакция, вызванная стыдом за то, что он его не выполнил. Взрослые с РДВГ могут возмущаться терапевтическими структурами или советами, интерпретируя их как критику или покровительство. Такая защитная реакция, по сути, является механизмом самозащиты, позволяющим избежать дальнейшего стыда.

- Страх неудачи (низкая самооффективность): взрослые с РДВГ часто сталкиваются с хроническими неудачами и неуспеваемостью в школе, на работе или в отношениях. Такая история подрывает уверенность в себе. В результате клиент может сопротивляться выполнению терапевтических заданий из-за сильного страха снова потерпеть неудачу. В данном случае избегание - это форма самосаботажа, направленная на предотвращение боли от очередной неудачи. Парадоксально, но не пытаться выполнить задание безопаснее, чем пытаться и потерпеть неудачу – это сохраняет (временное) чувство компетентности. С годами эти повторяющиеся неудачи и негативная социальная обратная связь могут создать неадаптивные базовые убеждения (например, “Зачем беспокоиться, я просто все испорчу”), которые снижают мотивацию и усиливают поведение избегания. Таким образом, “сопротивление” клиента часто является амбивалентным: часть его хочет исправиться, но другая часть убеждена, что это бесполезно, или боится результата. Этот внутренний конфликт может привести к прокрастинации, непоследовательности или даже к прекращению терапии, если им умело не управлять.



Стратегии при сопротивлении

1. Совместное составление повестки сессии

С самого начала каждой сессии привлекайте клиента в качестве активного участника к составлению повестки дня. Это означает совместное принятие решения о том, на каких темах сосредоточиться и как провести время сессии. Вместо того чтобы диктовать план, спросите клиента: “Над какими проблемами или целями вы бы хотели, чтобы мы поработали сегодня?”. Поощряйте их расставлять приоритеты в своих проблемах. Например, терапевт может сказать: “Мы можем решить ваши трудности с планированием, а также конфликт на работе. Что кажется наиболее неотложным для решения в первую очередь, и сколько времени мы должны уделить каждому из них?”



Такое совместное формирование повестки дня служит нескольким целям:

- Оно расширяет возможности клиента и дает ему чувство контроля, уменьшая ощущение, что с ним разговаривают свысока. Клиенты лучше реагируют, когда к ним относятся как к равным партнерам.
- Это позволяет избежать отклонений, создавая четкую структуру для сессии. Если клиент склонен отклоняться от темы или рассуждать интеллектуально, согласованная повестка дня становится мягким якорем: “Это важно – может, мы примем это к сведению и вернемся позже, чтобы сначала обсудить то, что вы хотели обсудить?”
- Это укрепляет приверженность процессу терапии. Когда клиенты видят, что их приоритеты отражены в плане, они с большей готовностью следуют ему. Это может уменьшить пассивное сопротивление (например, уход от обсуждения или пропуск тем).
- Это моделирует организационную структуру – полезный навык при РДВГ. Терапевт и клиент практикуют разбиение сессии на управляемые части, отрабатывая навыки тайм-менеджмента, которые клиент может использовать вне занятий.



В начале каждого сеанса вместе составляйте краткий план действий. Отмечайте пункты по ходу работы. Если клиент поднимает кризисную или новую проблему в середине сессии, вы можете совместно принять решение о корректировке повестки дня (“Давайте выделим на это 10 минут сейчас и соответственно перенесем другие вопросы”). Такая гибкость в рамках структуры свидетельствует об уважении к потребностям клиента при сохранении целенаправленности.

Сохраняйте доброжелательный и любопытный тон. Если клиент настроен неохотно (“Я не знаю, о чем я хочу поговорить”), мягко направьте его, рассказав о недавних проблемах, о которых он упоминал. Например, “На прошлой неделе вы упомянули о неприятностях на работе; вы хотели бы, чтобы вам помогли с этим сегодня?” Избегайте контроля – повестка дня – это командный план, а не жесткий сценарий. Со временем активное вовлечение клиента в планирование каждой сессии повышает его вовлеченность и снижает сопротивление, поскольку он владеет процессом.



2. Когнитивная реструктуризация, направленная на сопротивление

Когнитивная реструктуризация - это основной инструмент КПТ, помогающий клиентам выявлять и изменять модели мышления, которые способствуют избеганию, защите или другим видам самосаботажного поведения. У взрослых с РДВГ часто возникают автоматические мысли типа “У меня всегда что-то не получается, так зачем пытаться?” или “Если я не могу сделать это идеально, я могу вообще этого не делать”. Эти представления напрямую подрывают мотивацию и приводят к прокрастинации и сопротивлению. Решение этих проблем может освободить клиента для более полного участия в терапевтических задачах.

Стратегия: поработайте с клиентом над выявлением, изучением и переосмыслением этих негативных мыслей:

- Во-первых, помогите клиенту выявить мысли, связанные с избеганием. Это может включать в себя анализ недавнего случая избегания. Например: клиент избегал заполнять журнал настроений; спросите: “Что приходило вам в голову, когда вы думали о том, чтобы вести журнал?” Они могут выдать такие мысли, как “Это слишком утомительно” или “Это все равно не поможет”.
- Затем используйте сократовский диалог и управляемое открытие, чтобы опровергнуть бесполезное убеждение. Проанализируйте доказательства: “Каковы доказательства того, что ведение журнала не поможет? Был ли у вас опыт, когда запись чего-либо давала некоторое представление?” Или проанализируйте логику: “Если задача кажется утомительной, обязательно ли это означает, что она не имеет ценности? Может быть, все же стоит заняться ею на короткое время, чтобы посмотреть, что получится?”

- Совместными усилиями сформулируйте более взвешенную мысль. Например, “Ведение журнала может быть утомительным занятием, но если я буду заниматься им всего несколько дней, то смогу заметить изменения в своем настроении. Мне не обязательно делать это идеально – любая информация может оказаться полезной”. Новая мысль должна признавать сложность, но также напоминать клиенту об его целях или предыдущих успехах (даже небольших).
- Свяжите когнитивный сдвиг с поведенческим экспериментом: предложите им протестировать новую точку зрения. Например, “Почему бы не попробовать в качестве эксперимента просмотреть журнал за эту неделю и посмотреть, не даст ли он какой-нибудь полезной информации? Мы можем просмотреть его вместе”.



КПТ СДВГ

Со временем когнитивные вмешательства нацелены на дисфункциональное мышление, которое способствует избеганию и прокрастинации. Перестраивая катастрофические или саморазрушительные мысли, терапевт помогает разорвать порочный круг, в котором негативные убеждения снижают мотивацию и усиливают поведение избегания. Например, трансформация “я неудачник, который не может измениться” в “раньше у меня были трудности, но с новыми стратегиями я мог бы совершенствоваться шаг за шагом” может подтолкнуть клиента к выполнению домашней работы, а не к уклонению от нее.



КПТ СДВГ

Применяя когнитивную реструктуризацию к клиенту с РДВГ, будьте нежны и поддерживайте его. Многие из его негативных мыслей основаны на болезненном опыте прошлого. Начните с сочувствия: “Вполне логично, что после стольких разочарований вы подумали: “Зачем беспокоиться?” Только после этого предложите им рассмотреть альтернативную точку зрения. Избегайте пренебрежительного отношения к их проблемам. Кроме того, делайте интервенции конкретными – абстрактные когнитивные дискуссии могут привести к большей интеллектуализации. Обосновывайте рефрейминг конкретными примерами из жизни клиента. Цель состоит в том, чтобы напрямую связать новое мышление с новыми действиями (например, преодолеть стремление избегать выполнения одной небольшой задачи). Даже незначительный когнитивный сдвиг может уменьшить сопротивление, ослабив ментальные барьеры, которые говорят: “бесполезно пытаться”.



КПТ СДВГ

3. Методы повышения мотивации

Когда клиент проявляет двойственное отношение или нежелание к терапевтическим мероприятиям, методы, основанные на повышении мотивации, могут быть очень эффективными. Эти подходы, которые часто ассоциируются с мотивационным интервьюированием (МИ), совместимы с КПТ и направлены на разрешение противоречий и укрепление мотивации клиента к переменам. Две полезные стратегии - это сбалансированность принятия решений и согласование ценностей:

- Взвешенность принятия решений: этот метод позволяет клиенту открыто взвесить все "за" и "против" изменения или сохранения прежней позиции. Если клиент сопротивляется определенным изменениям, терапевт помогает ему четко сформулировать, что ему нравится в существующем положении вещей (например, “Мне не нужно прилагать усилий”, “Я могу избежать встречи с неудачей”) и что это не очень хорошо (“Я постоянно пропускаю сроки”, “Я чувствую, что теряю контроль”). Затем проделайте то же самое с переменами: преимущества перемен (“Я бы меньше нервничал, если бы был организованным”) и недостатки или страхи перемен (“Это может быть трудно; я могу потерпеть неудачу”). Если записать все это в простую таблицу из двух столбцов, то можно наглядно представить себе амбивалентность.

- **Согласование ценностей:** изучите основные ценности и личные цели клиента и соотнесите их с задачами терапии. Взрослые с РДВГ часто придерживаются высоких ценностей (например, быть хорошим родителем, проявлять творческий подход, помогать другим), но симптомы могут сбить их с правильного пути. Четко связывая терапевтическую работу с тем, что для них важнее всего, вы создаете мощный внутренний мотиватор. Например, если клиент высоко ценит семью, сформулируйте развитие навыков с точки зрения этой ценности: “Вы упомянули о желании быть более надежным для своих детей. Как, по-вашему, работа над своим тайм-менеджментом может способствовать достижению этой цели?” Или клиент, который ценит карьерный успех, может быть более мотивирован использовать планировщик, если это связано с его мечтой начать бизнес. Согласование ценностей переосмысливает приверженность терапии не как “следование указаниям терапевта”, а как действие, направленное на реализацию собственного видения жизни клиента.



КПТ СДВГ

Если клиент выражает нежелание (“Я действительно не понимаю, как выполнение этого упражнения поможет мне”), не поддавайтесь желанию спорить или убеждать. Вместо этого используйте рефлексивное слушание: “Вы не уверены, что это что-то изменит. Это понятно.” Затем, возможно, мягко спросите: “Как вы думаете, что могло бы помочь, учитывая ваши цели?” Мотивационные стратегии лучше всего работают в атмосфере непредвзятости и ориентации на клиента. Думайте о себе как о руководителе, помогающем клиенту разобраться в своих собственных мотивах, а не как о авторитетной фигуре, навязывающей правила. Повышая мотивацию таким чутким способом, многие сопротивляющиеся клиенты начинают охотнее экспериментировать с инструментами КПТ, которых они раньше избегали.



4. Подсвечиваем микро-успехи и прогресс

- Поймайте их на том, что они делают что-то правильно. На каждой сессии активно спрашивайте о прогрессе или усилиях, предпринятых с момента последней встречи. Например: “На прошлой неделе мы планировали, что вы попробуете использовать список задач дважды. Как все прошло?” Если клиент сообщает о хотя бы частичном успехе (“Я справлялся с этим один раз из двух”), проявите неподдельный энтузиазм по поводу его усилий: “Это здорово – однажды вы попробовали это! Расскажите мне, как вам это удалось”. Это смещает акцент с недостатков на достижения.



КПТ СДВГ

- Хвалите конкретно и искренне. Расплывчатая похвала ("Хорошая работа") менее эффективна. Вместо этого выделите конкретные действия: "Я впечатлен тем, что, несмотря на трудности, вы заполнили ежедневник в понедельник. Это свидетельствует о решимости". Убедитесь, что похвала искренняя; взрослые могут почувствовать покровительственный тон. Найдите в ней положительные стороны, такие как настойчивость, креативность или понимание, которого они достигли.



КПТ СДВГ

- Укрепляйте процесс, а не только результаты. Для людей с РДВГ, которым часто не удается достичь значительных результатов, признание процесса (усилий, использования стратегии) является мотивирующим фактором. Например: “Вы выполнили только часть проекта, но подошли к нему с разбивкой на части – это новый подход, и он сработал лучше, чем раньше”. Таким образом, даже если конечная цель еще не достигнута в полной мере, клиент все равно испытывает чувство удовлетворения от совершенствования своего метода.

- Документируйте и отражайте прогресс. Подумайте о том, чтобы вести “журнал успехов” или текущий список (возможно, на доске во время занятий или в общем журнале), куда вы записываете любые положительные моменты: “посетили 3 занятия подряд”, “внедрили 2 новых навыка преодоления трудностей”, “завершили один модуль рабочей тетради” и т.д. Периодически просматривайте этот список вместе с клиентом. Наблюдение за растущим списком успехов, какими бы незначительными они ни были, борется с негативным представлением о себе как о человеке, который “никогда ничего не делает правильно”. Это подкрепляет альтернативную версию: прогресс происходит.



5. Стратегии для предотвращения дроп-аута

Взрослые с РДВГ подвержены риску преждевременного прекращения терапии или несоблюдения планов лечения. Высокий уровень дроп-аута (в исследованиях часто 25-50%) отражает трудности с поддержанием вовлеченности в процесс, когда проявляются импульсивность, забывчивость или деморализация.

Чтобы противостоять этому, КПТ включает в себя методы поведенческого планирования, которые делают обязательства четкими и конкретными. Двумя эффективными методами являются планирование "если-то" и поведенческие контракты.



- Планирование "Если-то" (Намерения по реализации): этот метод помогает воплотить благие намерения в действие, заранее планируя меры реагирования на ожидаемые препятствия. Вместе с клиентом разработайте конкретные планы “ЕСЛИ X, ТО Y” для ситуаций, в которых вероятно сопротивление или несоблюдение требований. По сути, вы помогаете клиенту мысленно подсказать, что делать в случае возникновения проблемы, чтобы, когда это произойдет, решение было уже принято.

- Поведенческий контракт: это письменное соглашение между клиентом и терапевтом, в котором излагаются обязательства клиента, такие как посещение, выполнение упражнений или других терапевтических мероприятий, а также последующая поддержка или последствия. Сам процесс составления контракта повышает чувство ответственности клиента и серьезность его обязательств.

Для взрослого с СДВГ контракт может включать такие детали, как:

- Обязательство о посещении: например, “Я приду как минимум на 8 из следующих 10 занятий. Если мне нужно будет что-то отменить, я сделаю это за 24 часа и незамедлительно перенесу встречу”.
- Цели на период между сессиями: например, “Я согласен использовать предписанную стратегию организации не менее 15 минут в день, 5 дней в неделю, и отслеживать свои усилия для обсуждения на сессии”.
- Поддержка и последствия: например, “Если я выполню свои еженедельные задачи, то в субботу вознагражу себя часом игры без чувства вины. Если я постоянно не буду доводить дело до конца, я поговорю со своим психотерапевтом о привлечении ответственного партнера или переоценке своей готовности к этим переменам”.



КПТ СДВГ

ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕМУ



КПТ СДВГ

Заключительная часть терапии - подготовка к будущему - чрезвычайно важна, поскольку она предполагает переход от решения проблем к более позитивной позиции, включающей оптимизацию сильных сторон клиента и их применение в будущем. Тем не менее важно помнить, что окончание лечения всегда бывает трудным. Предполагается, что заключительные сессии терапии обеспечивают прагматичный обзор того, что было изучено, но также признают и обрабатывают эмоциональный путь, пройденный клиентом. Этот этап включает в себя размышления о будущем, повышение самооценки, анализ достижений и обдумывание того, как максимизировать их в будущем, чтобы способствовать здоровому психическому функционированию и инструментальному успеху.



КПТ СДВГ

Следует подчеркнуть и усилить когнитивно-поведенческие техники, которые были эффективны в терапии. Повышение самооценки является неявной темой в рамках терапии, но в конце лечения это становится более явным благодаря внедрению специальных методов, позволяющих привлечь внимание к прошлым успехам и достижениям и повысить уверенность в будущих результатах и самоэффективности. Наконец, терапевт должен вовлечь клиента в процесс передачи эмоционального и практического опыта, включая обращение за помощью к друзьям, семье, а иногда и к услугам других специалистов.



КПТ СДВГ

Прекращение терапии включает в себя три этапа:

1. Анализ динамики РДВГ и ожидания клиентов от будущего
2. Анализ прошлых достижений и успехов во время лечения с целью повышения самооценки
3. Внедрение доступа к социальной поддержке вне терапевтической среды



Анализ динамики РДВГ и ожидания клиентов от будущего

Различные симптомы при РДВГ уменьшаются с разной скоростью. Течение расстройства обычно включает в себя сначала уменьшение гиперактивности, за которым следует импульсивность. Невнимательность является наиболее заметным симптомом, сохраняющимся во взрослом возрасте. Однако, даже когда у людей нет полного набора симптомов или они не соответствуют критериям для постановки диагноза, у многих клиентов остаются частичные симптомы.



Существует 3 основных фактора, которые определяют степень, в которой симптомы будут вызывать функциональные проблемы:

1. Биологические изменения непосредственно влияют на симптомы
2. Изменение окружающей среды, например, способность изменять окружающую среду вокруг себя таким образом, чтобы уменьшить возникающие трудности
3. Психологические стратегии преодоления, например, когда человек осознает, как симптомы влияют на него, и разрабатывает внутренние методы управления симптомами



Анализ прошлых достижений и успехов во время лечения с целью повышения самооценки

Успехи часто недооцениваются людьми с РДВГ. Последствия поздней диагностики во взрослом возрасте заключаются в том, что человек жил и справлялся (либо функционально, либо дисфункционально) со своими симптомами и связанными с ними проблемами в течение очень долгого времени. Таким образом, у взрослых с РДВГ, вероятно, будет другой спектр проблем по сравнению с людьми, которым ставили диагноз и лечили с детства.

Взрослым с РДВГ часто требуется помощь в переоценке своего места в жизни, своих навыков, умений и возможностей. Как только они определятся с тем, что они хотят делать, им понадобится поддержка, чтобы ставить одну ногу впереди другой и делать первые шаги к своим целям.



КПТ СДВГ

У людей с РДВГ есть много сильных сторон, на которые можно опереться. Они часто являются творческими, артистичными, остроумными и занимательными личностями. Наиболее важным способом продвижения вперед является определение области знаний, в которой они могут достичь успехов, используя свои специализированные навыки. Часто это происходит в форме творчества, такой как искусство, дизайн и/или музыка, но также может быть более практичной, например, навыки работы с компьютером. Такие сильные стороны РДВГ можно рассматривать как "островки совершенства", которые формируют основу фундаментального оптимизма и веры в себя. Такие характеристики являются важными катализаторами процесса жизнестойкости.



КПТ СДВГ

Жизнестойкость - это фактор, который помогает людям с РДВГ придерживаться выбранного курса. Негативное самореализующееся пророчество может сбыться на короткое время, когда жизнь кажется плохой и кажется, что ничего не получается, но затем включается устойчивость. Это может произойти из-за жесткого упрямства, отказывающегося идти навстречу отчаянию или неудаче. С другой стороны, это может быть результатом процесса альтернативного мышления, порожденного природной креативностью, оптимизмом и интересом к новым и захватывающим возможностям.



1. Обзор жизненных достижений

Чтобы мотивировать клиента с РДВГ определять цели и стремиться реализовать свой потенциал в будущем, необходимо проанализировать прошлые достижения и успехи. Важно выделить сильные стороны человека и подчеркнуть, что у него все хорошо получается. Часто люди с РДВГ лучше осведомлены о своих слабостях и о том, что у них получается хуже.

Например, в качестве упражнения мы можем попросить клиента перечислить 10 своих достижений. Затем перечислить 5 целей, которые он бы хотел достичь в следующем году.



2. Обзор успешных стратегий

В ходе терапии клиент опробует различные стратегии для улучшения симптомов в нескольких функциональных областях. Эти стратегии будут реализованы с разной степенью успеха. Терапевт должен проанализировать методы, которые были применены в ходе лечения, и оценить их полезность. Это, конечно, может также включать стратегии, которые клиент разработал самостоятельно и которые привели к положительному (или отрицательному) результату. Упражнение, приведенное далее, предназначено для того, чтобы напомнить как терапевту, так и клиенту о том, какие техники были протестированы и насколько хорошо они сработали. Оно также предоставит клиенту список полезных стратегий для использования, когда терапия будет прекращена. Этим стратегиям следует присвоить оценку от 0 (совсем бесполезно) до 10 (чрезвычайно полезно).



Поддержка

Долгосрочная проблема для людей с РДВГ заключается в том, что они сталкиваются с многочисленными трудностями в развитии и поддержании отношений. Участвуя в терапии, клиент, возможно, впервые сталкивается с отношениями, в которых он чувствует, что ему конструктивно помогли. Таким образом, прекращение этих терапевтических отношений, вероятно, будет трудным и приведет к первоначальному снижению самооценки, сопровождающемуся чувством неспособности справиться. Поэтому важно потратить время на подготовку пациента к окончанию терапии путем разработки комплексного плана "профилактики рецидивов", который предоставит клиенту множество вариантов преодоления последствий прекращения терапии. Заключительный шаг - обсудить способы привлечения помощи и поддержки со стороны семьи, друзей и/или других специалистов.